



Optimal
Untuk
Negeri



optimal

Bunga Rampai

PENDEKATAN HOLISTIK DAN HUMANISTIK

DALAM PELAYANAN KESEHATAN



Dhea Novita • Erwin Purwanto • Aini Alifatin
Dewi Mey Lestanti Mukodri • Atik Badi'ah • Hanafi

Editor : Baltasar Serilus Sanggu Dedu

BUNGA RAMPAI: PENDEKATAN HOLISTIK DAN HUMANISTIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Penulis:

Dhea Novita, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb

Erwin Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kep

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.

Dewi Mey Lestanti Mukodri, SST., M.Keb

Dr. Atik Badi'ah, S.Pd., S.Kp., M.Kes

Ns. Hanafi, M.Kep

Editor:

Baltasar Serilus Sanggu Dedu, S.Kep., M.Sc



**Optimal
Untuk
Negeri**

Bunga Rampai: Pendekatan Holistik dan Humanistik dalam Pelayanan Kesehatan

Penulis:

Dhea Novita, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb
Erwin Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kep
Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.
Dewi Mey Lestanti Mukodri, SST., M.Keb
Dr. Atik Badi'ah, S.Pd., S.Kp., M.Kes
Ns. Hanafi, M.Kep

Editor:

Baltasar Serilus Sanggu Dedu, S.Kep., M.Sc

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Helmi Syaukani, S.Pd.

ISBN: 978-634-7556-80-6

Cetakan Pertama: Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya bunga rampai *"Pendekatan Holistik dan Humanistik dalam Pelayanan Kesehatan"* ini dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca. Buku ini disusun sebagai upaya memperkaya khazanah pemikiran dan praktik pelayanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pada pemahaman manusia secara utuh—sebagai individu dengan dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan membawa kemajuan besar dalam diagnosis dan terapi. Namun, di sisi lain, dinamika pelayanan yang semakin cepat dan kompleks kerap berisiko menggeser esensi pelayanan kesehatan yang sejatinya berpusat pada manusia. Karena itu, pendekatan holistik dan humanistik menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa setiap interaksi pelayanan tetap menjunjung martabat pasien, memperhatikan kebutuhan menyeluruhnya, serta menguatkan hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien.

Bunga rampai ini memuat berbagai topik yang saling melengkapi dan merepresentasikan pentingnya pelayanan yang utuh dan bermakna. Pembahasan diawali dengan konsep pelayanan kesehatan holistik dan humanistik sebagai landasan filosofis dan praktis dalam pelayanan. Selanjutnya, buku ini menguraikan pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual dalam asuhan kesehatan, yang menegaskan bahwa kondisi kesehatan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait. Dalam ranah praktik, buku ini menghadirkan kajian tentang asuhan keperawatan holistik dalam berbagai tatanan pelayanan, yang menunjukkan penerapan pendekatan holistik dalam konteks klinis, komunitas, maupun pelayanan berkelanjutan.

Selain itu, buku ini juga menyoroti pendekatan gizi holistik dalam pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, yang memandang gizi bukan semata pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi bagian dari strategi pemulihan menyeluruh dan peningkatan kualitas hidup. Aspek relasional dalam pelayanan diperkuat melalui pembahasan komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien, sebagai kunci membangun kepercayaan, meningkatkan kepatuhan, dan memastikan keputusan klinis yang lebih partisipatif. Tidak kalah penting, buku ini mengangkat nilai-nilai inti pelayanan melalui topik etika, empati, dan nilai kemanusiaan dalam praktik pelayanan kesehatan, yang menjadi fondasi moral sekaligus penuntun sikap profesional tenaga kesehatan. Pada bagian akhir, pembaca diajak memahami realitas lapangan melalui pembahasan tantangan penerapan pelayanan holistik di fasilitas kesehatan, termasuk kendala

sistem, budaya organisasi, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan penguatan kompetensi dan kolaborasi lintas profesi.

Kami menyadari bahwa penyusunan bunga rampai ini tidak lepas dari keterbatasan. Namun, besar harapan kami buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, pengelola fasilitas pelayanan, serta para pemangku kebijakan. Semoga buku ini turut mendorong lahirnya praktik pelayanan kesehatan yang lebih berkeadilan, berempati, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan pasien secara menyeluruh.

Maret 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP PELAYANAN KESEHATAN HOLISTIK DAN HUMANISTIK..... 1

Dhea Novita, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.....	1
A. Pendahuluan/Prolog.....	1
B. Konsep Holistic Care.....	2
C. Konsep Holisme.....	4
D. Konsep Humanisme.....	4
E. Kedudukan Pengasuhan dalam Teori Humanisme.....	7
F. Implementasi Pelayanan Holistik-Humanistik dalam Praktik Kebidanan.....	8
G. Tantangan Penerapan Pelayanan Holistik-Humanistik.....	9
H. Urgensi Pelayanan Holistik-Humanistik di Era Transformasi Kesehatan.....	10
I. Model Konseptual Pelayanan Kebidanan Holistik-Humanistik.....	10
J. Perbandingan Pendekatan Biomedis dan Holistik.....	10
K. Refleksi Profesionalisme Bidan.....	11
L. Implikasi bagi Pendidikan Kebidanan.....	11
M. Pertanyaan Reflektif untuk Mahasiswa.....	11
N. Simpulan.....	11
O. Referensi.....	12
P. Glosarium.....	13

CHAPTER 2 PENDEKATAN BIO-PSIKO-SOSIAL-SPRITUAL DALAM ASUHAN KESEHATAN..... 15

Erwin Purwanto, S.Kep., Ners., M.Kep.....	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Konsep Pendekatan Bio-Psiko-Sosial-Spiritual.....	16
C. Aspek Biologis dalam Asuhan Kesehatan.....	18
D. Aspek Psikologis dalam Asuhan Kesehatan.....	21
E. Aspek Sosial dalam Asuhan Kesehatan.....	24
F. Aspek Spiritual dalam Asuhan Kesehatan.....	25
G. Integrasi dan Implementasi Pendekatan Bio-Psiko-Sosial-Spiritual dalam Asuhan Kesehatan.....	28
H. Simpulan.....	30
I. Referensi.....	31

CHAPTER 3 ASUHAN KEPERAWATAN HOLISTIK DALAM BERBAGAI TATANAN PELAYANAN.....35

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.....	35
A. Pendahuluan.....	35
B. Konsep dan Prinsip Asuhan Keperawatan Holistik.....	37
C. Proses Keperawatan dalam Pendekatan Holistik.....	41
D. Asuhan Keperawatan Holistik dalam Berbagai Tata Layan.....	43
E. Peran dan Kompetensi Perawat dalam Asuhan Keperawatan Holistik.....	45
F. Tantangan dan Penguatan Implementasi Asuhan Keperawatan Holistik.....	49
G. Penutup.....	50
H. Daftar Pustaka.....	50
I. Glosarium.....	51

CHAPTER 4 PENDEKATAN GIZI HOLISTIK DALAM PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN54

Dewi Mey Lestanti Mukodri, SST., M.Keb.	54
A. Pendahuluan.....	54
B. Landasan Teori Dan Kerangka Konseptual.....	55
C. Mekanisme Biologis Dalam Pemeliharaan Kesehatan.....	55
D. Gizi Holistik Dalam Pemulihan Kesehatan.....	56
E. Implementasi di Indonesia.....	56
F. Simpulan.....	56
G. Referensi.....	57
H. Glosarium.....	59

CHAPTER 5 KOMUNIKASI EFEKTIF ANTARA TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN.....61

Dr. Atik Badi'ah, S.Pd., M.Kes.....	61
A. Landasan Filosofis dan Konseptual.....	61
B. Konsep Dan Prinsip Komunikasi Efektif.....	66
C. Komponen Komunikasi Terapeutik.....	70
D. Hambatan komunikasi dalam pelayanan kesehatan.....	71
E. Implementasi di Rumah Sakit.....	72
F. Implementasi di Puskesmas.....	72
G. Evaluasi dan indikator keberhasilan Indikator komunikasi efektif:.....	73
H. Peran Perawat Dalam Komunikasi Efektif Antara Tenaga Kesehatan Dan Pasien.....	73
I. Kesimpulan.....	77
J. Referensi.....	78

CHAPTER 6 ETIKA, EMPATI, DAN NILAI KEMANUSIAAN DALAM PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN 79

Aini Alifatin, S.KP., M.Kep.....	79
A. Pendahuluan.....	79
B. Landasan Konseptual Etika dalam Pelayanan Kesehatan.....	82
C. Empati sebagai Kompetensi Inti Pelayanan Kesehatan	86
D. Nilai Kemanusiaan dan Martabat dalam Praktik Pelayanan Kesehatan.....	88
E. Integrasi Etika, Empati, dan Nilai Kemanusiaan dalam Praktik Pelayanan Kesehatan	91
F. Tantangan dan Dilema Etis dalam Pelayanan Kesehatan kontemporer.	93
G. Transformasi Pelayanan Kesehatan Menuju Pendekatan Holistik dan Humanistik	95
H. Penutup	97
I. Referensi	98

CHAPTER 7 TANTANGAN PENERAPAN PELAYANAN HOLISTIK DI FASILITAS KESEHATAN 101

Hanafi, S.Kep., Ns., M.Kep.....	101
A. Pendahuluan.....	101
B. Ruang Lingkup Pelayanan Holistik.....	101
C. Nilai Utama dalam Pelayanan Holistik	103
D. Tantangan Pelayanan Holistik.....	104
E. Kesimpulan.....	106
F. Daftar Pustaka.....	107

PROFIL PENULIS 109

CHAPTER 1

KONSEP PELAYANAN KESEHATAN HOLISTIK DAN HUMANISTIK

Dhea Novita, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb

A. Pendahuluan/Prolog

Holistik dalam kebidanan diperlukan suatu perubahan cara pikir masyarakat dan jenis pelayanan kesehatan yang ada didalamnya. Karena perubahan ini merupakan suatu proses terjadinya perpindahan dari status tetap menjadi yang bersifat dinamis, yaitu dapat menyesuaikan diri dari lingkungan yang ada untuk mencapai kesehatan yang optimal. Holistik merupakan suatu yang mendasari tindakan kebidanan seperti dimensi fisiologis, psikologis, sosiokultural, dan spiritual. Dimensi ini merupakan suatu kesatuan yang utuh. Holistik terkait dengan kesejahteraan terdapat dimensi yang saling mempengaruhi seperti fisik, emosional, intelektual, sosial dan spiritual. (Dossey & Keegan, 2016).

Di dalam pelayanan pada klinik holistik care didasarkan pada konsep kebidanan holistik yang meyakini bahwa penyakit yang dialami seseorang bukan saja merupakan suatu masalah fisik yang dapat diselesaikan dengan pemberian semata. Dan pelayanan kesehatan ini memperlihatkan keutuhan aspek kehidupan sebagai manusia yang meliputi kehidupan jasmani, mental, sosial, dan spiritual yang saling mempengaruhi.

Sebagai bidan materi yang sangat penting dan menentukan adalah memahami konsep caring, mampu menanamkan dalam hati, disirami, dipupuk untuk mampu memperlihatkan kemampuan soft skill sebagai bidan yaitu empati, bertanggung jawab dan tanggung gugat serta mampu belajar seumur hidup. Semua itu akan berhasil dicapai oleh perawat kalau mereka mampu memahami apa itu caring. Saat ini, caring adalah isu besar dalam profesionalisme kebidanan. Mata ajaran ini mendeskripsikan tentang kebidanan dasar dimana bidan akan mendalami konsep sebagai dasar ilmu kebidanan. Diharapkan bidan mampu memahami tentang pentingnya perilaku caring sebagai dasar yang harus dikuasai oleh bidan. Humanisme adalah upaya mengimplementasikan sikap dan tindakan yang sesuai prinsip-prinsip penghargaan dan penghormatan nilai - nilai kemanusiaan yang meliputi segala aspek kehidupan. (Watson, 2018).

B. Konsep Holistic Care

Holistic memiliki arti menyeluruh yang terdiri dari kata holy dan healthy. Pandangan holistik bermakna membangun manusia yang utuh dan sehat, dan seimbang terkait dengan seluruh aspek dalam pembelajaran; seperti spiritual, moral, imajinasi, intelektual, budaya, estetika, emosi, dan fisik. Jadi healthy yang dimaksud bukan hanya physically, tetapi lebih pada aspek sinergitas spiritual.

Pengobatan Holistic adalah, Pengobatan dengan menggunakan Konsep Menyeluruh, yaitu keterpaduan antara Jiwa dan raga, dengan method Alamiah yang ilmiah, serta ilahia yang mana Tubuh manusia merupakan keterpaduan system yang sangat Kompleks, dan saling berinteraksi satu sama lainnya dengan sangat kompak dan otomatis terganggunya satu fungsi/ elemen / unsure tubuh manusia dapat mempengaruhi fungsi dan lainnya. (Dossey & Keegan, 2016).

1. Sejarah Holistic care

Sejarah holistik dimulai sebelum istilah holism diperkenalkan oleh Jan Christiaan Smuts dalam bukunya "Holism and Evolution". Holisme saat ini berkembang dalam istilah holistik, yang mengkombinasikan penyembuhan, seni, dan ilmu hidup. Holistic populer dengan cepat di tahun 70an.

Walaupun istilah holisme diperkenalkan di tahun 1926, penyembuhan holistik sebenarnya sudah ada jauh di jaman kuno kira-kira 5000 tahun yang lalu. Sejarawan belum bisa memastikan dari bangsa manakah pertama kali ia dipraktekkan. Kebanyakan sejarawan percaya bahwa penyembuhan holistik dimulai di India dan atau Cina.

Para praktisi holistik mempraktekkan prinsip hidup sehat lewat menyeimbangkan tubuh, pikiran, dan roh untuk menyatu atau harmonis dengan alam.

Contoh praktis holistik adalah Socrates, yang hidup 4 abad sebelum kelahiran Kristus. Ia menganut pandangan ini dan mengajarkan bahwa kita harus memandang tubuh sebagai keseluruhan, bukannya bagian yang terpisah.

2. Nilai Utama Perawatan

- a. Filosofi dan Pendidikan, Menekankan bahwa asuhan yang holistik didasarkan pada suatu kerangka filosofi dan pengetahuan.
- b. Holistik Etik, Teori Keperawatan dan Riset, Menekankan bahwa asuhan yang professional didasarkan pada teori, diinformasikan oleh penelitian dan didasarkan oleh prinsip etik sebagai petunjuk praktek yang kompeten.
- c. Holistik Nurse Save Care. Keyakinan bahwa perawat harus terlibat dalam perawatan diri untuk meningkatkan kesehatan dan kesadaran pribadi sehingga

perawat dapat melayani orang lain sebagai suatu alat sebagai proses penyembuhan seseorang

- d. Holistic Communication, Therapeutic Environment and Cultural Competency Menekankan pada perkembangan untuk memanfaatkan penkajian dan asuhan terapeutik yang mengacu pada pola, masalah dan kebutuhan klien dan suatu lingkungan yang mendukung proses penyembuhan pasien. (Alligood, 2022).

3. Macam-macam cabang penyembuhan holistic

a. Holistic tradisional

Suatu teknik penyembuhan yang memanfaatkan alam dengan prinsip holisme, berawal sejak ribuan tahun lalu. Biasa disebut sebagai penyembuhan/pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional. Yang termasuk holistik tradisional adalah akupuntur, akupresur, herbal, ayurveda, urology, pranic healing, apitherapy, dan lain-lain. Gelar para praktisiya bermacam-macam. Ada yang disebut sebagai tabib, sin-se, dukun, dan lain-lain.

b. Holistic Modern

Suatu teknik penyembuhan yang menggabungkan penyembuhan tradisional/kuno dengan teknologi dan sains modern yang memanfaatkan alam dengan prinsip holisme. Holistic modern berawal sekitar 200 tahun yang lalu dengan adanya homeopathy.

Yang termasuk holistik modern adalah homeopathy, osteopathy, ananopathy, psikologi hipnotis, naturopathy modern, dan sebagainya

c. Holistic Modern Ananophaty

Ananopathy adalah gabungan teknik pengobatan alternatif tradisional/kuno dengan teknologi dan sains modern, dimana tujuannya adalah menyembuhkan, bukan sekedar merawat.

Pengobatan Ananopathy fokus pada akar penyakit, bukan pada gejala; merawat manusia secara keseluruhan (whole), bukan pada apa yang tampak saja. Tehnik yang digunakan adalah dengan menggunakan Hukum Alam, Hukum Sebab-Akibat, perbaikan pola makan dan gaya hidup, penggunaan bahan-bahan alami, yang diterapkan dengan basis alam dan sains modern.

4. Teknik Pengobatan dan Penerapan Holistic care

Pengobatan Holistic adalah, Pengobatan dengan menggunakan Konsep Menyeluruh, yaitu keterpaduan antara Jiwa dan raga, dengan method Alamiah yang ilmiah, serta ilahiah yang mana Tubuh manusia merupakan keterpaduan system yang sangat Kompleks, dan saling berinteraksi satu sama lainnya dengan sangat kompak dan otomatis terganggunya satu fungsi/ elemen / unsure tubuh manusia dapat mempengaruhi fungsi yang lainnya.

Metode Pengobatan Holistic yang di Kembangkan dengan Terapi

- a. Pengaturan Pola hidup dan Pola makan dengan gizi dan kebutuhan berimbang
- b. Rileksasi, dengan konsep Meditasi Penyembuhan
- c. Stimulasi Otak dengan tehnik perangsangan alamiah
- d. Silaturahmi Doktrin
- e. Pancaran Bio energy (Pranaisasi)

C. Konsep Holisme

Holistik adalah memandang manusia secara seutuhnya secara psikologis dan spiritual. Holisme menegaskan bahwa organisme selalu bertingkahtaku sebagai kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen berbeda. Jiwa dan tubuh bukan dua unsur terpisah tetapi bagian dari satu kesatuan dan apa yang terjadi dibagian satu akan mempengaruhi bagian lain. Hukum inilah yang semestinya ditemukan agar dapat dipahami berfungsinya setiap komponen. (Sulmasy, 2020).

Pandangan holistik dalam kepribadian, yang terpenting adalah :

1. Kepribadian normal ditandai oleh unitas, integrasi, konsistensi dan koherensi (unity, integration, consistency, dan coherence). Organisasi adalah keadaan normal dan disorganisasi berarti patologik.
2. Organisme dapat dianalisis dengan membedakan tiap bagiannya, tetapi tidak ada bagian yang dapat dipelajari dalam isolasi. Keseluruhan berfungsi menurut hukum-hukum yang tidak terdapat dalam bagian-bagian.
3. Organisme memiliki satu dorongan yang berkuasa, yakni aktualisasi diri (self actualization). Orang berjuang tanpa henti (continuous) untuk merealisasikan potensi inheren yang dimilikinya pada ranah maupun terbuka baginya.
4. Pengaruh lingkungan eksternal pada perkembangan normal bersifat minimal. Potensi organisme, jika terkuak di lingkungan yang tepat, akan menghasilkan kepribadian yang sehat dan integral.
5. Penelitian komprehensif terhadap satu orang lebih berguna daripada penelitian ekstensif terhadap banyak orang mengenai fungsi psikologis yang diisolir.

D. Konsep Humanisme

Dalam teori humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia. Pendekatan ini melihat kejadian yaitu bagaimana dirinya untuk melakukan hal - hal yang positif. Kemampuan positif ini disebut sebagai potensi manusia dan para pendidik beraliran humanisme biasanya menfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif. Kemampuan positif tersebut erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif yang terdapat dalam domain afektif. Emosi

merupakan karakteristik sangat kuat yang nampak dari para pendidik beraliran humanisme. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Dimana memanusiakan manusia di sini berarti mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. (Joseph, 2016).

1. Ciri - Ciri Teori Humanisme

Pendekatan humanisme dalam pendidikan menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencakup kemampuan interpersonal sosial dan metode untuk pengembangan diri ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan masyarakat. Keterampilan atau kemampuan membangun diri secara positif ini menjadi sangat penting dalam pendidikan karena keterkaitannya dengan keberhasilan akademik.

Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika siswa memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik - baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya yaitu membantu masing - masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia unik dan membantu dalam mewujudkan potensi - potensi yang ada dalam diri mereka.

Ada salah satu ide penting dalam teori belajar humanisme yaitu siswa harus mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dalam kegiatan belajar - mengajar, sehingga siswa mengetahui apa yang dipelajarinya serta tahu seberapa besar siswa tersebut dapat memahaminya juga siswa dapat mengetahui mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Dengan demikian, siswa diharapkan mendapat manfaat dan kegunaan dari hasil belajar bagi dirinya sendiri. Aliran humanisme memandang belajar sebagai sebuah proses yang terjadi dalam individu meliputi bagian atau domain diantaranya domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Dengan kata lain, pendekatan humanisme menekankan pentingnya emosi atau perasaan, komunikasi terbuka dan nilai - nilai yang dimiliki oleh setiap individu.

2. Teori maslow

Asumsi dan Prinsip Dasar Teori Humanisme

Ahli - ahli teori humanistik menunjukkan bahwa tingkah laku individu pada mulanya ditentukan oleh bagaimana mereka merasakan dirinya sendiri dan dunia sekitarnya serta individu bukanlah satu - satunya hasil dari lingkungan mereka seperti yang dikatakan oleh ahli teori tingkah laku, melainkan langsung dari dalam (internal), bebas memilih, dimotivasi oleh keinginan untuk aktualisasi diri (self - actualization) atau memenuhi potensi keunikan mereka sebagai manusia.

Abraham Maslow mengatakan bahwa di dalam diri individu ada dua hal yaitu:

- a. Suatu usaha yang positif untuk berkembang.
- b. Kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu.

Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hirarki. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, seperti kebutuhan psikologis, barulah ia dapat menginginkan kebutuhan yang terletak di atasnya, ialah kebutuhan mendapatkan rasa aman dan seterusnya. Maslow berfokus pada individu secara keseluruhan, bukan hanya satu aspek individu, dan menekankan kesehatan daripada sekedar penyakit dan masalah. Teori yang terkenal dari Maslow yang merupakan salah satu tokoh humanistik adalah teori tentang Hirarki Kebutuhan.

Adapun hirarki kebutuhan tersebut sebagai berikut:

- c. Kebutuhan fisiologis atau dasar, seperti, makan, minum, menghirup udara dan sebagainya. Termasuk juga kebutuhan untuk istirahat, buang air besar atau kecil, menghindari rasa sakit dan seks. Jika terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.
- d. Kebutuhan akan rasa aman, seperti keadaan aman, stabilitas, proteksi, dan keteraturan akan menjadi kebutuhan yang meningkat. Jika tidak terpenuhi, maka akan timbul rasa cemas dan takut.
- e. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, hal ini dapat terlihat dalam usaha seseorang untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, anak, atau bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu seperti tim sepakbola, klub peminatan dan seterusnya. Jika tidak terpenuhi, maka perasaan kesepian akan timbul.
- f. Kebutuhan untuk dihargai terdapat dua jenis, yaitu lower one (status, atensi, reputasi) dan higher one (kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, kebebasan). Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka dapat timbul perasaan rendah diri dan inferior.

- g. Kebutuhan untuk aktualisasi diri, menunjukkan karya kita pada orang lain. Berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian bisa mencapai peringkat teratas ketika kebutuhan - kebutuhan primer ini banyak mengalami interaksi satu dengan yang lain, dan dengan aktualisasi diri seseorang akan bisa memanfaatkan faktor potensialnya secara sempurna.
- h. Spiritual

E. Kedudukan Pengasuhan dalam Teori Humanisme

Dalam pendekatan humanistik, orang tua diajarkan untuk mencerminkan perasaan anak - anak mereka dan membantunyatumbuh dalam kesadaran diri dan pemahaman serta memfasilitasi kematangan psikologis. Abraham Maslow melengkapi pemikiran tersebut dengan teori motivasi. Menurutnya, potensi -potensi unik seorang anak akan muncul apabila diberi motivasi dengan cara penyampaian wawasan, contoh orang tua, pergaulan dengan teman lain, maupun pengalaman langsung.

Dalam praktik pengasuhan, orang tua dianggap sebagai fasilitator yaitu menyediakan lingkungan dan sarana belajar anak untuk mengembangkan potensinya. Semakin dipenuhinya fasilitas yang dibutuhkan anak, akan semakin berkembang potensi - potensi yang dimiliki seorang anak. Selain itu, orang tua harus berperan sebagai motivator. Peran ini dilakukan dengan memberikan dorongan dan dukungan bagi berbagai hal yang menjadi minat seorang anak. Apabila anak melakukan kekeliruan tidak disalahkan atau disudutkan, tetapi diberi bimbingan dengan kalimat - kalimat yang membangkitkan semangat. Sehingga anak terpacu untuk melakukan tugasnya dan semakin tinggi tingkat pengaktualisasiannya.

1. Teori Pembelajaran Humanistik

Pengertian humanistik yang beragam membuat batasan - batasan aplikasinya dalam dunia pendidikan mengundang berbagai macam arti pula. Sehingga perlu adanya satu pengertian yang disepakati mengenai kata humanistik dalam pendidikan. Dalam artikel "What is Humanistik Education?". Krischenbaum menyatakan bahwa sekolah, kelas atau guru dapat dikatakan bersifat humanistik dalam beberapa kriteria. Hal ini menunjukkan, bahwa ada beberapa tipe pendekatan humanistik dalam pendidikan. Ide mengenai pendekatan - pendekatan ini terangkum dalam psikologi humanistik.

Dalam artikel "Some Educational Implications of the Humanistic Psychologist", Abraham Maslow mencoba untuk mengkritisi teori Freud dan Behavioristik. Menurutnya yang terpenting dalam melihat manusia adalah potensi

yang dimilikinya. Humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia daripada berfokus pada ketidaknormalan atau sakit seperti yang dilihat oleh teori psikoanalisa Freud. Pendekatan ini melihat kejadian setelah sakit tersebut sembuh, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan hal - hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi manusia dan para pendidik yang beraliran humanistik biasanya memfokuskan penganjarannya pada pembangunan kemampuan positif ini.

Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik - baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing - masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi - potensi yang ada dalam diri mereka. (Taormina & Gao, 2018).

2. Prinsip - Prinsip Belajar Humanistik :

- a. Manusia mempunyai belajar alami.
- b. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu.
- c. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya.
- d. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil.
- e. Bila ancaman itu rendah terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara.
- f. Belajar yang bermakna diperolehi jika siswa melakukannya.
- g. Belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar.
- h. Belajar yang melibatkan siswa sepenuhnya dapat memberi hasil yang mendalam.
- i. Kepercayaan pada diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri.
- j. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar

F. Implementasi Pelayanan Holistik-Humanistik dalam Praktik Kebidanan

Pelayanan kebidanan berbasis holistik-humanistik tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi harus terimplementasi dalam setiap tahapan asuhan, mulai dari pengkajian hingga evaluasi. Pendekatan ini menempatkan perempuan sebagai subjek aktif dalam proses pelayanan kesehatan (ICM, 2021).

1. Pengkajian Holistik dalam Kebidanan

Pengkajian tidak hanya mencakup data fisik, tetapi juga meliputi:

- a. Kondisi psikologis (tingkat kecemasan, kesiapan menjadi ibu)
- b. Dukungan sosial dan keluarga
- c. Nilai budaya dan keyakinan spiritual
- d. Kondisi ekonomi dan lingkungan

Model biopsikososial-spiritual menekankan pentingnya integrasi seluruh aspek tersebut dalam pengambilan keputusan klinis (Sulmasy, 2020).

2. Asuhan Berbasis Woman-Centered Care

Woman-centered care merupakan pendekatan yang:

- a. Menghormati pilihan perempuan
- b. Memberikan informasi yang jelas untuk pengambilan keputusan
- c. Mendorong partisipasi aktif ibu
- d. Menghindari praktik paternalistik

Pendekatan ini terbukti meningkatkan kepuasan ibu dan kualitas pengalaman persalinan (WHO, 2021; ICM, 2021).

3. Komunikasi Terapeutik dalam Pelayanan Humanistik

Komunikasi menjadi inti pendekatan humanistik. Prinsip komunikasi terapeutik meliputi:

- a. Active listening
- b. Empati
- c. Non-judgmental attitude
- d. Validasi perasaan klien

Komunikasi yang efektif meningkatkan kepercayaan dan memperkuat hubungan bidan-klien (Jeffreys, 2020).

4. Spiritualitas dalam Asuhan Kebidanan

Spiritualitas merupakan dimensi penting dalam pelayanan holistik. Banyak ibu menghadapi kecemasan saat kehamilan dan persalinan, sehingga dukungan spiritual dapat membantu meningkatkan ketenangan dan coping mechanism.

Pendekatan spiritual dalam pelayanan kesehatan terbukti meningkatkan kesejahteraan psikologis pasien (Sulmasy, 2020).

G. Tantangan Penerapan Pelayanan Holistik-Humanistik

Meskipun penting, penerapan pelayanan holistik menghadapi beberapa tantangan:

- 1. Beban kerja tenaga kesehatan
- 2. Keterbatasan waktu konsultasi
- 3. Kurangnya pelatihan komunikasi empatik
- 4. Sistem pelayanan yang masih berorientasi pada kuratif

Turale & Kunaviktikul (2019) menegaskan bahwa dukungan sistem dan kebijakan sangat diperlukan agar praktik holistik dapat berjalan optimal.

H. Urgensi Pelayanan Holistik-Humanistik di Era Transformasi Kesehatan

Di era transformasi sistem kesehatan global, pelayanan yang terintegrasi dan berpusat pada individu menjadi prioritas utama (WHO, 2021). Pelayanan kebidanan yang hanya berfokus pada intervensi medis tanpa memperhatikan aspek emosional dan sosial dapat mengurangi kualitas pengalaman ibu.

Pendekatan holistik-humanistik mendukung:

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan
2. Pencegahan komplikasi berbasis psikososial
3. Penguatan ketahanan keluarga
4. Pelayanan yang bermartabat dan beretika

I. Model Konseptual Pelayanan Kebidanan Holistik-Humanistik

Pelayanan kebidanan holistik-humanistik dapat digambarkan melalui integrasi empat pilar utama:

1. Biologis → Pemeriksaan fisik, pemantauan kehamilan, deteksi risiko.
2. Psikologis → Dukungan emosional, manajemen kecemasan, kesiapan menjadi ibu.
3. Sosial → Dukungan keluarga, kondisi ekonomi, lingkungan tempat tinggal.
4. Spiritual → Keyakinan, nilai hidup, makna kehamilan dan persalinan.

Model ini selaras dengan pendekatan integrated people-centred health services yang menekankan koordinasi pelayanan lintas aspek kehidupan individu (WHO, 2021).

Dalam praktik kebidanan, keempat dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan memengaruhi hasil kesehatan ibu dan bayi.

J. Perbandingan Pendekatan Biomedis dan Holistik

Aspek	Pendekatan Biomedis	Pendekatan Holistik-Humanistik
Fokus	Penyakit & gejala	Individu secara utuh
Peran Pasien	Objek pelayanan	Subjek aktif
Pengambilan Keputusan	Tenaga kesehatan dominan	Kolaboratif
Dimensi yang Dilihat	Fisik	Fisik, psikologis, sosial, spiritual
Tujuan	Penyembuhan	Kesejahteraan menyeluruh

Pendekatan holistik terbukti meningkatkan kepuasan pasien dan kualitas pelayanan (Dossey & Keegan, 2016).

K. Refleksi Profesionalisme Bidan

Pelayanan holistik-humanistik menuntut bidan memiliki:

1. Kompetensi klinis
2. Kecerdasan emosional
3. Sensitivitas budaya
4. Integritas moral
5. Kemampuan komunikasi terapeutik

Watson (2018) menekankan bahwa caring bukan sekadar tindakan teknis, tetapi sikap moral dan komitmen kemanusiaan dalam praktik kesehatan.

L. Implikasi bagi Pendidikan Kebidanan

Dalam pendidikan kebidanan, pendekatan humanistik dapat diterapkan melalui:

1. Pembelajaran reflektif
2. Diskusi studi kasus
3. Simulasi komunikasi terapeutik
4. Penilaian berbasis kompetensi afektif

Pendidikan berbasis humanistik membantu mahasiswa mengembangkan empati dan profesionalisme (Joseph, 2016).

M. Pertanyaan Reflektif untuk Mahasiswa

1. Bagaimana Anda menerapkan pendekatan holistik dalam praktik klinik?
2. Apakah Anda sudah melibatkan aspek psikologis dan spiritual dalam pengkajian?
3. Bagaimana cara meningkatkan komunikasi terapeutik dengan klien?
4. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan woman-centered care?

N. Simpulan

Pengobatan *Holistic* adalah, Pengobatan dengan menggunakan Konsep Menyeluruh, yaitu keterpaduan antara Jiwa dan raga, dengan method Alamiah yang ilmiah, serta ilahia yang mana Tubuh manusia merupakan keterpaduan system yang sangat Kompleks, dan salingberinteraksi satu sama lainnya dengan sangat kompak dan otomatis terganggunya satu fungsi/ elemen / unsure tubuh manusia dapat mempengaruhi fungsi yang lainnya. Holisme, bila ditelusuri dari akarnya berasal dari konsep Aristoteles (filosof dari Yunani), Baruch Spinoza (filosof Belanda), dan

William James (filosof dan psikolog dari Amerika), yang berkaitan dengan pergerakan Gestalt sebelum perang dunia. Holisme adalah nama yang diberikan kepada keyakinan bahwa adalah semua terkait erat. Holistik melihat dirinya terus-menerus sebagai bagian dari keseluruhan dan menganggap yang lain (manusia, hewan, tumbuhan atau objek) sebagai yang lain. Konsep holisme selalu mengemukakan bahwa organisme merupakan satu kesatuan yang utuh, bukan terbagi-bagi dalam bagian-bagian. Sehingga pikiran dan tubuh bukan merupakan bagian yang terpisah, tetapi merupakan satu bagian yang utuh, dan apabila terjadi sesuatu pada salah satunya maka akan berpengaruh pada keseluruhan. Perkembangan psikologi humanistik tidak lepas dari pandangan psikologi holistik dan humanistik. "Humanisme" dipandang sebagai sebuah gagasan positif oleh kebanyakan orang. Humanisme mengingatkan kita akan gagasan-gagasan seperti kecintaan akan perikemanusiaan, perdamaian, dan persaudaraan. Tetapi, makna filosofis dari humanisme jauh lebih signifikan: humanisme adalah cara berpikir bahwa mengemukakan konsep perikemanusiaan sebagai fokus dan satu-satunya tujuan. Kamus umum mendefinisikan humanisme sebagai "sebuah sistem pemikiran yang berdasarkan pada berbagai nilai, karakteristik, dan tindak tanduk yang dipercaya terbaik bagi manusia, bukannya pada otoritas supernatural mana pun".

O. Referensi

- Alligood, M. R. (2022). *Nursing theorists and their work* (10th ed.). Elsevier.
- Dossey, B. M., & Keegan, L. (2016). *Holistic nursing: A handbook for practice* (7th ed.). Jones & Bartlett Learning.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2021). *Essential competencies for midwifery practice*. ICM.
- Jeffreys, M. R. (2020). *Teaching cultural competence in nursing and health care* (4th ed.). Springer Publishing Company.
- Joseph, S. (2016). *Person-centered therapy: A positive psychology perspective*. Palgrave Macmillan.
- Sulmasy, D. P. (2020). The biopsychosocial-spiritual model for the care of patients at the end of life. *The Gerontologist*, 60(1), 1–8.
- Smuts, J. C. (1926). *Holism and evolution*. Macmillan.
- Taormina, R. J., & Gao, J. H. (2018). Maslow and the motivation hierarchy: Measuring satisfaction of the needs. *American Journal of Psychology*, 131(2), 1–14.
- Turale, S., & Kunaviktikul, W. (2019). The contribution of holistic nursing to universal health coverage. *International Nursing Review*, 66(4), 1–4.

Watson, J. (2018). *Unitary caring science: Philosophy and praxis of nursing*. University Press of Colorado.

World Health Organization (WHO). (2021). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. WHO.

World Health Organization (WHO). (2016). *Framework on integrated people-centred health services*. WHO.

P. Glosarium

Aktualisasi Diri (*Self-Actualization*)

Proses pengembangan dan perwujudan potensi diri secara optimal sesuai dengan kemampuan dan nilai individu.

Autonomy (Otonomi)

Hak pasien untuk menentukan pilihan dan keputusan terkait pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Beneficence

Prinsip etika yang menekankan kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan manfaat terbaik bagi pasien.

Biopsikososial-Spiritual

Pendekatan yang memandang kesehatan sebagai hasil interaksi antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Caring

Sikap peduli yang diwujudkan melalui empati, perhatian, dan hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan klien.

Cultural Competency

Kemampuan tenaga kesehatan memahami dan menghormati nilai, budaya, serta keyakinan pasien dalam pelayanan kesehatan.

Evidence-Based Practice (EBP)

Praktik pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, serta nilai dan preferensi pasien.

Holisme

Pandangan bahwa manusia merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipahami hanya melalui bagian-bagiannya saja.

Holistic Care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual secara menyeluruh.

Humanisme

Pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian dengan menjunjung tinggi martabat, nilai, dan potensi individu.

Integrated People-Centred Health Services

Model pelayanan kesehatan terintegrasi yang berpusat pada kebutuhan individu dan komunitas.

Non-Maleficence

Prinsip etika untuk tidak menimbulkan bahaya atau kerugian pada pasien.

Self-Care

Kemampuan individu atau tenaga kesehatan untuk menjaga kesejahteraan diri secara fisik dan mental.

Spiritualitas

Dimensi kehidupan yang berkaitan dengan makna hidup, nilai, keyakinan, dan hubungan dengan Tuhan atau kekuatan transenden.

Therapeutic Communication

Komunikasi profesional yang bertujuan membantu proses penyembuhan melalui empati, mendengar aktif, dan validasi perasaan.

Woman-Centered Care

Pendekatan pelayanan kebidanan yang menempatkan perempuan sebagai pusat pelayanan dan pengambil keputusan utama.

WUS (Wanita Usia Subur)

Perempuan dalam rentang usia reproduktif (15–49 tahun) yang secara biologis berpotensi mengalami kehamilan.

CHAPTER 2

PENDEKATAN BIO-PSIKO-SOSIAL-SPRITUAL DALAM ASUHAN KESEHATAN

Erwin Purwanto, S.Kep., Ners., M.Kep

A. Pendahuluan

Pendekatan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual atau biasa disingkat BPSS dalam pemberian asuhan kesehatan merupakan suatu paradigma holistik yang memandang individu sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak hanya dari aspek biologis semata, namun individu juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Proses pendekatan pasien dengan metode bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) berakar dari *Biopsychosocial Model* yang diperkenalkan oleh Engel pada tahun 1977, dimana model ini berkembang atas terbatasnya model biomedis yang cenderung berfokus pada penyakit dan aspek fisiologis, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor non fisik yang secara signifikan mempengaruhi kesehatan, proses penyembuhan, serta kualitas hidup individu seperti aspek psikologis dan sosial pasien (Engel, 2012).

Seiring perkembangan ilmu kesehatan, dalam konteks ini pelayanan kesehatan modern, kompleksitas masalah kesehatan menuntut tenaga kesehatan untuk memahami manusia sebagai individu secara komprehensif, model bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) terus berevolusi dengan memasukkan aspek spiritual sebagai komponen penting dalam asuhan kesehatan yang diberikan sehingga lebih efektif, manusiawi, dan berpusat pada pasien dalam pemahaman kesehatan dan penyakit secara menyeluruh.

Aspek biologis mencakup kondisi fisik, proses patofisiologi penyakit, serta intervensi medis yang diberikan untuk memperbaiki fungsi tubuh. Namun, kondisi biologis dari individu sering kali dipengaruhi oleh aspek psikologis seperti stress, kecemasan, depresi, dan mekanisme koping yang berpengaruh signifikan terhadap proses penyakit, kepatuhan pengobatan, serta hasil klinis pasien (Borrell-Carrió et al., 2004). Interaksi antara kondisi biologis dan psikologis dapat menegaskan bahwa penyembuhan tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan medis.

Aspek sosial dalam hal ini meliputi dukungan keluarga, lingkungan sosial, budaya, status ekonomi dan akses terhadap layanan kesehatan serta lingkungan tempat tinggal terbukti mempengaruhi perilaku kesehatan, akses layanan, dan kemampuan pasien turut memainkan peranan penting dalam menentukan

kemampuan individu dalam mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatannya (Gilbert et al., 2010). Melalui pendekatan bio-psiko-sosial menempatkan faktor-faktor tersebut sebagai bagian integral dari proses pengkajian dan perencanaan asuhan kesehatan.

Selain aspek bio-psiko-sosial, aspek spiritual menjadi komponen penting dalam pemberian layanan asuhan kesehatan, khususnya dalam menghadapi penyakit kronis, kondisi terminal, maupun situasi krisis kesehatan. Aspek spiritual berkaitan dengan makna hidup, harapan, keyakinan, dan hubungan individu dengan kekuatan yang lebih tinggi yang sering kali menjadi sumber ketegangan, ketahanan, dan penerimaan terhadap kondisi yang dialami (Koenig, 2015). Aspek spiritual melengkapi pendekatan holistik dengan menyoroti makna hidup, nilai, keyakinan, serta hubungan individu dengan Tuhan-Nya.

Spiritualitas terbukti memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan psikologis, ketahanan emosional, serta kualitas hidup pasien khususnya pada pasien dengan penyakit kronis dan kondisi terminal. Integrasi aspek spiritual dalam pemberian layanan asuhan kesehatan dapat meningkatkan derajat kesejahteraan kesehatan holistik pasien, memperkuat mekanisme koping, serta memberikan dukungan emosional yang bermakna. Selain itu, integrasi aspek spiritual dalam asuhan kesehatan juga sejalan dengan konsep *caring* dan pelayanan yang berpusat pada pasien (*patient centered care*) (Kannan & Gowri, 2020).

Melalui pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual dalam pemberian asuhan kesehatan pada pasien, menuntut peran aktif dari tenaga kesehatan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif, perencanaan intervensi yang individual dan kontekstual, serta kolaborasi multidisiplin. Pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) mendukung prinsip pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien (*patient centered care*) dan terbukti mampu meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan dan kepuasan pasien, serta hasil kesehatan secara menyeluruh terhadap layanan kesehatan (Puchalski et al., 2014).

B. Konsep Pendekatan Bio-Psiko-Sosial-Spiritual

Pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) merupakan asuhan kesehatan holistik yang memandang individu sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, dimana keempat aspek ini saling berinteraksi dalam menentukan status kesehatan dan penyakit dari individu. Sebagai model asuhan kesehatan holistik, model bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) mendorong praktik pelayanan kesehatan yang komprehensif, humanistik, dan kolaboratif, dimana melalui pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan memahami pasien secara lebih mendalam, merancang intervensi yang sesuai

dengan kebutuhan individu, serta dapat meningkatkan kualitas asuhan dan kepuasan pasien.

Pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) memandang aspek biologis sebagai suatu bagian yang mencakup proses fisiologis, patologis, genetik, serta respon tubuh terhadap intervensi medis. Aspek biologis menjadi komponen penting dalam asuhan kesehatan karena melalui pemeriksaan yang terstruktur pada aspek biologis tenaga kesehatan dapat menentukan diagnosa klinis pasien, pemeriksaan penunjang pada pasien, dan terapi medis yang akan diberikan oleh petugas kesehatan kepada pasien. Namun, dalam pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) memandang aspek biologis tidak dapat berdiri sendiri dalam pemberian asuhan kesehatan, melainkan dipengaruhi dan mempengaruhi aspek psikologis, sosial, serta spiritual pasien itu sendiri (Borrell-Carrió et al., 2004).

Aspek psikologis merupakan aspek berikutnya dalam pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS), dimana aspek psikologis meliputi emosional, kognitif, sikap, persepsi individu terhadap penyakitnya, serta bagaimana mekanisme coping individu terhadap penyakit yang dialami. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara stress, kecemasan, depresi, dan motivasi pasien terhadap proses penyembuhan dan kepatuhan pasien dengan pengobatan yang dijalani. Sehingga pemahaman akan pemenuhan kebutuhan psikologis oleh tenaga kesehatan menjadi aspek penting yang tidak bisa dipisahkan dalam pemberian asuhan kesehatan yang berpusat pada pasien (Suls & Green, 2019).

Aspek lain yang merupakan bagian dari pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) yaitu aspek sosial, dimana aspek ini lebih menekankan pada pengaruh dan peran dari lingkungan sosial, budaya, ekonomi, serta dukungan keluarga dan masyarakat juga memiliki pengaruh dalam menentukan derajat kesehatan individu. Faktor-faktor yang berperan pada aspek sosial seperti status sosial ekonomi, hubungan interpersonal, peran keluarga, dan akses terhadap pelayanan kesehatan terbukti secara efektif dapat mempengaruhi derajat kesehatan individu. Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan asuhan kesehatan dengan pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS), tenaga kesehatan dituntut untuk mempertimbangkan aspek sosial pasien untuk menjadi dasar dalam pemberian ataupun perencanaan tindakan maupun intervensi kesehatan yang realistis dan bersifat berkelanjutan (Morelli, 2023).

Aspek terakhir yang menjadi komponen dalam pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) yakni aspek spiritual, dimana aspek ini memandang konsep spiritual berkaitan dengan pencarian makna hidup, tujuan hidup, nilai-nilai yang diyakini, serta bentuk-bentuk keyakinan yang dapat memberikan kekuatan batin bagi individu dalam menghadapi proses penyakit yang diderita. Hal ini sudah terbukti

dari sejumlah studi yang dilakukan menunjukkan bahwa melalui pemberian dukungan spiritual yang baik berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup, perbaikan kondisi psikologis pasien dalam menghadapi masalah kesehatan yang dialami, serta bentuk penerimaan individu terhadap kondisi penyakitnya lebih baik (Glajchen et al., 2024). Aspek spiritual dalam pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS), dipandang sebagai aspek menyeluruh yang tidak selalu berkaitan dengan agama, melainkan segala sesuatu yang relevan bagi pasien itu sendiri.

Pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) merupakan model asuhan kesehatan yang bersifat holistik dengan memandang manusia sebagai kesatuan utuh yang terdiri aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Aspek biologis berkaitan dengan fungsi tubuh dan proses penyakit, sedangkan aspek psikologis mencakup aspek emosional, kognitif, dan mekanisme coping individu, sementara aspek sosial menyoroti peran keluarga, lingkungan, budaya, dan sistem sosial dalam mempengaruhi perilaku kesehatan individu, serta aspek spiritual lebih merefleksikan nilai, keyakinan, makna hidup, dan harapan yang menjadi sumber kekuatan individu. Model bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) menekankan pemberian asuhan yang tidak terbatas pada aspek medis, tetapi menyentuh seluruh kebutuhan pasien dengan menempatkan individu sebagai subjek aktif dalam proses asuhan kesehatan.

C. Aspek Biologis dalam Asuhan Kesehatan

Aspek biologis merupakan komponen utama dalam asuhan kesehatan yang menekankan aspek fisik-biologis tubuh manusia sebagai dasar dalam pengkajian, diagnosa, intervensi, dan evaluasi dalam pelayanan kesehatan. Aspek biologis berfokus pada kondisi fisik, proses fisiologis, serta mekanisme patofisiologi yang terjadi pada individu selama keadaan sehat maupun sakit. Aspek biologis terfokus pada bagaimana fungsi tubuh bekerja secara normal, bagaimana perubahan biologis dapat memicu penyakit, serta bagaimana respon tubuh terhadap berbagai intervensi medis dan keperawatan. Pemahaman yang kuat terhadap aspek biologis menjadi dasar penting oleh tenaga kesehatan dalam menghadirkan asuhan kesehatan yang tepat dan efektif bagi pasien.

Aspek biologis dalam praktik klinis dilakukan melalui pengkajian tanda dan gejala klinis, pemeriksaan laboratorium, penggunaan biomarker, dan studi diagnostik, kesemuanya digunakan untuk menentukan status biologis individu serta bagaimana respon terhadap terapi. Pengkajian biologis dilakukan secara sistematis melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Mekanisme patofisiologi penyakit menjelaskan terkait proses terjadinya gangguan fungsi organ atau sistem tubuh yang meliputi mekanisme proses molekuler dan seluler, untuk pemberian intervensi pada aspek biologis meliputi pemberian terapi farmakologis,

perawatan medis, serta respon individu terhadap pengobatan, pemahaman terkait mekanisme penyakit menjadi dasar dalam merancang intervensi yang lebih efektif (Brock et al., 2024).

Respon biologis individu terhadap terapi sangat bervariasi yang dipengaruhi oleh tubuh secara keseluruhan seperti fungsi organ, imunitas, serta adanya penyakit yang menyertai akan mempengaruhi efektivitas pengobatan dan proses penyembuhan. Selain itu, aspek biologis juga mencakup bagaimana faktor biologis dapat mempengaruhi kesehatan mental dan perkembangan fisik, sebagaimana pemanfaatan biomarker seperti integrasi data nutrisi, metabolisme, dan proses inflamasi dalam memahami kondisi kesehatan individu, hal ini menunjukkan bahwa aspek biologis berperan dalam penilaian risiko dan pengembangan terapi individu (Inamdar et al., 2025). Oleh karena itu, pemberian asuhan kesehatan berbasis aspek biologis seharusnya bersifat individual, menyesuaikan intervensi dengan kondisi fisik dan kemampuan adaptasi dari tubuh pasien.

Dalam pemberian asuhan kesehatan, aspek biologis mencakup berbagai elemen yang saling berkaitan untuk memahami status kesehatan, penyakit, serta respon tubuh terhadap intervensi yang menjadi dasar dalam penentuan asuhan kesehatan yang aman dan efektif, dimana komponen tersebut terdiri dari :

1. Pengkajian kondisi fisik dan fisiologis pasien

Pengkajian yang dilakukan meliputi tanda vital, status nutrisi, fungsi organ, status hidrasi, serta kemampuan fungsional pasien. Pengkajian kondisi fisik dan fisiologis pasien harus dilakukan secara sistematis, hal ini karena memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi perubahan dari aspek biologis pasien sejak awal, sehingga dapat untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis. Studi terbaru menyebutkan bahwa pengkajian biologis yang komprehensif berperan penting dalam meningkatkan keselamatan pasien serta akurasi diagnosis klinis (Guzmán-Leguel & Rodríguez-Lara, 2025).

2. Patofisiologi penyakit pasien

Patofisiologi menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya penyakit pada tingkat seluler, jaringan, dan sistem organ. Hal ini menuntut pemahaman yang baik dari tenaga kesehatan, karena dapat membantu tenaga kesehatan mengaitkan gejala klinis dengan proses biologis yang mendasarinya, sehingga dalam menentukan intervensi yang akan diberikan kepada individu menjadi lebih tepat sasaran dan rasional. Pemahaman yang baik akan patofisiologi dari suatu kondisi penyakit dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas asuhan yang berbasis bukti serta dapat menurunkan kesalahan klinis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (Lewis et al., 2015).

3. Pemeriksaan diagnostik pasien

Pemeriksaan diagnostik terdiri dari beberapa diantaranya pemeriksaan laboratorium, radiologi, serta biomarker molekuler yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis, memantau tingkat progressive penyakit, dan dapat juga digunakan sebagai bagian untuk mengevaluasi terapi serta respon pasien terhadap terapi yang diberikan. Hal ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Lewis et al., (2014) yang menunjukkan penggunaan biomarker biologis dalam praktik klinis modern terbukti dapat meningkatkan ketepatan terapi dan memungkinkan pendekatan pengobatan yang lebih personal (*personalized medicine*)

4. Intervensi berbasis biologis

Intervensi yang berbasis biologis meliputi pemberian farmakoterapi, tindakan medis, terapi nutrisi, serta perawatan keperawatan yang ditujukan untuk memperbaiki atau mempertahankan fungsi biologis tubuh individu. Berbagai macam intervensi yang dapat diberikan, seperti pengimplementasian praktik berbasis bukti (*evidence based practice*) dalam intervensi terbukti mampu untuk meningkatkan *outcome* klinis dan menurunkan terjadinya komplikasi (Wood LoBiondo et al., 2019).

5. Respon dan evaluasi hasil asuhan

Penilaian respon dan evaluasi dilakukan dengan memantau perubahan pada tanda-tanda vital, hasil pemeriksaan laboratorium, status klinis, serta respon terhadap terapi. Pemantauan secara berkelanjutan sangat penting untuk menilai seberapa efektifitas intervensi yang telah diberikan serta dapat menjadi dasar dalam menyesuaikan rencana asuhan kesehatan yang diberikan kepada individu.

Secara keseluruhan komponen aspek biologis sebagai dasar dalam memahami kondisi kesehatan individu, menentukan diagnosis, merencanakan intervensi, serta mengevaluasi hasil asuhan yang telah diberikan secara objektif. Pendekatan biologis tidak hanya membantu menentukan penyebab dari suatu penyakit, tetapi juga menunjang peningkatan kualitas asuhan klinis melalui praktik berbasis bukti (*evidence based practice*). Secara keseluruhan, aspek biologis dalam asuhan kesehatan berperan sebagai landasan utama dalam pemberian pelayanan kesehatan, meskipun demikian, komponen biologis perlu diintegrasikan dengan aspek psikologis, sosial, dan spiritual agar asuhan kesehatan menjadi holistik dan komprehensif.

D. Aspek Psikologis dalam Asuhan Kesehatan

Pelaksanaan praktik asuhan kesehatan modern telah mengalami pergeseran paradigma, dimana dalam memberikan pelayanan asuhan kesehatan kepada pasien tidak hanya sekedar mengobati penyakit (*curing*), melainkan sekarang berubah menjadi melakukan perawatan secara menyeluruh dengan memandang pasien sebagai manusia seutuhnya (*caring*). Pada konteks ini, aspek psikologis menjadi penghubung karena kondisi fisik seseorang akan selalu beresonansi dengan kondisi mentalnya. Aspek psikologis merupakan bagian dari model bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) yang berfokus pada kondisi mental, emosional, kognitif, dan perilaku individu dalam menghadapi masalah kesehatan. Aspek psikologis memandang dan menempatkan pasien sebagai individu yang memiliki respon psikologis seperti stress, kecemasan, depresi, motivasi, dan mekanisme koping terhadap penyakit yang dialami berbeda-beda, dimana hal ini akan menjadi faktor penting yang mempengaruhi proses penyembuhan dan kualitas hidup pasien.

Aspek psikologis dalam asuhan kesehatan merupakan paradigma yang memandang bahwa derajat kesehatan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kondisi biologis saja, melainkan terdapat juga faktor lain seperti emosional, kognitif, dan sosial yang dapat meningkatkan kepatuhan individu dalam menjalani proses pengobatan sehingga mempercepat proses penyembuhan. Pada saat seseorang menderita penyakit akut maupun kronis sering menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan, seperti rasa takut terhadap prognosis penyakit, perubahan peran sosial, dan ketergantungan pada orang lain, dimana hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi gangguan psikologis akan berhubungan langsung dengan kondisi luaran klinis pasien (Katon, 2011).

Pada pelaksanaannya, hubungan terapeutik antara petugas kesehatan dengan pasien menjadi hal yang penting dalam pendekatan psikologis. Hubungan terapeutik dilandasi dengan komunikasi yang empatik, dukungan emosional, dan validasi perasaan oleh petugas kesehatan kepada pasien, semua hal ini dapat meningkatkan kepercayaan, rasa aman, serta keterlibatan pasien dalam proses perawatan sehingga hal ini akan membantu dalam penyembuhan. Terjalinnya hubungan terapeutik yang baik antara petugas kesehatan dan pasien terbukti efektif untuk meningkatkan kepuasan pasien terhadap petugas kesehatan serta dapat memperbaiki derajat kesehatan, terutama pada pasien dengan berbagai penyakit kronis (Afriyie, 2020).

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pendekatan psikologis utama yang dapat diterapkan, diantaranya *Biopsychosocial Model* yang memandang pasien tidak hanya sebagai "objek" dengan gangguan organ, melainkan individu yang memiliki

pikiran dan lingkungan sosial, sebagai contoh pasien dengan penyakit jantung coroner tidak hanya membutuhkan pembedahan (biologis), tetapi juga membutuhkan penanganan kecemasan dan dukungan sosial agar proses penyembuhan menjadi lebih optimal. *Health Belief Model* merupakan bentuk pendekatan psikologis lain dimana teori ini digunakan untuk memahami persepsi pasien terhadap resiko penyakit dan manfaat dari tindakan pengobatan, dimana jika pasien merasa sakitnya tidak berbahaya biasanya cenderung mengabaikan atau mengikuti program pengobatan. Disinilah peranan aspek psikologis dalam asuhan kesehatan untuk mengubah persepsi tersebut melalui edukasi yang menyentuh sisi kognitif pasien. Selain itu, intervensi psikologis seperti konseling, terapi kognitif perilaku (*Cognitive Behavioral Therapy*), edukasi kesehatan, dan manajemen stress menjadi bagian dari aspek psikologis (Chęć & Michałowska, 2024).

Terdapat beberapa komponen-komponen dalam aspek psikologis dalam pemberian asuhan kesehatan, diantaranya :

1. Persepsi dan Proses Kognitif

Hal ini terkait bagaimana pasien mempersepsikan kondisi kesehatannya secara kognitif yang mencakup pemahaman pasien tentang penyebab, tingkat keparahan, durasi, serta dampak dari penyakitnya. Cara pasien dalam menafsirkan penyakit akan mempengaruhi respon emosional dan juga perilaku kesehatannya, hal ini berarti persepsi negatif akan penyakitnya sering dikaitkan dengan tingginya kecemasan, depresi, serta rendahnya kepatuhan terhadap terapi, sebaliknya persepsi yang baik akan penyakitnya menunjukkan pasien lebih realistis dan adaptif sehingga menunjukkan perbaikan yang lebih baik (Broadbent et al., 2015).

2. Respon dan Regulasi Emosional

Penyakit akut maupun kronis sering memicu respon emosional seperti takut, cemas, marah, sedih, ataupun putus asa. Respon emosional merupakan bagian alami dari pengalaman sakit, namun jika hal ini tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses penyembuhan. Regulasi emosi menjadi aspek yang penting dalam komponen psikologis karena kemampuan pasien dalam mengelola emosinya berkaitan erat kepatuhan pengobatan dan proses penyembuhan. Hal ini menunjukkan regulasi emosi yang baik memiliki tingkat stress yang lebih rendah dan adaptasi psikologis yang lebih optimal terhadap penyakit kronis (Compas et al., 2017).

3. Stress dan Mekanisme Koping

Stress muncul ketika kemampuan seseorang tidak mampu untuk memenuhi tuntutan situasi kesehatan sehingga pasien mengalami keadaan sakit. Komponen ini melibatkan identifikasi stressor serta mekanisme koping yang digunakan oleh

pasien. Mekanisme koping yang dimiliki pasien sangat menentukan tingkat stress yang dimiliki pasien terkait kondisi penyakitnya. Sehingga petugas kesehatan dalam memberikan asuhan kesehatan perlu mempertimbangkan intervensi berbasis koping termasuk psikoedukasi dan dukungan psikososial, efektif dalam menurunkan tingkat stress dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Thumala et al., 2020).

4. Motivasi dan Perilaku Kesehatan

Motivasi yang dimiliki oleh pasien merupakan kunci untuk menentukan sejauh mana pasien terlibat dalam perawatan dan perubahan perilaku kesehatan. Motivasi dipengaruhi oleh keyakinan pasien terhadap manfaat terapi, persepsi resiko, serta efikasi diri. Pendekatan psikologis yang memperkuat motivasi seperti *motivational interviewing* terbukti efektif meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan dan menjadikan pasien melakukan perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat, sehingga hal ini menuntut pemahaman dari tenaga kesehatan terkait faktor psikologis yang dapat mempengaruhi motivasi pasien saat merancang intervensi (Wood et al., 2023).

5. Hubungan Terapeutik dan Dukungan Psikologis

Hubungan terapeutik antara pasien dan petugas kesehatan merupakan komponen psikologis yang sangat penting dalam tercapainya asuhan kesehatan. Hubungan terapeutik didasarkan pada empati, kepercayaan, dan komunikasi terbuka dapat meningkatkan kenyamanan dan rasa aman dari pasien. Selain itu, dukungan psikologis dari keluarga dan lingkungan sosial juga berperan dalam membantu pasien dalam meningkatkan derajat kesehatannya (Delgado et al., 2017).

6. Kesejahteraan Psikologis

Perasaan yang bermakna, penerimaan diri, harapan, dan kemampuan untuk bangkit dari kesulitan merupakan komponen lain yang juga tidak kalah penting. Kesejahteraan psikologis dan resiliensi yang tinggi memiliki hubungan dengan adaptasi yang lebih baik terhadap penyakit serta kemampuan pasien dalam meningkatkan derajat kesehatannya (Zhang et al., 2020).

Secara keseluruhan pendekatan psikologis dalam asuhan kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan mental, memperkuat koping pasien, serta mendukung keberhasilan terapi medis. Integrasi aspek psikologis menjadikan pemberian asuhan kesehatan lebih manusiawi, komprehensif, dan berorientasi pada kebutuhan dari individu pasien.

E. Aspek Sosial dalam Asuhan Kesehatan

Aspek sosial dalam asuhan kesehatan merupakan bagian penting dari praktik pelayanan kesehatan berbasis pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) yang memandang individu tidak hanya sebagai objek biologis, namun juga sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dan hidup dalam konteks keluarga, komunitas, budaya, dan strata sosial tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa, kondisi kesehatan dan penyakit seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti tingkat pendidikan, status ekonomi, pekerjaan, lingkungan tempat tinggal, akses terhadap layanan kesehatan, serta dukungan sosial yang diterima dari lingkungannya, dimana kesemua hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan asuhan kesehatan yang diberikan tidak terlepas dari pemahaman terhadap konteks sosial dari pasien tersebut.

Dalam pemenuhan asuhan kesehatan, aspek sosial dikaitkan dengan konsep *Social Determinants of Health* (SDOH) yang memandang bahwa kondisi sosial dan lingkungan yang membentuk peluang seseorang untuk mencapai derajat kesehatan secara optimal. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakamanan pangan, perumahan yang tidak layak, dan keterbatasan akses layanan kesehatan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan resiko terjadinya penyakit kronis serta buruknya luaran kesehatan. Novilla et al., (2023) menemukan bahwa pemberian intervensi medis saja sering kali tidak cukup bagi pasien selama pemberian asuhan keperawatan, apabila faktor-faktor sosial yang mendasari timbulnya masalah kesehatan tidak dapat diidentifikasi dengan baik serta dilakukan penanganan secara bersama dengan aspek biologis dan psikologis.

Pendekatan sosial dalam pemberian asuhan kesehatan memandang bahwa dukungan sosial menjadi element kunci dalam rangkaian proses penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan. Dukungan sosial yang dimaksudkan seperti yang berasal dari keluarga, teman, maupun komunitas terbukti memiliki peran dalam meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan, kemampuan coping adaptif pasien terhadap kondisinya, serta peningkatan kualitas hidup pasien tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pasien dengan dukungan sosial yang baik cenderung memiliki kontrol yang lebih baik serta tingkatan stress yang lebih rendah dibandingkan pasien dengan dukungan sosial yang rendah (Glenn et al., 2024). Keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial pasien selama menjalani perawatan kesehatan perlu menjadi bagian yang terintegrasi dalam perencanaan pemberian asuhan kesehatan.

Melalui pendekatan pada aspek sosial juga memiliki manfaat dalam hal ini yaitu mendorong tenaga kesehatan untuk melakukan pengkajian sosial secara sistematis dalam proses asuhan kesehatan. Pengkajian pada aspek sosial mencakup

identifikasi kondisi sosial pasien, seperti kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh pasien, bagaimana peran pasien dalam keluarga, kondisi tempat tinggal dari pasien, serta hambatan sosial yang dapat mempengaruhi pasien dalam mengakses fasilitas kesehatan serta bagaimana keberlanjutan perawatan pasien nantinya. Integrasi pengkajian sosial dalam asuhan kesehatan pada tatanan praktik klinik terbukti dapat membantu tenaga kesehatan untuk merancang intervensi kesehatan yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasien, hal ini dapat terjadi karena integrasi aspek sosial dalam layanan kesehatan berkontribusi pada penurunan kesenjangan kesehatan (*health inequities*) dan peningkatan efektivitas layanan (Novilla et al., 2023).

Pada konteks asuhan kesehatan khususnya asuhan keperawatan dan kesehatan masyarakat, pendekatan sosial juga dilakukan dengan kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan komunitas. Pelaksanaan program kesehatan yang dilaksanakan berbasis masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan organisasi sosial terbukti efektif dalam meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu dalam melaksanakan asuhan kesehatan, melibatkan aspek sosial dalam memberikan asuhan kesehatan kepada pasien juga dapat meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan, terutama pada kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dengan dukungan sosial yang kuat mampu meningkatkan keberhasilan program pengendalian penyakit menular dan tidak menular pada tingkat komunitas (Handayani & Suryana, 2024).

Aspek sosial dalam asuhan kesehatan menegaskan bahwa kesehatan merupakan hasil interaksi kompleks antara individu dan lingkungan sosialnya, sehingga dengan memahami dan mengintegrasikan faktor sosial ke dalam proses asuhan kesehatan, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal, manusiawi, kontekstual, dan berkeadilan yang akan berdampak pada peningkatan derajat kesehatan pasien lebih maksimal (Glenn et al., 2024). Pendekatan pada aspek sosial tidak hanya dapat meningkatkan luaran kesehatan, namun pendekatan pada aspek sosial juga dapat memberikan kontribusi pada pembangunan sistem kesehatan yang lebih efektif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.

F. Aspek Spiritual dalam Asuhan Kesehatan

Pendekatan spiritual dalam asuhan kesehatan merupakan bagian dari pelayanan kesehatan berbasis pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) yang memandang manusia sebagai makhluk yang utuh dalam pelayanan kesehatan holistik. Aspek spiritual dalam pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) berkaitan

dengan pencarian makna hidup, tujuan, harapan, nilai, keyakinan, serta hubungan individu dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan Tuhan. Pada konteks pelayanan kesehatan, pendekatan spiritual berperan penting dalam membantu pasien menghadapi kondisi penyakitnya, penderitaan yang dialami, ketidakpastian, serta ancaman terhadap kehidupan, terutama pada kondisi penyakit kronis, terminal, maupun situasi krisis kesehatan.

Pada praktik asuhan kesehatan, aspek spiritual diwujudkan melalui proses pengkajian kebutuhan spiritual pasien, penghormatan terhadap nilai dan keyakinan yang dianut, serta pemberian dukungan yang memungkinkan pasien mengekspresikan harapan, kecemasan, dan makna hidupnya. Peran tenaga kesehatan dalam pemberian asuhan kesehatan sangat strategis dalam melaksanakan pengintegrasian aspek spiritual (*spiritual care*) khususnya perawat yang memiliki waktu interaksi yang lebih lama dengan pasien, selain itu perawat juga melakukan interaksi langsung dan berkelanjutan dengan pasien. Pengkajian spiritual yang dilaksanakan secara sistematis terbukti mampu membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi *spiritual distress* seperti putus asa, kehilangan makna hidup, dan konflik keyakinan yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan proses penyembuhan pasien (Büssing et al., 2018).

Pendekatan melalui aspek spiritual dalam pemberian asuhan kesehatan kepada pasien terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pasien, hal ini dibuktikan dengan berbagai studi penelitian yang dilakukan dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa dukungan spiritual yang baik pada pasien yang sedang menjalani perawatan terbukti dapat menurunkan tingkat kecemasan, depresi, dan stress. Selain itu, dukungan spiritual yang baik kepada pasien juga dapat meningkatkan harapan dan mekanisme koping yang adaptif pasien dalam menghadapi penyakit (Best et al., 2020). Berbagai bentuk intervensi kesehatan dalam aspek spiritual seperti pemberian pendampingan rohani oleh tokoh agama, memfasilitasi praktik kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan pasien selama menjalani perawatan menunjukkan hubungan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien, khususnya pada area pelayanan paliatif dan perawatan penyakit kronis.

Selain dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, pendekatan spiritual juga memiliki dampak terhadap kepuasan pasien dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan. Saat petugas kesehatan mampu untuk memenuhi kebutuhan spiritual pasien, akan berdampak pada pasien secara langsung, dimana pasien yang merasa kebutuhan spiritualnya terpenuhi cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap pelayanan kesehatan serta meningkatkan tingkat kepercayaan yang lebih baik terhadap tenaga kesehatan. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan

oleh Azanaw et al., (2025) menemukan bahwa kemampuan yang baik dari petugas kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas *spiritual care* dan kepuasan yang dimiliki oleh pasien terhadap petugas kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa aspek spiritual dalam pelayanan kesehatan berbasis pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) bukan sekedar aktivitas tambahan ataupun pelengkap, melainkan komponen penting dalam proses asuhan kesehatan profesional.

Melalui pendekatan pada aspek spiritual juga turut mendukung praktik pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien (*patient centered care*), dimana dalam pendekatan spiritual, tenaga kesehatan melakukan perawatan dengan menghargai nilai, keyakinan, dan preferensi yang diyakini oleh pasien sehingga dapat membangun hubungan terapeutik yang lebih kuat, selain itu dengan pendekatan spiritual yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan asuhan kesehatan kepada pasien juga dapat meningkatkan komunikasi perawat dan pasien, serta memberikan ruang yang lebih kepada pasien melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait perawatan. Melalui penginterasian pendekatan spiritual dalam perawatan pasien dapat membantu tenaga kesehatan untuk dapat lebih memahami pasien secara lebih mendalam, tidak hanya dari aspek biologis saja, melainkan juga dari aspek spiritual terkait makna dan pengalaman hidup pasien (Espinell et al., 2022).

Secara keseluruhan pemberian asuhan kesehatan dengan mengintegrasikan aspek spiritual merupakan element penting dalam perawatan pasien secara holistik, dimana hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pasien, kualitas hidup, serta mutu pelayanan kesehatan. Meskipun manfaat pendekatan spiritual telah banyak dibuktikan, namun implementasinya pada pelayanan kesehatan masih kurang yang disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya perbedaan persepsi tenaga kesehatan mengenai konsep spiritualitas, serta keterbatasan waktu dari petugas kesehatan dalam penerapannya yang masih menjadi hambatan utama (Malviya et al., 2022). Oleh karena itu, pengintegrasian *spiritual care* secara sistematis dan profesional diharapkan dapat memperkuat praktek asuhan kesehatan yang humanis, beretika, dan berorientasi pada kebutuhan pasien secara menyeluruh.

G. Integrasi dan Implementasi Pendekatan Bio-Psiko-Sosial-Spiritual dalam Asuhan Kesehatan

Pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) merupakan paradigma asuhan kesehatan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang utuh dan kompleks. Dimana pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) menegaskan bahwa kondisi kesehatan dan penyakit yang diderita oleh pasien, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis semata, melainkan dipengaruhi oleh hal lain seperti kondisi psikologis, lingkungan sosial, serta dimensi spiritual. Pada pelaksanaan praktik asuhan kesehatan di era modern, pendekatan asuhan kesehatan berdasar teori bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) menunjukkan relevansi dengan kebutuhan saat ini seiring dengan meningkatnya prevalensi penyakit kronis, gangguan kesehatan mental, serta tuntutan terhadap pelayanan kesehatan yang berorientasi pada pasien atau *patient centered care*.

Integrasi model pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) dalam praktik asuhan kesehatan diawali dengan proses pengkajian yang dilakukan secara komprehensif, dimana pada saat melakukan pengkajian, tenaga kesehatan tidak hanya melakukan proses pemeriksaan fisik untuk menentukan masalah biologis saja, tetapi juga saat pengkajian petugas kesehatan perlu untuk mengeksplorasi kondisi psikologis pasien yang meliputi tingkat stress, kecemasan, depresi, dan mekanisme koping yang digunakan. Selain itu, petugas kesehatan juga perlu mengkaji faktor sosial seperti dukungan keluarga, kondisi ekonomi, peran sosial, serta lingkungan dan budaya pasien yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan asuhan kesehatan. Hal yang perlu dikaji dari segi dimensi spiritual dengan menggali nilai, keyakinan, makna hidup, serta sumber harapan pasien yang sering kali menjadi kekuatan utama dalam menghadapi penyakitnya (Koenig, 2015).

Hasil dari pengkajian yang dilakukan secara holistik selanjutnya menjadi dasar dalam proses penegakan diagnose yang nantinya akan menentukan bentuk intervensi yang disusun dalam rangkaian perencanaan asuhan kesehatan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa melalui pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) dapat melakukan suatu *assessment* secara holistik kepada pasien yang berdampak pada meningkatnya kualitas perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan, selain itu juga pengkajian secara holistik mampu meningkatkan interaksi dan komunikasi terapeutik antara petugas kesehatan dan pasien yang dimana hal ini akan sangat membantu dalam penyusunan rencana perawatan yang lebih memperhatikan kebutuhan individu secara menyeluruh (Afriyie, 2020).

Implementasi pelaksanaan dari pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS), mampu untuk mendorong tenaga kesehatan agar mengintegrasikan intervensi

medis yang selama ini selalu diberikan dengan dukungan psikologis, sosial, dan spiritual secara bersama. Hal ini dapat terlihat pada pasien dengan penyakit kronis seperti kanker, diabetes, atau penyakit kardiovaskuler, dimana pada aspek biologis diberikan perawatan berupa terapi farmakologis serta tindakan medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien, hal ini akan lebih efektif dalam menunjang proses penyembuhan pasien ketika didukung oleh intervensi psikologis seperti konseling, edukasi kesehatan, serta penguatan motivasi pasien (Büssing et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar pasien, serta pemenuhan akan kebutuhan spiritual yang baik menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, kemampuan pasien dalam mengendalikan gejala penyakitnya, serta meningkatnya kualitas hidup dari pasien (Bozek et al., 2020).

Dampak dari penerapan pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) tidak hanya dirasakan oleh pasien saja, namun juga berdampak langsung pada sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan karena pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) menuntut penerapan praktik asuhan kesehatan menjadi lebih humanis, empatis, dan terjadi kolaborasi antarprofesi. Dalam penerapannya, tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki kompetensi komunikasi yang baik, kemampuan asesmen aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang baik, serta kesadaran akan budaya (peka budaya) dalam memberikan layanan asuhan kesehatan. Implementasi bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) dalam pelayanan asuhan kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pasien, pengambilan keputusan klinis yang lebih etis, serta mampu untuk menurunkan angka rawat kembali (*rehospitalisasi*) pada pasien dengan penyakit kronis (Roberts, 2023).

Ditinjau dari konteks kebijakan dan pendidikan kesehatan, pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) memiliki implikasi yang strategis jika diintegrasikan kedalam kurikulum pendidikan tenaga kesehatan khususnya keperawatan dan kedokteran. Hal ini dimaksudkan guna untuk membekali tenaga profesional kesehatan dengan pendekatan holistik sejak dini. Selain itu, institusi pelayanan kesehatan perlu untuk mengembangkan pedoman dan kebijakan yang guna untuk mendukung proses pelaksanaan asuhan kesehatan berbasis bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS), yang dimana didalamnya termasuk tersedianya layanan konseling, dukungan sosial, dan pemberian pendampingan spiritual secara terstruktur dan berkelanjutan serta berlandaskan akan etika (Vermette & Doolittle, 2022).

Pengintegrasian pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) dalam praktik asuhan kesehatan merupakan landasan penting untuk menciptakan bentuk pelayanan kesehatan yang komprehensif, holistik, dan menjadikan pasien sebagai pusat layanan secara menyeluruh (*patient centered care*) dengan menegaskan

bahwa keberhasilan asuhan kesehatan yang diberikan, tidak hanya diukur dari kesembuhan fisik semata, tetapi juga dari tingkat kemampuan pasien untuk bisa beradaptasi, menemukan makna dari kondisi sakitnya, dan pasien mampu untuk mempertahankan kualitas hidup secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual (BPSS) bukan hanya sekedar konsep teoritis saja, melainkan sebuah kebutuhan nyata dalam praktik asuhan kesehatan saat ini.

H. Simpulan

Pendekatan Bio-Psiko-Sosial-Spiritual (BPSS) menegaskan bahwa asuhan kesehatan yang berkualitas harus memandang pasien sebagai manusia/individu yang utuh, dimana aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual saling berinteraksi dalam menentukan status kesehatan dan penyakit. Pendekatan BPSS hadir sebagai respon atas keterbatasan model biomedis yang berfokus pada aspek fisik semata, dimana dalam pendekatan BPSS memperluas pemahaman bahwa proses penyembuhan dan kualitas hidup pasien dipengaruhi oleh berbagai dimensi kehidupan manusia.

Pada praktik pemberian asuhan kesehatan, aspek biologis berperan sebagai landasan utama dalam pengkajian klinis dan pemberian intervensi medis, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis pasien, dukungan sosial, serta kekuatan spiritual yang dimiliki oleh pasien. Penggabungan keempat aspek tersebut memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan asuhan yang lebih komprehensif, manusiawi, dan berorientasi pada kebutuhan individu pasien, terutama dalam menghadapi penyakit kronis, kondisi terminal, dan permasalahan kesehatan yang kompleks.

Penerapan pendekatan BPSS menuntut bentuk pengkajian secara holistik, perencanaan intervensi kesehatan secara individual dan kontekstual, serta kolaborasi multidisiplin ilmu yang berkesinambungan. Melalui pengintegrasian pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual dalam praktik pelayanan kesehatan, diharapkan tidak hanya berfokus pada kesembuhan fisik, tetapi juga pada kemampuan pasien untuk beradaptasi, menemukan makna hidup, serta mempertahankan kualitas hidup secara optimal. Oleh karena itu, pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan holistik dan perpusat pada pasien (*patient centered care*) di era pelayanan kesehatan modern.

I. Referensi

- Afriyie, D. (2020). Effective communication between nurses and patients: an evolutionary concept analysis. *British Journal of Community Nursing*, 25(9), 438–445. <https://doi.org/10.12968/bjcn.2020.25.9.438>
- Azanaw, Y. G., Woretaw, A. W., Azene, T., Ayele, D. G., Siyoum, T. M., Gebeyehu, T., Bazezew, K., Zeleke, K. A., Alemsht, E., Tsega, S. S., Dessie, M. T., Getahun, A. F., & Bazezew, A. M. (2025). Spiritual care competence and associated factors among nurses: a multi-center cross-sectional study. *BMC Nursing*, 24(1), 606. <https://doi.org/10.1186/s12912-025-03268-6>
- Best, M., Leget, C., Goodhead, A., & Paal, P. (2020). An EAPC white paper on multi-disciplinary education for spiritual care in palliative care. *BMC Palliative Care*, 19(1), 9. <https://doi.org/10.1186/s12904-019-0508-4>
- Borrell-Carrió, F., Suchman, A. L., & Epstein, R. M. (2004). The biopsychosocial model 25 years later: principles, practice, and scientific inquiry. *Annals of Family Medicine*, 2(6), 576–582. <https://doi.org/10.1370/afm.245>
- Božek, A., Nowak, P. F., & Blukacz, M. (2020). The Relationship Between Spirituality, Health-Related Behavior, and Psychological Well-Being. *Frontiers in Psychology*, 11, 1997. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01997>
- Broadbent, E., Wilkes, C., Koschwanez, H., Weinman, J., Norton, S., & Petrie, K. J. (2015). A systematic review and meta-analysis of the Brief Illness Perception Questionnaire. *Psychology & Health*, 30(11), 1361–1385. <https://doi.org/10.1080/08870446.2015.1070851>
- Brock, B. A., Mir, H., Flenaugh, E. L., Oprea-Ilie, G., Singh, R., & Singh, S. (2024). Social and Biological Determinants in Lung Cancer Disparity. *Cancers*, 16(3). <https://doi.org/10.3390/cancers16030612>
- Büssing, A., Recchia, D. R., Koenig, H., Baumann, K., & Frick, E. (2018). Factor Structure of the Spiritual Needs Questionnaire (SpNQ) in Persons with Chronic Diseases, Elderly and Healthy Individuals. *BMC Psychology*, 9(1), 1–11. <https://doi.org/10.3390/rel9010013>
- Chęć, M., & Michałowska, S. (2024). Cognitive behavioral therapy for adolescents with eating disorders, with particular regard to clinical perfectionism. *Psychiatria Polska*, 58(5), 773–788. <https://doi.org/10.12740/PP/175717>
- Compas, B. E., Jaser, S. S., Bettis, A. H., Watson, K. H., Gruhn, M. A., Dunbar, J. P., Williams, E., & Thigpen, J. C. (2017). Coping, emotion regulation, and psychopathology in childhood and adolescence: A meta-analysis and narrative review. *Psychological Bulletin*, 143(9), 939–991. <https://doi.org/10.1037/bul0000110>
- Delgado, C., Upton, D., Ranse, K., Furness, T., & Foster, K. (2017). Nurses' resilience and the emotional labour of nursing work: An integrative review of

- empirical literature. *International Journal of Nursing Studies*, 70, 71–88. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.02.008>
- Engel, G. L. (2012). The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. *Psychodynamic Psychiatry*, 40(3), 377–396. <https://doi.org/10.1521/pdps.2012.40.3.377>
- Espinel, J., Colautti, N., Reyes Donoso, M. M., López Saca, J. M., Riveros Rios, M. E., Mazzotti, U., Espín González, I. I., Mas, M., Rios, M., Ramos, L., Rodríguez Paz, M. A., Bonilla, P., & Delgado Guay, M. O. (2022). Competencies for quality spiritual care in palliative care in Latin America: from the Spirituality Commission of the Latin American Association for Palliative Care. *Annals of Palliative Medicine*, 11(10), 3247–3262. <https://doi.org/10.21037/apm-22-519>
- Gilbert, J. H. V, Yan, J., & Hoffman, S. J. (2010). A WHO report: framework for action on interprofessional education and collaborative practice. *Journal of Allied Health*, 39 Suppl 1, 196–197.
- Glajchen, M., Otis-Green, S., Berkman, C., & Portenoy, R. K. (2024). Educating Social Workers in Palliative and End-of-Life Care: Development and Implementation of a New National Training Program. *Journal of Palliative Medicine*, 27(5), 638–643. <https://doi.org/10.1089/jpm.2023.0516>
- Glenn, J., Kleinhenz, G., Smith, J. M. S., Chaney, R. A., Moxley, V. B. A., Donoso Naranjo, P. G., Stone, S., Hanson, C. L., Redelfs, A. H., & Novilla, M. L. B. (2024). Do healthcare providers consider the social determinants of health? Results from a nationwide cross-sectional study in the United States. *BMC Health Services Research*, 24(1), 271. <https://doi.org/10.1186/s12913-024-10656-2>
- Guzmán-Leguel, Y. M., & Rodríguez-Lara, S. Q. (2025). Assessment of Patients' Quality of Care in Healthcare Systems: A Comprehensive Narrative Literature Review. *Healthcare (Basel, Switzerland)*, 13(14). <https://doi.org/10.3390/healthcare13141714>
- Handayani, L., & Suryana, A. A. (2024). The Role of Social Support in Coping Strategies for Pulmonary Tuberculosis Patients: Literature Review. *The Indonesian Journal of Health Promotion*, 7(5), 1101–1107. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/mppki.v7i5.5018>
- Inamdar, A., Bugadannavar, P., Palled, M., Umarani, S., Salve, P., Gurupadayya, B., Patil, P., & Sharma, H. (2025). Biological determinants of blood-based biomarker levels in Alzheimer's disease: role of nutrition, inflammation, and metabolic factors. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 17, 1614962. <https://doi.org/10.3389/fnagi.2025.1614962>
- Kannan, S., & Gowri, S. (2020). Spiritual Care: Define and Redefine Self. *Journal of Religion and Health*, 59(1), 470–483. <https://doi.org/10.1007/s10943->

- Katon, W. J. (2011). Epidemiology and treatment of depression in patients with chronic medical illness. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 13(1), 7–23. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2011.13.1/wkaton>
- Koenig, H. G. (2015). Religion, spirituality, and health: a review and update. *Advances in Mind-Body Medicine*, 29(3), 19–26.
- Lewis, S. L., Dirksen, S. R., & Bucher, L. (2014). *Study Guide for Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems* (9th ed.). Elsevier Inc. <https://books.google.com/books?id=4VcMBAAAQBAJ&pgis=1>
- Lewis, S. L., Dirksen, S. R., Heitkemper, M. M., & Bucher, L. (2015). *Medical-surgical nursing; Assessment and management of clinical problems 4th Edn.* (fourth Edi). Elsevier Inc. <https://doi.org/617'.0231-dc23>
- Malviya, S., Zupan, B., & Meredith, P. (2022). Evidence of religious/spiritual singing and movement in mental health: A systematic review. *Complementary Therapies in Clinical Practice*, 47, 101567. <https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2022.101567>
- Morelli, V. (2023). Social Determinants of Health: An Overview for the Primary Care Provider. *Primary Care*, 50(4), 507–525. <https://doi.org/10.1016/j.pop.2023.04.004>
- Novilla, M. L. B., Goates, M. C., Leffler, T., Novilla, N. K. B., Wu, C.-Y., Dall, A., & Hansen, C. (2023). Integrating Social Care into Healthcare: A Review on Applying the Social Determinants of Health in Clinical Settings. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(19). <https://doi.org/10.3390/ijerph20196873>
- Puchalski, C. M., Vitillo, R., Hull, S. K., & Reller, N. (2014). Improving the spiritual dimension of whole person care: reaching national and international consensus. *Journal of Palliative Medicine*, 17(6), 642–656. <https://doi.org/10.1089/jpm.2014.9427>
- Roberts, A. (2023). The biopsychosocial model: Its use and abuse. *Medicine, Health Care, and Philosophy*, 26(3), 367–384. <https://doi.org/10.1007/s11019-023-10150-2>
- Suls, J., & Green, P. A. (2019). Multimorbidity in health psychology and behavioral medicine. In *Health psychology: official journal of the Division of Health Psychology, American Psychological Association* (Vol. 38, Issue 9, pp. 769–771). <https://doi.org/10.1037/hea0000783>
- Thumala, D., Gajardo, B., Gómez, C., Arnold-Cathalifaud, M., Araya, A., Jofré, P., & Ravera, V. (2020). Coping processes that foster accommodation to loss in old age. *Aging & Mental Health*, 24(2), 300–307.

<https://doi.org/10.1080/13607863.2018.1531378>

- Vermette, D., & Doolittle, B. (2022). What Educators Can Learn from the Biopsychosocial-Spiritual Model of Patient Care: Time for Holistic Medical Education. *Journal of General Internal Medicine*, 37(8), 2062–2066. <https://doi.org/10.1007/s11606-022-07491-8>
- Wood, A. R., Ross, L., & Wood, R. J. (2023). Motivational Interviewing and Chronic Care Management Using the Transtheoretical Model of Change. *Health & Social Work*, 48(4), 271–276. <https://doi.org/10.1093/hsw/hlad020>
- Wood LoBiondo, G., Haber, J., & Titler, M. G. (2019). *Evidence Based Practice For Nursing And Healthcare Quality Improvement*. Elsevier, Inc.
- Zhang, Y., Zhang, H., Ma, X., & Di, Q. (2020). Mental Health Problems during the COVID-19 Pandemics and the Mitigation Effects of Exercise: A Longitudinal Study of College Students in China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(10). <https://doi.org/10.3390/ijerph17103722>

CHAPTER 3

ASUHAN KEPERAWATAN HOLISTIK DALAM BERBAGAI TATANAN PELAYANAN

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan global pada abad ke-21 menghadapi dinamika yang semakin kompleks sebagai konsekuensi dari perubahan demografis, epidemiologis, sosial, dan ekonomi. Peningkatan usia harapan hidup, transisi epidemiologi menuju dominasi penyakit kronis dan degeneratif, serta meningkatnya prevalensi kondisi multimorbiditas menuntut sistem pelayanan kesehatan yang mampu memberikan asuhan jangka panjang, berkesinambungan, dan bermakna bagi individu dan keluarga. Namun demikian, berbagai sistem kesehatan di dunia masih didominasi oleh pendekatan biomedis yang reduksionistik, terfragmentasi, dan berorientasi institusi, sehingga sering kali gagal merespons kebutuhan manusia secara utuh.

World Health Organization menegaskan bahwa fragmentasi pelayanan kesehatan merupakan salah satu penyebab utama rendahnya mutu, keselamatan, dan pengalaman pasien dalam sistem kesehatan modern. Pelayanan yang terkotak-kotak antar tingkat dan antar profesi tidak hanya meningkatkan biaya dan inefisiensi, tetapi juga melemahkan kesinambungan asuhan serta mengurangi peran aktif individu dan keluarga dalam pengelolaan kesehatannya. Kondisi ini mendorong WHO untuk mengembangkan *Framework on Integrated, People-Centred Health Services* sebagai strategi global dalam mentransformasi sistem pelayanan kesehatan menuju pendekatan yang lebih holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada manusia (SETNEG, 2009; WHO, 2016).

Pendekatan *people-centred* yang dikembangkan WHO tidak hanya menekankan perubahan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan, tetapi juga menuntut pergeseran paradigma fundamental mengenai cara sistem kesehatan memandang individu. Individu tidak lagi diposisikan sebagai penerima pasif layanan, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki nilai, preferensi, kapasitas, serta hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatannya. Dalam konteks ini, pelayanan kesehatan dipahami sebagai proses relasional yang berlangsung secara berkesinambungan, bukan sekadar rangkaian tindakan klinis yang terpisah-pisah.

Pendekatan holistik dan humanistik menjadi inti dari transformasi paradigma tersebut. Pendekatan holistik memandang manusia sebagai kesatuan yang utuh, di mana dimensi biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan budaya saling berinteraksi dan membentuk pengalaman kesehatan dan penyakit. Sementara itu, pendekatan humanistik menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, empati, relasi terapeutik, serta pengakuan terhadap makna subjektif yang dilekatkan individu pada pengalaman sakit dan sehat. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dan menjadi fondasi filosofis dalam pengembangan pelayanan kesehatan yang berpusat pada manusia.

Dalam konteks Indonesia, paradigma kesehatan holistik telah diadopsi secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Definisi ini menegaskan bahwa pembangunan kesehatan nasional tidak hanya berorientasi pada aspek kuratif, tetapi juga mencakup dimensi psikososial dan spiritual sebagai bagian integral dari kesejahteraan manusia (SETNEG, 2009).

Sebagai bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan, keperawatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan pendekatan holistik dan humanistik tersebut. Keperawatan merupakan profesi yang secara inheren berorientasi pada asuhan berkelanjutan dan relasi terapeutik, serta memiliki jangkauan praktik yang luas di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Perawat hadir dalam seluruh fase perjalanan kesehatan individu, mulai dari upaya promotif dan preventif, pelayanan kuratif dan rehabilitatif, hingga perawatan paliatif dan akhir kehidupan. Dengan karakteristik tersebut, keperawatan memiliki posisi unik sebagai penghubung antara kebijakan kesehatan, sistem pelayanan, dan pengalaman nyata individu serta keluarga dalam menerima asuhan.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai asuhan keperawatan holistik dalam berbagai tatanan pelayanan menjadi relevan dan penting dalam mendukung transformasi sistem pelayanan kesehatan yang berpusat pada manusia. Book chapter ini bertujuan untuk menguraikan secara konseptual, reflektif, dan sistemik mengenai asuhan keperawatan holistik, dengan mengintegrasikan kerangka kebijakan global WHO, teori keperawatan humanistik, serta regulasi dan praktik keperawatan di Indonesia.

B. Konsep dan Prinsip Asuhan Keperawatan Holistik

1. Paradigma Holistik dalam Pelayanan Kesehatan

Pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan berangkat dari pandangan bahwa manusia tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah berdasarkan komponen biologis semata. Kesehatan dan penyakit merupakan fenomena multidimensional yang dibentuk oleh interaksi kompleks antara kondisi fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan budaya. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan yang hanya berfokus pada diagnosis penyakit dan intervensi medis berisiko mengabaikan dimensi penting dari pengalaman manusia sebagai subjek perawatan (Duffy, 2009; McKenna, H., Pajnkhar, M., & Murphy, 2013).

World Health Organization menegaskan bahwa sistem pelayanan kesehatan yang terfragmentasi dan berorientasi penyakit tidak lagi memadai dalam menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat modern. Melalui kerangka *Integrated, People-Centred Health Services*, WHO mendorong pergeseran paradigma dari pelayanan yang berfokus pada institusi dan penyakit menuju pelayanan yang berfokus pada manusia secara utuh, berkesinambungan, dan terintegrasi lintas tatanan pelayanan (WHO, 2015, 2016).

Paradigma holistik menempatkan individu sebagai subjek aktif yang memiliki nilai, preferensi, dan kapasitas untuk terlibat dalam pengelolaan kesehatannya. Dalam kerangka ini, pelayanan kesehatan dipahami sebagai proses relasional yang berlangsung sepanjang daur kehidupan, bukan sekadar rangkaian tindakan klinis yang terpisah-pisah. Konsekuensinya, tenaga kesehatan—termasuk perawat—dituntut untuk mengembangkan cara pandang dan praktik yang mampu merespons kebutuhan manusia secara menyeluruh dan kontekstual.

2. Pendekatan Reduksionistik dan Keterbatasannya

Pendekatan reduksionistik dalam pelayanan kesehatan berakar pada model biomedis yang memandang penyakit sebagai gangguan biologis yang dapat diidentifikasi dan ditangani secara teknis. Pendekatan ini telah memberikan kontribusi besar dalam kemajuan ilmu kedokteran, khususnya dalam diagnosis dan terapi penyakit akut. Namun, dominasi pendekatan reduksionistik dalam sistem pelayanan kesehatan modern juga menimbulkan berbagai keterbatasan.

Pelayanan yang berfokus pada penyakit cenderung mengabaikan pengalaman subjektif individu, konteks sosial dan budaya, serta makna personal yang dilekatkan pada pengalaman sakit dan sehat. Akibatnya, individu sering kali diposisikan sebagai objek perawatan, bukan sebagai mitra dalam proses penyembuhan. Kondisi ini dapat menurunkan kepuasan pasien, melemahkan

keterlibatan keluarga, serta menghambat kesinambungan asuhan, khususnya pada kondisi kronis dan perawatan jangka panjang.

WHO menegaskan bahwa fragmentasi pelayanan dan dominasi pendekatan penyakit berkontribusi pada meningkatnya inefisiensi sistem kesehatan, rendahnya mutu pelayanan, serta pengalaman negatif pengguna layanan. Oleh karena itu, pendekatan holistik dipandang sebagai koreksi konseptual dan praktis terhadap keterbatasan pendekatan reduksionistik, dengan menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan kesehatan.

3. Pendekatan Humanistik sebagai Fondasi Etik Keperawatan

Pendekatan holistik dalam keperawatan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai humanistik yang menempatkan martabat manusia sebagai inti praktik profesional. Pendekatan humanistik menekankan bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang harus dihormati, terlepas dari kondisi kesehatan, status sosial, atau kapasitas fungsionalnya. Dalam konteks ini, pelayanan keperawatan dipahami sebagai relasi moral dan etis antara perawat dan klien.

Nilai-nilai humanistik dalam keperawatan ditegaskan secara normatif melalui *ICN Code of Ethics for Nurses* yang disusun oleh International Council of Nurses. Kode etik ini menegaskan bahwa praktik keperawatan berakar pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap penderitaan manusia. Tanggung jawab perawat mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, serta pengurangan penderitaan dan promosi kematian yang bermartabat (ICN, 2021).

Pendekatan humanistik menuntut perawat untuk hadir secara autentik dalam relasi dengan klien, menunjukkan empati, mendengarkan secara aktif, serta menghormati nilai dan preferensi individu. Relasi terapeutik dalam perspektif humanistik tidak bersifat hierarkis, melainkan dialogis dan partisipatif, di mana perawat dan klien bersama-sama membangun makna dan tujuan asuhan.

Berangkat dari prinsip-prinsip etik universal yang dirumuskan dalam *International Council of Nurses Code of Ethics*, nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab profesional, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan individu serta masyarakat kemudian dikontekstualisasikan dalam praktik keperawatan nasional melalui **Kode Etik Keperawatan Indonesia**. Kode etik yang ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) tersebut merepresentasikan internalisasi dan penjabaran nilai etik global ke dalam norma, kewajiban, dan tanggung jawab profesional yang sesuai dengan sistem hukum, budaya, dan kebutuhan pelayanan kesehatan di Indonesia (PPNI, 2015). Dengan demikian, kode etik keperawatan Indonesia tidak berdiri terpisah dari kerangka etik internasional, melainkan

berfungsi sebagai panduan operasional yang menghubungkan prinsip etik universal ke dalam praktik keperawatan sehari-hari di berbagai tatanan pelayanan, sekaligus memberikan dasar perlindungan, pengawasan, dan penegakan etik bagi perawat Indonesia

4. Teori Caring Jean Watson dalam Keperawatan Holistik

Dalam ranah teori keperawatan, pendekatan humanistik diperkuat oleh teori *Human Caring* yang dikemukakan oleh Jean Watson. Watson memandang *caring* sebagai esensi keperawatan yang melampaui tindakan teknis dan prosedural. Caring dipahami sebagai proses transpersonal yang melibatkan kehadiran penuh, empati, dan komitmen moral perawat terhadap kesejahteraan manusia secara utuh.

Menurut Watson, tujuan utama keperawatan bukan sekadar penyembuhan penyakit (*curing*), tetapi fasilitasi penyembuhan menyeluruh (*healing*) yang mencakup dimensi fisik, emosional, dan spiritual. Relasi perawat–klien menjadi ruang utama terjadinya proses caring dan healing, di mana perawat hadir sebagai manusia yang merawat manusia lain, bukan sekadar pelaksana intervensi klinis (Duffy, 2009; Martha Raile Alligood, 2018).

Teori Watson memberikan landasan filosofis yang kuat bagi praktik keperawatan holistik dan menegaskan bahwa kualitas asuhan keperawatan sangat ditentukan oleh kualitas relasi terapeutik. Perspektif ini relevan dalam berbagai tatanan pelayanan, khususnya pada kondisi kronis, paliatif, dan perawatan jangka panjang, di mana dimensi makna, harapan, dan penerimaan menjadi sangat penting.

5. Person-Centred Nursing sebagai Model Operasional

Pendekatan holistik dan humanistik dalam keperawatan kontemporer diperkaya oleh model *person-centred nursing* yang dikembangkan oleh Brendan McCormack dan Tanya McCance (2010). Model ini menawarkan kerangka operasional yang menjembatani konsep *people-centred care* WHO dengan praktik keperawatan sehari-hari.

Model *person-centred nursing* terdiri atas empat komponen utama, yaitu *prerequisites* (kompetensi, nilai, dan reflektivitas perawat), *care environment* (lingkungan praktik yang mendukung), *care processes* (proses keperawatan yang berfokus pada relasi terapeutik), dan *person-centred outcomes* (luaran yang mencerminkan kesejahteraan dan pengalaman positif individu). Keempat komponen ini saling terkait dan menegaskan bahwa praktik keperawatan berpusat pada manusia tidak dapat dilepaskan dari konteks organisasi dan sistem pelayanan kesehatan (McCormack & McCance, 2010).

Model ini memperkuat pandangan bahwa keperawatan holistik bukan sekadar sikap individual perawat, tetapi praktik profesional yang membutuhkan dukungan sistemik, budaya organisasi yang humanistik, serta kepemimpinan yang berorientasi pada nilai kemanusiaan.

6. Asuhan Keperawatan Holistik dalam Konteks Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pendekatan holistik dalam keperawatan telah dilembagakan melalui kerangka regulasi dan standar profesi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi sejahtera secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Definisi ini memberikan dasar normatif bagi praktik keperawatan holistik di Indonesia.

Selain itu, Standar Kompetensi Perawat Indonesia dan Standar Profesi Perawat menegaskan bahwa pelayanan keperawatan mencakup pemenuhan kebutuhan bio-psiko-sosial-spiritual klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, keperawatan holistik di Indonesia bukan sekadar adopsi teori global, tetapi telah menjadi bagian integral dari praktik profesional yang diakui secara hukum dan etik.

7. Kontekstualisasi Prinsip Holistik dalam Standar Profesi Keperawatan Indonesia

Prinsip-prinsip asuhan keperawatan holistik dan humanistik yang dirumuskan dalam kerangka global tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi memerlukan kontekstualisasi agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik keperawatan nasional. Nilai-nilai universal seperti penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab profesional, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan individu yang ditegaskan dalam *International Council of Nurses Code of Ethics* menjadi landasan etik yang kemudian diterjemahkan ke dalam norma dan kewajiban profesional sesuai dengan sistem hukum dan konteks sosial budaya masing-masing negara.

Di Indonesia, proses kontekstualisasi tersebut diwujudkan melalui Kode Etik Keperawatan Indonesia dan Standar Kompetensi Perawat Indonesia yang ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Dokumen-dokumen ini menegaskan bahwa praktik keperawatan nasional berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia secara utuh, mencakup dimensi biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural, serta dilaksanakan secara etis, profesional, dan bertanggung gugat. Dengan demikian, pendekatan holistik dan humanistik dalam keperawatan tidak hanya merupakan adopsi teori global, tetapi telah dilembagakan sebagai standar profesi yang mengikat praktik keperawatan di Indonesia.

Keberadaan standar nasional tersebut memperlihatkan kesinambungan antara prinsip etik global dan praktik keperawatan di tingkat lokal.

Kontekstualisasi ini menjadi jembatan penting antara kerangka filosofis dan implementasi operasional asuhan keperawatan holistik, sekaligus memperkuat legitimasi praktik keperawatan sebagai profesi yang berperan strategis dalam sistem pelayanan kesehatan nasional.

C. Proses Keperawatan dalam Pendekatan Holistik

Proses keperawatan merupakan fondasi metodologis praktik keperawatan profesional yang memungkinkan perawat memberikan asuhan secara sistematis, ilmiah, dan bertanggung jawab. Dalam literatur keperawatan fundamental, proses keperawatan dipahami sebagai metode pemecahan masalah yang digunakan perawat untuk mengidentifikasi respons manusia terhadap masalah kesehatan, merencanakan intervensi yang sesuai, serta mengevaluasi hasil asuhan secara berkelanjutan. Potter dan Perry menegaskan bahwa proses keperawatan tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai kerangka berpikir kritis yang memandu pengambilan keputusan klinis dan refleksi profesional perawat (McKenna, H., Pajnkhar, M., & Murphy, 2013; Potter, P A dan Perry, 2012).

Dalam pendekatan holistik, proses keperawatan memperoleh makna yang lebih luas. Proses ini tidak semata-mata diarahkan untuk mengatasi gangguan fisiologis, tetapi juga untuk memahami pengalaman subjektif individu, dinamika psikososial, nilai spiritual, serta konteks budaya yang memengaruhi respons klien terhadap kondisi kesehatannya. Dengan demikian, proses keperawatan holistik menuntut perawat untuk mengintegrasikan pengetahuan klinis, sensitivitas interpersonal, dan kesadaran etis dalam setiap tahap asuhan.

1. Pengkajian Holistik sebagai Dasar Asuhan Keperawatan

Pengkajian merupakan tahap awal dan paling krusial dalam proses keperawatan holistik. Pengkajian holistik dilakukan dengan mengumpulkan data objektif dan subjektif yang mencerminkan kondisi biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan budaya klien. WHO menegaskan bahwa pemahaman terhadap kebutuhan, preferensi, dan nilai individu merupakan prasyarat utama dalam pelayanan kesehatan yang berpusat pada manusia. Tanpa pengkajian yang komprehensif, pelayanan kesehatan berisiko menjadi tidak relevan, tidak bermakna, dan tidak berkelanjutan (WHO, 2016).

Dalam konteks biologis, pengkajian mencakup kondisi fisik, status fungsional, dan parameter klinis yang relevan. Namun, pendekatan holistik menuntut perawat untuk melampaui data fisiologis dengan menggali kondisi psikologis seperti emosi, persepsi terhadap penyakit, mekanisme koping, serta tingkat stres. Dimensi sosial mencakup peran keluarga, dukungan sosial, kondisi ekonomi, serta lingkungan tempat tinggal klien. Sementara itu, dimensi spiritual

dan budaya berkaitan dengan keyakinan, nilai hidup, serta makna yang dilekatkan klien pada pengalaman sakit dan sehat.

Pengkajian holistik juga menuntut keterampilan komunikasi terapeutik dan kehadiran empatik dari perawat. Relasi perawat–klien dalam tahap pengkajian menjadi ruang awal terbangunnya kepercayaan dan kemitraan, yang merupakan prasyarat penting dalam praktik *person-centred nursing*.

2. Diagnosis Keperawatan sebagai Respons Manusia

Diagnosis keperawatan dalam pendekatan holistik dipahami sebagai pernyataan tentang respons manusia terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupan, bukan sekadar label masalah klinis. Perspektif ini sejalan dengan pandangan bahwa keperawatan berfokus pada manusia sebagai subjek yang mengalami kondisi kesehatan, bukan pada penyakit sebagai entitas biologis semata.

Dengan menggunakan diagnosis keperawatan, perawat mengintegrasikan data dari berbagai dimensi kehidupan klien untuk merumuskan masalah, risiko, atau kesiapan klien dalam mencapai kesehatan optimal. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi kebutuhan yang mungkin tidak tertangkap melalui diagnosis medis, seperti gangguan coping, distress spiritual, atau hambatan peran sosial. Diagnosis keperawatan dengan demikian menjadi instrumen penting dalam mewujudkan asuhan keperawatan holistik.

3. Perencanaan Asuhan Berbasis Kemitraan

Perencanaan asuhan dalam pendekatan holistik dilakukan melalui kemitraan antara perawat, klien, dan keluarga. WHO menekankan pentingnya *shared decision-making* dalam pelayanan kesehatan yang berpusat pada manusia, di mana individu dilibatkan secara aktif dalam menentukan tujuan dan rencana asuhan sesuai dengan nilai dan preferensinya (WHO, 2016).

Perencanaan asuhan holistik tidak hanya menetapkan tujuan klinis jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan tujuan jangka panjang yang berkaitan dengan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan klien. Dalam kerangka *person-centred nursing*, perencanaan asuhan dipandang sebagai proses dialogis yang menghargai pengetahuan dan pengalaman hidup klien, serta mengakui klien sebagai mitra dalam perawatan (McCormack & McCance, 2010).

4. Implementasi Asuhan Terintegrasi dan Berkesinambungan

Implementasi asuhan keperawatan holistik menuntut koordinasi dan integrasi pelayanan lintas profesi dan lintas tatanan. Perawat berperan sebagai koordinator asuhan yang memastikan bahwa intervensi yang diberikan konsisten, saling melengkapi, dan selaras dengan kebutuhan klien. Peran ini menjadi

semakin penting dalam sistem kesehatan yang kompleks, di mana klien sering kali berpindah antar tatanan pelayanan.

Pendekatan holistik juga menuntut perawat untuk hadir secara autentik dalam interaksi dengan klien. Dalam perspektif Jean Watson, kehadiran perawat yang penuh perhatian dan empati merupakan bagian integral dari proses *caring* dan *healing*. Dengan demikian, implementasi asuhan keperawatan holistik tidak hanya diukur dari ketepatan tindakan, tetapi juga dari kualitas relasi terapeutik yang terbangun.

5. Evaluasi Asuhan dan Pengalaman Klien

Evaluasi dalam pendekatan holistik mencakup penilaian terhadap luaran klinis, pengalaman klien, serta makna yang dirasakan klien dari proses asuhan yang diterima. WHO menekankan bahwa pengalaman pengguna layanan merupakan indikator penting mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, evaluasi asuhan keperawatan holistik harus mempertimbangkan aspek kepuasan, rasa aman, keterlibatan, dan penghormatan terhadap martabat klien.

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan proses keperawatan holistik ditegaskan melalui Standar Kompetensi Perawat Indonesia serta PMK Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan, yang menegaskan bahwa praktik keperawatan dilaksanakan secara profesional, bertanggung gugat, dan sesuai kompetensi perawat.

D. Asuhan Keperawatan Holistik dalam Berbagai Tatanan Pelayanan

Asuhan keperawatan holistik tidak dilaksanakan dalam ruang yang homogen, melainkan dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan yang memiliki karakteristik, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda. WHO menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang berpusat pada manusia harus menjamin kesinambungan asuhan lintas tatanan pelayanan, mulai dari promotif dan preventif hingga paliatif, sepanjang daur kehidupan individu (WHO, 2015, 2016). Dalam kerangka ini, perawat memiliki peran strategis sebagai penghubung yang memastikan bahwa asuhan tetap holistik dan bermakna di setiap tatanan pelayanan.

1. Tatanan Pelayanan Promotif dan Preventif

Dalam tatanan promotif dan preventif, asuhan keperawatan holistik berfokus pada pemberdayaan individu, keluarga, dan komunitas untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *people-centred care* yang menempatkan individu dan komunitas sebagai aktor utama dalam pengelolaan kesehatan.

Perawat dalam tatanan ini berperan sebagai edukator, fasilitator, dan mitra masyarakat. Edukasi kesehatan tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi,

tetapi juga membangun pemahaman, kesadaran, dan motivasi individu untuk melakukan perubahan perilaku. Pendekatan holistik menuntut perawat untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam merancang intervensi promotif dan preventif.

2. Tatanan Pelayanan Kuratif

Dalam tatanan kuratif, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat sekunder dan tersier, asuhan keperawatan holistik sering kali menghadapi tantangan fragmentasi pelayanan dan dominasi pendekatan biomedis. Namun, pendekatan *person-centred nursing* menegaskan bahwa meskipun berada dalam lingkungan yang teknologis dan berorientasi tindakan, perawat tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga relasi terapeutik dan memperhatikan pengalaman subjektif pasien.

Perawat berperan dalam memastikan bahwa intervensi medis terintegrasi dengan dukungan psikososial, komunikasi yang empatik, serta keterlibatan keluarga dalam perawatan. Pendekatan ini membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan pemahaman pasien terhadap kondisinya, serta memperkuat rasa kontrol dan partisipasi pasien dalam proses perawatan.

3. Tatanan Pelayanan Rehabilitatif

Pelayanan rehabilitatif menuntut pendekatan holistik yang berorientasi pada fungsi, kemandirian, dan kualitas hidup. WHO menekankan bahwa rehabilitasi merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan dan harus tersedia bagi individu dengan kondisi kronis, disabilitas, atau keterbatasan fungsional.

Dalam tatanan rehabilitatif, perawat berperan dalam mendukung adaptasi individu terhadap perubahan kondisi kesehatan, memfasilitasi pembelajaran keterampilan baru, serta memperkuat dukungan keluarga dan komunitas. Pendekatan holistik memungkinkan perawat untuk melihat rehabilitasi tidak hanya sebagai pemulihan fungsi fisik, tetapi juga sebagai proses penyesuaian psikososial dan spiritual.

4. Tatanan Pelayanan Paliatif

Pelayanan paliatif merupakan manifestasi paling nyata dari pendekatan holistik dan humanistik dalam keperawatan. Pelayanan ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa, melalui pengelolaan nyeri dan gejala, dukungan psikososial dan spiritual, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

WHO menegaskan bahwa pelayanan paliatif harus tersedia sepanjang daur kehidupan dan tidak terbatas pada fase akhir kehidupan. Dalam konteks ini, perawat berperan sebagai pendamping yang hadir secara empatik, membantu

individu dan keluarga menghadapi penderitaan, serta mendukung proses pengambilan keputusan yang bermakna terkait perawatan akhir kehidupan (WHO, 2016).

Di Indonesia, standar pelayanan keperawatan di rumah sakit khusus menegaskan bahwa asuhan keperawatan mencakup pemenuhan kebutuhan bio-psiko-sosial-spiritual pasien. Kerangka regulasi ini memberikan dasar operasional bagi implementasi asuhan keperawatan holistik dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

E. Peran dan Kompetensi Perawat dalam Asuhan Keperawatan Holistik

Transformasi pelayanan kesehatan menuju pendekatan holistik dan berpusat pada manusia menuntut peran perawat yang semakin kompleks dan strategis. WHO menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *integrated, people-centred health services* sangat bergantung pada kapasitas tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam menerjemahkan kebijakan dan kerangka sistem ke dalam praktik pelayanan sehari-hari (WHO, 2016). Dalam konteks ini, perawat tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana tindakan klinis, tetapi sebagai aktor kunci dalam menjaga kesinambungan asuhan, membangun relasi terapeutik, serta mengoordinasikan pelayanan lintas tatanan dan lintas profesi.

1. Peran Profesional Perawat dalam Pendekatan Holistik

Dalam pendekatan holistik, perawat menjalankan berbagai peran profesional yang saling terkait. Peran sebagai *caregiver* diwujudkan melalui pemberian asuhan langsung yang mempertimbangkan kebutuhan bio-psiko-sosial-spiritual klien. Peran ini menuntut kemampuan klinis yang kuat sekaligus sensitivitas interpersonal untuk memahami pengalaman subjektif klien. Pendekatan *person-centred nursing* menegaskan bahwa kualitas asuhan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan tindakan, tetapi juga oleh kualitas hubungan perawat–klien yang terbangun (McCormack & McCance, 2010).

Selain sebagai pemberi asuhan, perawat juga berperan sebagai edukator yang mendukung pemberdayaan individu dan keluarga. Edukasi dalam perspektif holistik tidak terbatas pada penyampaian informasi medis, tetapi juga mencakup fasilitasi pemahaman, penguatan kapasitas coping, serta dukungan terhadap pengambilan keputusan yang selaras dengan nilai dan preferensi klien. Peran edukator ini menjadi semakin penting dalam konteks penyakit kronis dan perawatan jangka panjang, di mana keberhasilan asuhan sangat bergantung pada keterlibatan aktif klien dan keluarga.

Peran advokasi juga merupakan elemen penting dalam praktik keperawatan holistik. Kode Etik Perawat Internasional menegaskan bahwa perawat memiliki

tanggung jawab untuk melindungi hak, martabat, dan kepentingan klien, serta memperjuangkan keadilan sosial dan pemerataan akses pelayanan kesehatan (ICN, 2021). Dalam praktik, peran advokasi diwujudkan melalui upaya memastikan bahwa suara klien didengar dalam proses pengambilan keputusan klinis dan kebijakan pelayanan.

2. Kerangka Kompetensi Perawat Indonesia dalam Asuhan Keperawatan Holistik

Asuhan keperawatan holistik tidak dapat dilepaskan dari kompetensi profesional perawat sebagai pelaku utama praktik keperawatan. Kompetensi perawat menentukan sejauh mana prinsip holistik dan humanistik dapat diterjemahkan ke dalam tindakan keperawatan yang bermutu, aman, dan bermakna bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kompetensi tersebut dirumuskan secara normatif melalui *Standar Kompetensi Perawat Indonesia* yang ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI, AIPNI, 2023).

Standar kompetensi ini menempatkan perawat sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif dengan memperhatikan dimensi biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan kultural klien. Dengan demikian, kerangka kompetensi perawat Indonesia secara substansial telah selaras dengan prinsip *people-centred care* dan pendekatan holistik–humanistik dalam pelayanan kesehatan.

a. Kompetensi Etik, Profesional, dan Legal

Kompetensi etik dan profesional merupakan fondasi utama praktik keperawatan holistik. Perawat dituntut untuk menjalankan praktik sesuai dengan kode etik, menghormati martabat dan hak klien, menjaga kerahasiaan, serta bertindak sesuai kewenangan dan peraturan perundangan. Dalam perspektif holistik, kompetensi ini memastikan bahwa asuhan keperawatan tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga benar secara moral dan manusiawi. Hubungan perawat–klien dibangun atas dasar kepercayaan, penghormatan, dan tanggung jawab profesional, sehingga menciptakan relasi terapeutik yang mendukung proses penyembuhan secara menyeluruh.

b. Kompetensi Pemberian Asuhan Keperawatan Holistik

Standar kompetensi perawat Indonesia menegaskan kemampuan perawat dalam melaksanakan proses keperawatan secara komprehensif dan berkesinambungan. Kompetensi ini mencakup pengkajian kebutuhan klien secara menyeluruh, penetapan diagnosis keperawatan sebagai respons manusia, perencanaan dan implementasi intervensi keperawatan, serta evaluasi hasil asuhan. Dalam pendekatan holistik, proses keperawatan tidak hanya diarahkan pada pemulihan fungsi fisik, tetapi juga pada penguatan

aspek psikologis, dukungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan spiritual klien. Kompetensi ini memungkinkan perawat untuk memberikan asuhan yang berorientasi pada kualitas hidup dan kesejahteraan klien secara utuh.

c. Kompetensi Komunikasi Terapeutik dan Kemitraan

Asuhan keperawatan holistik menuntut kemampuan komunikasi terapeutik yang efektif dan empatik. Standar kompetensi perawat Indonesia menekankan pentingnya komunikasi sebagai sarana membangun hubungan profesional, memberikan edukasi kesehatan, serta melibatkan klien dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Kompetensi komunikasi ini menjadi landasan praktik *shared decision-making* dan kemitraan perawat–klien, di mana klien diposisikan sebagai subjek aktif dalam proses perawatan. Melalui komunikasi terapeutik, perawat dapat memahami pengalaman subjektif klien dan menyesuaikan asuhan dengan nilai serta preferensi individu.

d. Kompetensi Kolaborasi dan Koordinasi Pelayanan

Pelayanan kesehatan holistik dan terintegrasi tidak dapat dilaksanakan secara individual. Oleh karena itu, standar kompetensi perawat Indonesia menegaskan kemampuan perawat dalam bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain serta berkoordinasi lintas unit dan lintas tatanan pelayanan. Kompetensi kolaborasi ini memperkuat peran perawat sebagai penghubung dalam sistem pelayanan kesehatan, yang memastikan kesinambungan asuhan dan konsistensi rencana perawatan. Dalam praktik, kompetensi ini mendukung implementasi pelayanan kesehatan terintegrasi dan berpusat pada manusia.

e. Kompetensi Pengembangan Diri dan Refleksi Praktik

Kompetensi pengembangan diri dan profesional menegaskan bahwa perawat merupakan pembelajar sepanjang hayat. Standar kompetensi perawat Indonesia mendorong perawat untuk melakukan refleksi praktik, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta berpartisipasi dalam pengembangan mutu pelayanan keperawatan. Dalam konteks asuhan keperawatan holistik, kompetensi ini penting untuk memastikan bahwa praktik keperawatan tetap adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dinamika kebutuhan klien, dan tuntutan sistem pelayanan kesehatan yang terus berubah.

Tabel 3.1 Ringkasan Kompetensi Perawat Indonesia dalam Asuhan Keperawatan Holistik

Area Kompetensi	Rumusan Kompetensi Utama	Relevansi dengan Asuhan Keperawatan Holistik
Etik, Profesional, dan Legal	Praktik sesuai kode etik, menghormati martabat dan hak klien, bertanggung gugat	Menjamin pendekatan humanistik dan perlindungan martabat manusia
Asuhan Keperawatan	Penerapan proses keperawatan secara komprehensif dan berkesinambungan	Pemenuhan kebutuhan bio–psiko–sosio–spiritual klien
Komunikasi Terapeutik	Komunikasi empatik, edukatif, dan partisipatif	Mendukung <i>person-centred care</i> dan kemitraan
Kolaborasi dan Koordinasi	Kerja sama interprofesional dan kesinambungan asuhan	Mendukung pelayanan kesehatan terintegrasi
Pengembangan Diri Profesional	Refleksi praktik dan pembelajaran berkelanjutan	Menjaga kualitas dan keberlanjutan praktik holistik

3. Kolaborasi Interprofesional dan Kepemimpinan Klinis

Pendekatan holistik juga menuntut kemampuan perawat dalam bekerja secara kolaboratif dengan tenaga kesehatan lain serta sektor terkait. WHO menegaskan bahwa koordinasi dan kolaborasi lintas profesi merupakan elemen kunci dalam pelayanan kesehatan terintegrasi. Dalam konteks ini, perawat berperan sebagai penghubung yang memastikan bahwa pelayanan yang diterima klien tetap koheren dan berkesinambungan lintas tatanan.

Selain itu, perawat dituntut memiliki kepemimpinan klinis yang memungkinkan mereka berperan aktif dalam pengambilan keputusan, peningkatan mutu pelayanan, serta advokasi perubahan sistem yang mendukung praktik holistik. Kepemimpinan klinis ini tidak selalu bersifat struktural, tetapi tercermin dalam kemampuan perawat memengaruhi praktik melalui teladan profesional, refleksi kritis, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Berangkat dari uraian mengenai peran dan kompetensi perawat dalam asuhan keperawatan holistik, terlihat bahwa secara normatif dan profesional perawat Indonesia telah memiliki landasan yang kuat untuk menerapkan pendekatan holistik dan humanistik di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Namun, keberadaan kerangka kompetensi dan standar profesi tidak secara otomatis menjamin terwujudnya praktik holistik secara optimal di lapangan. Implementasi kompetensi tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor individu, organisasi, dan sistem pelayanan kesehatan yang lebih luas. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan asuhan keperawatan holistik, serta strategi penguatan yang

diperlukan agar kompetensi perawat dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan dalam praktik keperawatan sehari-hari.

F. Tantangan dan Penguatan Implementasi Asuhan Keperawatan Holistik

Meskipun pendekatan holistik dan humanistik diakui sebagai paradigma ideal dalam pelayanan kesehatan, implementasinya di berbagai tatanan pelayanan masih menghadapi sejumlah tantangan. WHO mengidentifikasi fragmentasi sistem pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia, serta model pembiayaan dan tata kelola yang belum sepenuhnya mendukung integrasi sebagai hambatan utama dalam penerapan pelayanan kesehatan berpusat pada manusia (WHO, 2015, 2016).

1. Tantangan pada Tingkat Individu dan Praktik

Pada tingkat praktik, perawat sering menghadapi beban kerja yang tinggi, keterbatasan waktu, serta tuntutan administratif yang menyulitkan penerapan pendekatan holistik secara optimal. Kondisi ini dapat mengurangi kesempatan perawat untuk membangun relasi terapeutik yang bermakna dan melakukan pengkajian holistik secara mendalam. Selain itu, perbedaan tingkat kompetensi dan pemahaman terhadap konsep holistik juga dapat memengaruhi konsistensi praktik keperawatan di lapangan.

2. Tantangan pada Tingkat Organisasi dan Sistem

Pada tingkat organisasi, fragmentasi antar unit dan antar tatanan pelayanan sering kali menghambat kesinambungan asuhan. Sistem rujukan yang belum optimal, keterbatasan sistem informasi kesehatan terintegrasi, serta budaya organisasi yang masih berorientasi tugas menjadi tantangan dalam mewujudkan pelayanan holistik. Hafiz dan kolega menunjukkan bahwa meskipun kerangka WHO IPCHS telah diadopsi secara konseptual, implementasi empirisnya masih terbatas dan belum merata di berbagai konteks negara.

Dalam konteks Indonesia, tantangan implementasi juga terkait dengan distribusi tenaga keperawatan, variasi kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, serta perbedaan kondisi geografis dan sosial budaya. Meskipun kerangka regulasi nasional telah mengakomodasi pendekatan holistik, penerapannya masih memerlukan penguatan pada tingkat operasional dan manajerial.

3. Strategi Penguatan Implementasi

WHO menekankan bahwa penguatan implementasi pelayanan holistik memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup penguatan kepemimpinan, tata kelola partisipatif, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, serta penciptaan lingkungan praktik yang mendukung. Pengembangan kompetensi perawat melalui pendidikan berkelanjutan, supervisi reflektif, dan budaya

pembelajaran organisasi menjadi strategi penting dalam mendukung praktik holistik.

Selain itu, penguatan kolaborasi lintas profesi dan lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi kesehatan, serta integrasi indikator pengalaman pasien dalam evaluasi mutu pelayanan dapat mendukung implementasi pendekatan holistik secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

G. Penutup

Asuhan keperawatan holistik dalam berbagai tatanan pelayanan merupakan manifestasi nyata dari transformasi sistem pelayanan kesehatan menuju pendekatan yang berpusat pada manusia. Pendekatan ini menuntut perubahan paradigma dari pelayanan yang terfragmentasi dan berorientasi penyakit menuju pelayanan yang terintegrasi, berkesinambungan, dan menghormati martabat manusia.

Dengan dukungan kerangka kebijakan global WHO, nilai etik profesi yang ditegaskan melalui ICN *Code of Ethics*, teori keperawatan humanistik, serta regulasi nasional Indonesia, keperawatan memiliki landasan konseptual, etik, dan hukum yang kuat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang holistik dan humanistik. Tantangan implementasi yang ada menuntut komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas perawat, sistem pelayanan, dan lingkungan praktik yang mendukung (ICN, 2021).

Melalui penguatan peran dan kompetensi perawat, kolaborasi interprofesional, serta dukungan kebijakan dan sistem yang memadai, asuhan keperawatan holistik diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan individu, keluarga, dan komunitas di berbagai tatanan pelayanan.

H. Daftar Pustaka

Duffy, J. R. (2009). *Quality Caring In Nursing*. Springer Publishing Company.

ICN. (2021). *THE ICN CODE OF ETHICS FOR NURSES International Council of Nurses. Code of Ethics for Nurses*. Retrieved from https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-06/ICN_Code-of-Ethics_EN_Web.pdf

Martha Raile Alligood. (2018). Nursing Theorists and their work. In *Elsevier* (pp. 1–618).

McCormack, B., & McCance, T. (2010). *Person-Centred Nursing Theory and Practice*. Blackwell Publishing was.

McKenna, H., Pajnkhar, M., & Murphy, F. (2013). *Fundamentals of Nursing Models, Theories and practice. Fundamentals of Nursing Models, Theory, and*

Practice. Retrieved from <http://www.amazon.co.uk/Fundamentals-Infection-Prevention-Control-Practice/dp/1118306651>

Potter, P A dan Perry, A. G. (2012). *Fundamentals of Nursing: Nursing today The history of modern nursing*.

PPNI. Kode Etik Keperawatan Indonesia (2015).

PPNI, AIPNI, Aipd. Standar Kompetensi perawat indonesia, Standar Kompetensi Perawat Indonesia 1–5 (2023).

SETNEG, R. (2009). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN D. *Sekretariat Negara RI*.

WHO. (2015). *WHO global strategy on integrated people-centred health services 2016-2026: executive summary. World Health Organization 2015*.

WHO. (2016). Framework on integrated people-centred health services. Report by the Secretariat. World Health Organization. Sixty-ninth World Health Assembly.WHA69.39. *Sixty-Ninth World Health Assembly, Provisiona*(April), 1–12.

I. Glosarium

Asuhan Keperawatan

Rangkaian kegiatan profesional yang diberikan oleh perawat kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan melalui pendekatan sistematis dan bertanggung jawab secara etik, hukum, dan profesional.

Asuhan Keperawatan Holistik

Pendekatan keperawatan yang memandang individu sebagai makhluk utuh dengan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual, dan budaya yang saling berinteraksi, serta memberikan asuhan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Caring

Inti praktik keperawatan yang menekankan hubungan relasional, empati, kehadiran autentik, dan komitmen moral perawat dalam merawat manusia secara utuh, melampaui tindakan teknis semata.

Continuity of Care (Kesinambungan Asuhan)

Prinsip pelayanan kesehatan yang memastikan individu menerima asuhan yang terkoordinasi dan berkesinambungan lintas waktu, tatanan pelayanan, dan penyedia layanan kesehatan.

Diagnosis Keperawatan

Pernyataan klinis mengenai respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan, yang menjadi dasar perencanaan intervensi keperawatan.

Etika Keperawatan

Prinsip moral dan nilai profesional yang membimbing perawat dalam memberikan asuhan, termasuk penghormatan terhadap martabat manusia, hak asasi, keadilan, dan tanggung jawab profesional.

Healing

Proses penyembuhan menyeluruh yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual individu, tidak terbatas pada hilangnya gejala penyakit.

Holistik

Pendekatan yang memandang manusia sebagai kesatuan utuh dan tidak terpisah-pisah, di mana berbagai dimensi kehidupan saling memengaruhi pengalaman kesehatan dan penyakit.

Humanistik

Pendekatan yang menempatkan martabat, nilai, makna, dan pengalaman subjektif manusia sebagai pusat praktik pelayanan kesehatan dan keperawatan.

Integrated Health Services (Pelayanan Kesehatan Terintegrasi)

Model pelayanan kesehatan yang mengoordinasikan berbagai jenis layanan kesehatan lintas tatanan dan lintas profesi untuk menjamin kesinambungan dan mutu asuhan.

International Council of Nurses (ICN)

Organisasi profesi perawat internasional yang menetapkan standar etik dan nilai profesional keperawatan secara global.

Kode Etik Perawat

Dokumen normatif yang menetapkan prinsip moral dan tanggung jawab profesional perawat dalam praktik keperawatan, termasuk promosi kesehatan dan pengurangan penderitaan.

Model Biomedis

Pendekatan pelayanan kesehatan yang berfokus pada aspek biologis penyakit dan intervensi medis, dengan keterbatasan dalam menjelaskan pengalaman subjektif dan konteks sosial pasien.

Paliatif

Pendekatan pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga yang menghadapi penyakit yang mengancam jiwa melalui pengelolaan gejala serta dukungan psikososial dan spiritual.

People-Centred Care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan individu, keluarga, dan komunitas sebagai pusat sistem kesehatan, serta menghormati nilai, preferensi, dan keterlibatan aktif mereka dalam pengambilan keputusan.

Person-Centred Nursing

Model praktik keperawatan yang menekankan hubungan terapeutik, keterlibatan aktif pasien, lingkungan praktik yang mendukung, dan luaran yang mencerminkan kesejahteraan serta pengalaman positif individu.

Proses Keperawatan

Kerangka kerja sistematis yang digunakan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan, meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Promotif

Upaya pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan kapasitas individu atau komunitas dalam menjaga kesehatannya.

Preventif

Upaya pelayanan kesehatan yang bertujuan mencegah terjadinya penyakit atau masalah kesehatan melalui intervensi dini dan pengendalian faktor risiko.

Rehabilitatif

Pelayanan kesehatan yang bertujuan memulihkan dan mempertahankan fungsi, kemandirian, serta kualitas hidup individu setelah mengalami gangguan kesehatan.

Reduksionistik

Cara pandang yang memahami masalah kesehatan dengan memecahnya menjadi komponen-komponen terpisah, terutama aspek biologis, tanpa mempertimbangkan konteks psikososial dan spiritual.

Shared Decision-Making

Proses pengambilan keputusan kesehatan yang melibatkan tenaga kesehatan dan pasien secara kolaboratif berdasarkan informasi, nilai, dan preferensi pasien.

Tatanan Pelayanan Kesehatan

Berbagai tingkat dan bentuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif.

World Health Organization (WHO)

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab dalam kepemimpinan global bidang kesehatan dan pengembangan kebijakan kesehatan internasional.

CHAPTER 4

PENDEKATAN GIZI HOLISTIK DALAM PEMELIHARAAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN

Dewi Mey Lestanti Mukodri, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Perubahan transisi epidemiologi global menunjukkan peningkatan signifikan penyakit tidak menular (PTM) sebagai penyebab utama kematian. *World Health Organization* (WHO, 2023) melaporkan bahwa 74% kematian global disebabkan oleh PTM seperti penyakit kardiovaskular, diabetes melitus, kanker, dan penyakit paru kronis. Pola makan tidak sehat menjadi salah satu determinan utama yang berkontribusi terhadap beban penyakit tersebut.

Global Burden of Disease Study (Afshin et al., 2019) menyebutkan bahwa faktor risiko diet menyumbang lebih dari 11 juta kematian per tahun secara global. Konsumsi tinggi natrium, rendah buah dan sayur, serta peningkatan makanan ultra-proses merupakan determinan dominan. Temuan ini diperkuat oleh Monteiro et al. (2019) yang menunjukkan hubungan kuat antara konsumsi *ultra-processed food* dengan obesitas dan sindrom metabolik.

Di Indonesia, situasi serupa tercermin dalam Survei Kesehatan Indonesia (Kemenkes RI, 2023), yang menunjukkan peningkatan prevalensi obesitas, hipertensi, dan dislipidemia pada usia produktif. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi masalah stunting dan anemia, mencerminkan kondisi *double burden of malnutrition* (WHO, 2020).

Pendekatan gizi konvensional yang berfokus pada kecukupan zat gizi tunggal dinilai kurang memadai dalam menjawab kompleksitas penyakit modern. Katz dan Meller (2018) mengkritik pendekatan reduksionistik dalam ilmu gizi karena mengabaikan sinergi antar komponen pangan. Fardet dan Rock (2020) menekankan pentingnya melihat pangan sebagai *food matrix*, yaitu sistem kompleks yang bekerja secara terpadu.

Lebih lanjut, penelitian terbaru mengonfirmasi keterkaitan antara diet, mikrobiota usus, regulasi inflamasi, dan kesehatan mental melalui mekanisme gut-brain axis (Cryan et al., 2019; Tilg et al., 2020). Pendekatan nutrisi yang mempertimbangkan aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan inilah yang dikenal sebagai pendekatan gizi holistik. Dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan promotif dan preventif di Indonesia, pendekatan gizi holistik menjadi

relevan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan menuju paradigma yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

B. Landasan Teori Dan Kerangka Konseptual

Gizi holistik adalah pendekatan nutrisi yang memandang kesehatan sebagai hasil interaksi antara pola makan, metabolisme, mikrobiota, kesehatan mental, aktivitas fisik, serta determinan sosial (WHO, 2022). Prinsip utama meliputi *Whole-food based approach*, *Individualized nutrition therapy*, *Preventive orientation*, *Integration of lifestyle factors*, *Sustainability and food system awareness* (FAO & WHO, 2019).

Kritik terhadap Pendekatan Reduksionistik, Mozaffarian (2018) menyatakan bahwa rekomendasi berbasis satu nutrisi sering menimbulkan distorsi pola konsumsi. Contoh klasik adalah pengurangan lemak total yang justru meningkatkan konsumsi gula olahan. Pendekatan holistik menekankan pola makan secara keseluruhan (*dietary pattern*) dibanding fokus pada nutrisi Tunggal.

Model Konseptual Orisinal, terdapat Model Integratif 5 Dimensi antara lain Dimensi Biologis (metabolisme, inflamasi, hormon), Dimensi Mikrobiota dan Imunitas, Dimensi Psikososial, Dimensi Perilaku dan Gaya Hidup, Dimensi Lingkungan dan Keberlanjutan. Kelima dimensi berinteraksi dalam menentukan outcome kesehatan jangka panjang.

C. Mekanisme Biologis Dalam Pemeliharaan Kesehatan

Regulasi Inflamasi kronis tingkat rendah menjadi dasar PTM (Calder, 2020). Diet tinggi gula sederhana dan lemak jenuh meningkatkan sitokin proinflamasi. Sebaliknya, diet Mediterania terbukti menurunkan risiko kardiovaskular sebesar 30% (Estruch et al., 2018). Keanekaragaman mikrobiota dipengaruhi asupan serat dan pangan fermentasi. Cryan et al. (2019) menunjukkan hubungan mikrobiota dengan regulasi stres dan kecemasan.

Regulasi Metabolik menurut Reynolds et al. (2020) menunjukkan bahwa peningkatan asupan serat berhubungan dengan penurunan risiko diabetes tipe 2 dan mortalitas kardiovaskular. Sedangkan untuk Regulasi Berat Badan Hall et al. (2019) membuktikan bahwa konsumsi *ultra-processed food* meningkatkan asupan kalori secara signifikan dibanding diet berbasis *whole food*.

D. Gizi Holistik Dalam Pemulihan Kesehatan

Pada Diabetes Mellitus, Pendekatan *plant-forward diet* meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan HbA1c (Ley et al., 2019). Pada Hipertensi, Diet DASH menurunkan tekanan darah sistolik 8–14 mmHg (AHA, 2021). Dan pada Dislipidemia, Omega-3 serta diet tinggi serat menurunkan trigliserida dan LDL (ESC Guidelines, 2021). Pemulihan Pasien Rawat Inap, menurut ESPEN (2023) menekankan pentingnya *individualized nutrition therapy* untuk mempercepat pemulihan dan menurunkan komplikasi.

E. Implementasi di Indonesia

1. Integrasi di Pelayanan Primer
 - a. Konseling keluarga berbasis pangan lokal
 - b. Edukasi ibu hamil untuk pencegahan stunting
 - c. Penguatan GERMAS
 - d. Monitoring PTM berbasis komunitas
2. Tantangan
 - a. Literasi gizi rendah
 - b. Urbanisasi dan perubahan pola konsumsi
 - c. Dominasi makanan ultra-proses
3. Strategi
 - a. Edukasi berbasis keluarga
 - b. Interprofessional collaboration
 - c. Integrasi kurikulum tenaga kesehatan
 - d. Kebijakan pangan sehat

Pendekatan gizi holistik memiliki potensi besar dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia. Namun, diperlukan antara lain Standarisasi pedoman praktik, Riset berbasis komunitas, Integrasi dengan program nasional, Monitoring *outcome* jangka Panjang. Pendekatan ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan 2 dan 3.

F. Simpulan

Pendekatan gizi holistik merupakan paradigma nutrisi komprehensif yang memandang kesehatan sebagai hasil interaksi antara pola makan, metabolisme, mikrobiota usus, faktor psikologis, perilaku hidup, serta lingkungan sosial dan keberlanjutan pangan. Berbasis bukti ilmiah terkini, pendekatan ini terbukti efektif dalam mendukung pemeliharaan kesehatan melalui pencegahan penyakit tidak

menular serta dalam mempercepat pemulihan pada berbagai kondisi metabolik dan kronis.

Berbeda dengan pendekatan reduksionistik yang berfokus pada zat gizi tunggal, gizi holistik menekankan pola makan berbasis pangan utuh (*whole food*), keseimbangan sistem tubuh, serta integrasi gaya hidup sehat. Mekanisme biologis seperti regulasi inflamasi, perbaikan sensitivitas insulin, peningkatan keberagaman mikrobiota, dan stabilisasi sistem neuroendokrin menjadi dasar ilmiah efektivitas pendekatan ini.

Dalam konteks Indonesia yang menghadapi beban gizi ganda, pendekatan gizi holistik memiliki relevansi strategis untuk memperkuat upaya promotif dan preventif di pelayanan kesehatan primer, pengendalian penyakit tidak menular, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Implementasinya memerlukan kolaborasi multidisiplin, penguatan literasi gizi, dan dukungan kebijakan pangan yang berorientasi pada kesehatan dan keberlanjutan.

Dengan demikian, pendekatan gizi holistik dapat menjadi kerangka konseptual dan operasional dalam transformasi sistem kesehatan menuju model pelayanan yang lebih integratif, preventif, dan berkelanjutan.

G. Referensi

- Afshin, A., Sur, P. J., Fay, K. A., Cornaby, L., Ferrara, G., Salama, J. S., Mullany, E. C., Abate, K. H., Abbafati, C., Abebe, Z., Afarideh, M., & Murray, C. J. L. (2019). Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *The Lancet*, 393(10184), 1958–1972.
- American Heart Association. (2021). 2021 dietary guidance to improve cardiovascular health: A scientific statement from the American Heart Association. *Circulation*, 144(23), e472–e487.
- Calder, P. C. (2020). Nutrition, immunity and inflammation: Implications for health and disease. *BMJ*, 369, m1573.
- Cryan, J. F., O’Riordan, K. J., Cowan, C. S. M., Sandhu, K. V., Bastiaanssen, T. F. S., Boehme, M., Codagnone, M. G., Cussotto, S., Fulling, C., Golubeva, A. V., & Dinan, T. G. (2019). The microbiota–gut–brain axis. *Physiological Reviews*, 99(4), 1877–2013.
- Estruch, R., Ros, E., Salas-Salvadó, J., Covas, M. I., Corella, D., Arós, F., Gómez-Gracia, E., Ruiz-Gutiérrez, V., Fiol, M., Lapetra, J., & Martínez-González, M. A. (2018). Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet supplemented with extra-virgin olive oil or nuts. *New England Journal of Medicine*, 378(25), e34.

- European Society of Cardiology. (2021). 2021 ESC guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *European Heart Journal*, 42(34), 3227–3337.
- Fardet, A., & Rock, E. (2020). Ultra-processed foods and food system sustainability: What are the links? *Nutrients*, 12(9), 2598.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations & World Health Organization. (2019). *Sustainable healthy diets: Guiding principles*. FAO.
- Hall, K. D., Ayuketah, A., Brychta, R., Cai, H., Cassimatis, T., Chen, K. Y., Chung, S. T., Costa, E., Courville, A., Darcey, V., & Fletcher, L. A. (2019). Ultra-processed diets cause excess calorie intake and weight gain: An inpatient randomized controlled trial. *Cell Metabolism*, 30(1), 67–77.e3.
- Jacka, F. N., O'Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohebbi, M., Castle, D., Dash, S., Mihalopoulos, C., & Berk, M. (2019). A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (SMILES). *BMC Medicine*, 17(1), 23.
- Katz, D. L., & Meller, S. (2018). Can we say what diet is best for health? *Annual Review of Public Health*, 39, 83–103.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*. Kementerian Kesehatan RI.
- Ley, S. H., Hamdy, O., Mohan, V., & Hu, F. B. (2019). Prevention and management of type 2 diabetes: Dietary components and nutritional strategies. *The Lancet*, 383(9933), 1999–2007.
- Monteiro, C. A., Cannon, G., Levy, R. B., Moubarac, J. C., Louzada, M. L. C., & Jaime, P. C. (2019). Ultra-processed foods: What they are and how to identify them. *Public Health Nutrition*, 22(5), 936–941.
- Mozaffarian, D. (2018). Dietary and policy priorities for cardiovascular disease, diabetes, and obesity. *Circulation*, 133(2), 187–225.
- Reynolds, A., Mann, J., Cummings, J., Winter, N., Mete, E., & Te Morenga, L. (2020). Carbohydrate quality and human health: A series of systematic reviews and meta-analyses. *The Lancet*, 393(10170), 434–445.
- Schwingshackl, L., Hoffmann, G., Lampousi, A. M., Knüppel, S., Iqbal, K., Schwedhelm, C., Bechthold, A., Schlesinger, S., & Boeing, H. (2018). Food groups and risk of chronic disease: A systematic review and dose–response meta-analysis. *American Journal of Clinical Nutrition*, 108(3), 576–586.
- Tilg, H., Zmora, N., Adolph, T. E., & Elinav, E. (2020). The intestinal microbiota fuelling metabolic inflammation. *Nature Reviews Immunology*, 20(1), 40–54.
- World Health Organization. (2020). *The double burden of malnutrition*. WHO.
- World Health Organization. (2022). *Healthy diet*. WHO Fact Sheets.
- World Health Organization. (2023). *Noncommunicable diseases progress monitor 2023*. WHO.

H. Glosarium

Anemia=Kondisi klinis yang ditandai dengan kadar hemoglobin dalam darah lebih rendah dari nilai normal sehingga menurunkan kapasitas pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh.

Antioksidan=Senyawa yang berfungsi menangkal radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif yang berkontribusi terhadap inflamasi dan penyakit kronis.

Asam Lemak Omega-3=Asam lemak tak jenuh ganda esensial yang berperan dalam regulasi inflamasi, fungsi kardiovaskular, dan kesehatan otak.

Calorie-Controlled Diet=Pola makan yang mengatur jumlah asupan energi sesuai kebutuhan individu untuk mencapai atau mempertahankan berat badan sehat.

Chronic Low-Grade Inflammation=Inflamasi tingkat rendah yang berlangsung lama dan menjadi mekanisme dasar berbagai penyakit tidak menular seperti diabetes dan penyakit jantung.

Diet DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension)=Pola makan yang dirancang untuk menurunkan tekanan darah dengan menekankan konsumsi buah, sayur, biji-bijian utuh, dan produk rendah lemak.

Diet Mediterania=Pola makan tradisional negara-negara Mediterania yang kaya sayur, buah, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan ikan, serta terbukti menurunkan risiko penyakit kardiovaskular.

Dislipidemia=Gangguan kadar lipid darah, termasuk peningkatan kolesterol total, LDL, trigliserida, atau penurunan HDL.

Double Burden of Malnutrition=Kondisi coexistence antara masalah gizi kurang (seperti stunting atau wasting) dan gizi lebih (obesitas) dalam satu populasi atau individu.

Evidence-Based Practice=Pendekatan praktik kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis, dan kebutuhan pasien.

Food Matrix=Konsep yang menjelaskan bahwa komponen dalam makanan bekerja secara sinergis dalam struktur alami pangan, bukan secara terpisah.

GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)=Program nasional Indonesia yang bertujuan meningkatkan perilaku hidup sehat melalui aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, dan pemeriksaan kesehatan berkala.

Gizi Holistik=Pendekatan nutrisi komprehensif yang mempertimbangkan interaksi antara pola makan, metabolisme, mikrobiota, faktor psikologis, sosial, dan lingkungan dalam mencapai kesehatan optimal.

Gut-Brain Axis=Sistem komunikasi dua arah antara saluran cerna dan otak yang dimediasi oleh sistem saraf, hormon, dan mikrobiota usus.

HbA1c (Hemoglobin A1c)=Indikator kadar gula darah rata-rata selama 2–3 bulan terakhir yang digunakan dalam diagnosis dan pemantauan diabetes.

Hipertensi=Kondisi tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau diastolik ≥ 90 mmHg secara persisten.

Individualized Nutrition Therapy=Pendekatan terapi gizi yang disesuaikan dengan kondisi klinis, kebutuhan metabolik, dan karakteristik individu.

Inflamasi=Respons biologis tubuh terhadap cedera atau infeksi yang ditandai dengan kemerahan, pembengkakan, panas, dan nyeri.

Insulin Resistance=Kondisi ketika sel tubuh tidak merespons insulin secara efektif sehingga kadar glukosa darah meningkat.

Interprofessional Collaboration=Kerja sama antara berbagai profesi kesehatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pasien.

Malnutrisi=Kondisi ketidakseimbangan asupan zat gizi, baik kekurangan maupun kelebihan, yang berdampak pada kesehatan.

Mikrobiota Usus=Komunitas mikroorganisme yang hidup dalam saluran cerna dan berperan dalam metabolisme, imunitas, serta regulasi sistem saraf.

Nutritional Screening=Proses identifikasi dini risiko malnutrisi pada individu atau pasien.

Obesitas=Kondisi kelebihan lemak tubuh yang ditandai dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 30 kg/m².

Pangan Ultra-Proses (Ultra-Processed Food)=Produk makanan industri yang mengalami proses pengolahan intensif dengan tambahan zat aditif seperti perisa, pewarna, dan pengawet.

Plant-Forward Diet=Pola makan yang menekankan konsumsi bahan pangan nabati tanpa sepenuhnya menghilangkan sumber hewani.

Preventif=Upaya pencegahan penyakit sebelum terjadi gangguan kesehatan.

Promotif=Upaya peningkatan derajat kesehatan melalui edukasi dan perubahan perilaku.

Resistensi Insulin=Gangguan respons sel terhadap insulin yang menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah.

Sarkopenia=Penurunan massa dan kekuatan otot yang umumnya terjadi pada usia lanjut.

Sustainable Healthy Diets=Pola makan yang mendukung kesehatan individu sekaligus menjaga keberlanjutan sistem pangan dan lingkungan.

Whole Food=Pangan utuh atau minimal proses yang mempertahankan struktur dan kandungan zat gizinya secara alami.

CHAPTER 5

KOMUNIKASI EFEKTIF ANTARA TENAGA KESEHATAN DAN PASIEN

Dr. Atik Badi'ah, S.Pd., M.Kes

A. Landasan Filosofis dan Konseptual

Pelayanan kesehatan modern telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan disease-centered care menuju patient-centered care. Dalam konteks ini, pasien tidak lagi dipandang sebagai objek perawatan, tetapi sebagai individu yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang saling terintegrasi. Pergeseran ini menuntut pendekatan pelayanan yang holistik dan humanistik. Salah satu elemen fundamental dalam pendekatan tersebut adalah komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien. Komunikasi yang efektif terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan pasien, kepatuhan terapi, keselamatan pasien (patient safety), serta penurunan kesalahan medis (Street et al., 2020; Levinson et al., 2023).

Dalam praktik keperawatan dan pelayanan kesehatan primer maupun sekunder, komunikasi bukan sekadar proses penyampaian informasi, tetapi merupakan proses terapeutik yang mempengaruhi kualitas hubungan profesional, kepercayaan, serta hasil klinis pasien.

1. Pendekatan Holistik dalam Pelayanan Kesehatan

Pendekatan holistik dalam pelayanan kesehatan berpijak pada pemahaman bahwa manusia merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan antara tubuh, pikiran, lingkungan sosial, dan nilai-nilai spiritual. Gangguan pada satu dimensi akan memengaruhi dimensi lainnya. Oleh karena itu, asuhan keperawatan dan pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan seluruh aspek tersebut secara terintegrasi.

Pendekatan holistik memandang manusia sebagai sistem utuh yang terdiri atas:

a. Dimensi biologis

Dimensi biologis mencakup seluruh aspek fisik dan fisiologis tubuh manusia, termasuk:

- 1) Struktur anatomi
- 2) Fungsi organ
- 3) Sistem metabolisme

- 4) Status nutrisi
- 5) Kondisi patologis
- 6) Respon imun
- 7) Faktor genetik

Pendekatan biologis berfokus pada diagnosis medis, pengobatan, tindakan keperawatan, dan pemantauan kondisi klinis pasien.

Dalam praktik klinik, dimensi biologis meliputi:

- 1) Pengkajian tanda vital
- 2) Pemeriksaan fisik
- 3) Pemeriksaan laboratorium
- 4) Intervensi farmakologis
- 5) Prosedur medis dan keperawatan

Namun dalam pendekatan holistik, aspek biologis tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan kondisi psikologis dan sosial pasien.

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit:

Pasien pasca operasi appendektomi:

Pendekatan biologis:

- 1) Monitoring tekanan darah, suhu, nadi
- 2) Observasi luka operasi
- 3) Pemberian antibiotik dan analgesik

Pendekatan holistik:

Selain tindakan fisik, perawat juga:

- 1) Menanyakan tingkat kecemasan pasien
- 2) Memberikan edukasi untuk mencegah infeksi
- 3) Melibatkan keluarga dalam perawatan

Di Puskesmas

Pasien hipertensi datang kontrol rutin:

Pendekatan biologis:

- 1) Pemeriksaan tekanan darah
- 2) Evaluasi kepatuhan obat
- 3) Pemeriksaan gula darah

Pendekatan holistik:

- 1) Edukasi diet rendah garam
- 2) Diskusi tentang stres pekerjaan
- 3) Menilai dukungan keluarga

b. Dimensi psikologis

Dimensi psikologis mencakup:

- 1) Emosi
- 2) Persepsi
- 3) Pikiran
- 4) Keyakinan
- 5) Mekanisme koping
- 6) Tingkat stres
- 7) Motivasi

Kondisi psikologis sangat memengaruhi respon pasien terhadap penyakit dan pengobatan.

Peran Dimensi Psikologis dalam Penyembuhan:

Penelitian menunjukkan bahwa kecemasan dan depresi dapat:

- 1) Memperlambat penyembuhan luka
- 2) Menurunkan sistem imun
- 3) Mengurangi kepatuhan terapi

Sebaliknya, kondisi psikologis yang stabil meningkatkan outcome klinis.

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit

Pasien kanker yang akan menjalani kemoterapi:

Pendekatan psikologis:

- 1) Mengidentifikasi ketakutan pasien
- 2) Memberikan konseling singkat
- 3) Menggunakan komunikasi empatik
- 4) Melibatkan psikolog bila diperlukan

Perawat tidak hanya fokus pada obat kemoterapi, tetapi juga pada kesiapan mental pasien.

Di Puskesmas

Ibu hamil trimester pertama merasa cemas:

Pendekatan:

- 1) Memberi kesempatan ibu mengekspresikan kekhawatiran
- 2) Menjelaskan proses kehamilan secara sederhana
- 3) Memberikan reassurance yang realistis

Hasilnya, ibu lebih percaya diri menjalani kehamilan.

c. Dimensi sosial

Dimensi sosial mencakup:

- 1) Hubungan keluarga
- 2) Dukungan sosial
- 3) Kondisi ekonomi
- 4) Pendidikan
- 5) Budaya
- 6) Lingkungan tempat tinggal

Faktor sosial sering menjadi penentu keberhasilan terapi.

Pengaruh Faktor Sosial terhadap Kesehatan

Contoh:

- 1) Pasien diabetes dari keluarga ekonomi rendah mungkin kesulitan membeli obat
- 2) Pasien TB dapat mengalami stigma sosial
- 3) Lansia yang tinggal sendiri berisiko depresi

Oleh karena itu, intervensi kesehatan perlu mempertimbangkan kondisi sosial pasien.

Di Rumah Sakit

Pasien stroke yang akan pulang:

Pendekatan sosial:

- 1) Menilai apakah keluarga mampu merawat
- 2) Mengedukasi caregiver
- 3) Menghubungkan dengan layanan home care

Di Puskesmas

Pasien TB tidak rutin minum obat:

Pendekatan sosial:

- 1) Menanyakan hambatan (transportasi, stigma, biaya)
- 2) Melibatkan kader kesehatan

3) Memberikan edukasi keluarga

d. Dimensi spiritual

Dimensi spiritual berkaitan dengan:

1) Keyakinan agama

2) Makna hidup

3) Harapan

4) Nilai dan prinsip hidup

Hubungan dengan Tuhan atau kekuatan transenden

Spiritualitas tidak selalu identik dengan agama, tetapi berkaitan dengan makna dan tujuan hidup.

Peran Spiritualitas dalam Penyembuhan

Banyak pasien mengandalkan kekuatan spiritual dalam menghadapi penyakit berat. Dukungan spiritual dapat:

1) Mengurangi kecemasan

2) Meningkatkan ketenangan

3) Memberikan harapan

4) Memperkuat ketahanan (resilience)

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit

Pasien ICU dalam kondisi kritis:

Pendekatan spiritual:

1) Memfasilitasi doa bersama keluarga

2) Mengizinkan kunjungan rohaniawan

3) Menghormati ritual keagamaan pasien

Di Puskesmas

Pasien lansia dengan penyakit kronis:

Pendekatan:

1) Menghormati keyakinan pasien

2) Memberikan waktu untuk praktik ibadah

3) Memberikan dukungan emosional berbasis nilai religius pasien

Gangguan kesehatan pada satu dimensi dapat memengaruhi dimensi lainnya. Oleh karena itu, komunikasi tenaga kesehatan harus mampu menggali seluruh aspek tersebut.

Sebagai contoh, pasien hipertensi tidak hanya membutuhkan obat antihipertensi, tetapi juga dukungan psikologis terkait stres, edukasi gaya

hidup, serta pemahaman kondisi sosial ekonomi yang memengaruhi kepatuhan minum obat.

Pendekatan Humanistik dalam Pelayanan Kesehatan

Pendekatan humanistik berakar pada teori Carl Rogers yang menekankan:

- 1) Empati
- 2) Penerimaan tanpa syarat (unconditional positive regard)
- 3) Keaslian (genuineness)

Dalam konteks kesehatan, pendekatan ini berarti:

- 1) Menghormati martabat pasien
- 2) Memberikan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan
- 3) Mengakui nilai dan kepercayaan pasien

Levinson et al. (2023) menegaskan bahwa komunikasi berbasis empati meningkatkan kualitas hubungan terapeutik dan memperbaiki outcome klinis.

Integrasi Keempat Dimensi dalam Praktik Nyata

Contoh Kasus Terpadu:

Seorang pasien diabetes dengan luka kaki:

- 1) Biologis: Perawatan luka dan kontrol gula darah
- 2) Psikologis: Mengatasi rasa putus asa
- 3) Sosial: Edukasi keluarga dan dukungan finansial
- 4) Spiritual: Memberikan penguatan sesuai keyakinan pasien

Pendekatan holistik memastikan seluruh kebutuhan pasien terpenuhi secara komprehensif.

B. Konsep Dan Prinsip Komunikasi Efektif

1. Definisi Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif adalah proses pertukaran informasi yang menghasilkan pemahaman bersama antara pemberi dan penerima pesan, sehingga tercapai tujuan pelayanan kesehatan (Street et al., 2020).

Komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan bukan hanya soal berbicara dengan baik, tetapi menciptakan pemahaman bersama antara tenaga kesehatan dan pasien. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun hubungan terapeutik, meningkatkan keselamatan pasien, serta mendukung pendekatan holistik dan humanistik.

2. Prinsip-Prinsip Komunikasi Efektif

a. Kejelasan pesan (*Clarify*)

Kejelasan pesan berarti informasi yang disampaikan:

- 1) Mudah dipahami
- 2) Tidak ambigu
- 3) Tidak menggunakan jargon medis berlebihan
- 4) Disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan literasi kesehatan pasien

Kejelasan pesan sangat penting karena banyak kesalahan medis terjadi akibat miskomunikasi.

Unsur Kejelasan Pesan

- 1) Gunakan bahasa sederhana
- 2) Hindari istilah teknis tanpa penjelasan
- 3) Gunakan kalimat singkat
- 4) Perjelas dengan contoh atau demonstrasi

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit:

Contoh yang salah: "Ibu mengalami hiperglikemia dan harus restriksi diet karbohidrat."

Contoh yang benar: Kadar gula darah Ibu sedang tinggi. Ibu perlu mengurangi makanan manis dan nasi berlebihan agar gula darah stabil."

Di Puskesmas

Saat menjelaskan obat antibiotik:

"Obat ini diminum tiga kali sehari setelah makan, pagi–siang–malam, dan harus dihabiskan walaupun sudah merasa sembuh."

Perawat juga menuliskan jadwal minum obat agar pasien tidak lupa.

b. Empati (*Empathy*)

Empati adalah kemampuan memahami perasaan pasien dan menunjukkan bahwa perasaan tersebut diakui dan dihargai. Empati bukan berarti larut dalam emosi pasien, tetapi mampu merespons secara profesional dan penuh kepedulian.

Unsur Empati:

- 1) Mendengarkan tanpa menyela
- 2) Mengakui perasaan pasien
- 3) Menggunakan kalimat reflektif

Contoh kalimat empatik:

"Saya bisa memahami bahwa kondisi ini membuat Bapak khawatir."

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit

Pasien kanker berkata: "Saya takut kemoterapi."

Perawat menjawab:

"Wajar sekali merasa takut. Banyak pasien merasakan hal yang sama. Mari kita bahas bersama agar Ibu lebih siap."

Di Puskesmas

Ibu hamil cemas menjelang persalinan:

"Saya mengerti Ibu merasa khawatir. Kita akan pantau bersama dan saya akan jelaskan prosesnya satu per satu."

Empati meningkatkan rasa aman dan kepercayaan pasien.

c. Respek (Respect)

Respek berarti menghargai martabat, nilai, dan hak pasien sebagai individu yang memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan.

Respek ditunjukkan melalui:

- 1) Bahasa sopan
- 2) Tidak meremehkan keluhan
- 3) Menjaga privasi
- 4) Memberikan kesempatan bertanya

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit:

Perawat mengetuk pintu sebelum masuk ruangan dan berkata:

"Permisi Pak, saya akan memeriksa tekanan darah, apakah Bapak bersedia sekarang?"

Ini menunjukkan penghormatan terhadap privasi dan persetujuan pasien.

Di Puskesmas

Pasien menolak metode KB tertentu karena alasan agama.

Perawat merespons:

"Baik Ibu, saya menghormati keputusan Ibu. Kita bisa diskusikan alternatif lain yang sesuai."

d. Konsistensi informasi (*Consistency*)

Konsistensi berarti informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan tidak saling bertentangan.

Ketidakkonsistenan dapat:

- 1) Menurunkan kepercayaan pasien
- 2) Menyebabkan kebingungan
- 3) Mengurangi kepatuhan terapi

Implementasi:

- 1) Koordinasi antar profesi
- 2) Dokumentasi yang jelas
- 3) Edukasi tim kesehatan

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit

Dokter menyarankan diet rendah garam, tetapi perawat memberikan edukasi berbeda.

Solusi:

Sebelum edukasi, perawat memastikan instruksi dokter melalui rekam medis
Di Puskesmas

Program pengelolaan hipertensi:

Semua tenaga kesehatan memberikan pesan yang sama:

- 1) Kurangi garam
- 2) Olahraga rutin
- 3) Minum obat teratur

Pesan yang konsisten memperkuat perubahan perilaku.

e. Umpan balik (*feed back*)

Umpan balik bertujuan memastikan bahwa pesan telah dipahami dengan benar.

Metode yang efektif adalah *teach-back method*, yaitu meminta pasien mengulang kembali informasi yang diberikan.

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit

Perawat berkata:

"Untuk memastikan tidak ada yang terlewat, boleh Bapak ulangi bagaimana cara minum obat ini di rumah nanti?"

Jika pasien keliru, perawat mengoreksi dengan cara suportif.

Di Puskesmas

Setelah edukasi gizi:

"Coba Ibu ceritakan kembali makanan apa saja yang sebaiknya dikurangi?"

Umpan balik membantu mencegah kesalahan penggunaan obat atau terapi.

f. Kesesuaian budaya (*cultural sensitivity*)

Cultural sensitivity adalah kemampuan memahami dan menghargai perbedaan budaya, bahasa, nilai, dan kepercayaan pasien.

Pelayanan kesehatan di Indonesia sangat beragam secara budaya, sehingga kompetensi budaya menjadi sangat penting.

Aspek *Cultural Sensitivity*

- 1) Bahasa lokal
- 2) Nilai keluarga
- 3) Kepercayaan terhadap pengobatan tradisional
- 4) Norma sosial

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit

Pasien dari budaya tertentu ingin didampingi keluarga saat diskusi medis.

Perawat mengakomodasi kebutuhan tersebut selama tidak mengganggu prosedur medis.

Di Puskesmas

Pasien lebih percaya pada jamu tradisional.

Perawat tidak langsung menolak, tetapi berkata:

“Boleh saja mengonsumsi jamu, tetapi tetap minum obat dari dokter agar tekanan darah tetap terkontrol.”

Pendekatan ini menjaga hubungan baik tanpa mengabaikan keselamatan pasien.

Integrasi Keenam Prinsip dalam Praktik Nyata

Contoh kasus terpadu:

Pasien diabetes dengan kadar gula tidak terkontrol.

Perawat menerapkan:

- 1) Kejelasan pesan: Menjelaskan diet secara sederhana
- 2) Empati: Mengakui kesulitan pasien mengubah pola makan
- 3) Respek: Menghargai pilihan makanan budaya pasien
- 4) Konsistensi: Menyampaikan informasi sesuai instruksi dokter
- 5) Umpan balik: Meminta pasien mengulang jadwal obat
- 6) Cultural sensitivity: Menyesuaikan saran diet dengan makanan lokal

Hasil: pasien lebih kooperatif dan termotivasi.

C. Komponen Komunikasi Terapeutik

1. Mendengarkan Aktif (*Active Listening*)

Mendengarkan aktif meliputi:

- a. Kontak mata
- b. Bahasa tubuh terbuka
- c. Parafrase
- d. Klarifikasi

Contoh di Rumah Sakit:

Pasien pasca operasi mengatakan, “Saya takut jahitannya terbuka.”

Perawat merespon:

"Bapak khawatir luka operasi tidak kuat, ya? Mari saya jelaskan cara perawatannya."

Contoh di Puskesmas:

Pasien TB merasa malu karena stigma masyarakat.

Petugas menjawab:

"Saya memahami perasaan Bapak. Penyakit ini bisa disembuhkan dan kami akan mendampingi sampai tuntas."

Komunikasi Verbal dan Nonverbal

Penelitian menunjukkan bahwa pesan nonverbal (intonasi, ekspresi wajah, sikap tubuh) sangat memengaruhi persepsi pasien (Ranjan et al., 2021).

Contoh:

Nada suara yang lembut meningkatkan rasa aman pada pasien lansia.

Edukasi dengan Bahasa Sederhana

Hindari istilah medis kompleks.

Acontoh yang salah: "Anda mengalami hiperglikemia."

Contoh yang benar: Kadar gula darah Anda sedang tinggi."

2. Shared Decision Making (Pengambilan Keputusan Bersama)

Model ini melibatkan pasien dalam menentukan pilihan terapi.

Contoh di RS:

Dokter menjelaskan dua pilihan terapi kanker dan mendiskusikan kelebihan serta risiko masing-masing bersama pasien dan keluarga.

Contoh di Puskesmas:

Perawat mendiskusikan metode kontrasepsi sesuai kebutuhan dan kondisi ibu.

D. Hambatan komunikasi dalam pelayanan kesehatan

1. Hambatan Individual

- a. Perbedaan bahasa
- b. Tingkat pendidikan rendah
- c. Kondisi emosional pasien

2. Hambatan Institusional

- a. Beban kerja tinggi
- b. Waktu konsultasi terbatas
- c. Kurangnya pelatihan komunikasi

3. Hambatan Budaya

Perbedaan nilai dan keyakinan dapat memengaruhi penerimaan informasi kesehatan.

Contoh:

Pasien menolak transfusi karena keyakinan agama.

Solusi:

Pendekatan empatik dan diskusi alternatif medis yang memungkinkan.

E. Implementasi di Rumah Sakit

1. Komunikasi Saat Admission
 - a. Menjelaskan prosedur rawat inap
 - b. Memberikan orientasi ruangan
 - c. Memperkenalkan tim kesehatan
2. Komunikasi Saat Tindakan Medis
 - a. Informed consent jelas
 - b. Menjelaskan risiko dan manfaat
 - c. Memberikan kesempatan bertanya
3. Komunikasi Saat *Discharge Planning*
 - a. Edukasi tertulis dan verbal
 - b. Demonstrasi perawatan luka
 - c. Konfirmasi pemahaman pasien
4. Hasil yang diharapkan:
 - a. Penurunan readmisi
 - b. Kepatuhan terapi meningkat

F. Implementasi di Puskesmas

1. Pelayanan Promotif dan Preventif
 - a. Edukasi imunisasi
 - b. Konseling gizi
 - c. Penyuluhan penyakit tidak menular
2. Kunjungan Rumah (Home Care)

Komunikasi lebih personal dan kontekstual terhadap kondisi keluarga.
3. Program Penyakit Kronis (Prolanis)

Komunikasi berkelanjutan untuk meningkatkan self-management pasien.

G. Evaluasi dan indikator keberhasilan Indikator komunikasi efektif:

1. Kepuasan pasien meningkat
2. Kepatuhan pengobatan meningkat
3. Penurunan keluhan
4. Peningkatan skor akreditasi pelayanan

Menurut Sustersic et al. (2022), komunikasi efektif di layanan primer meningkatkan literasi kesehatan dan outcome jangka panjang.

H. Peran Perawat Dalam Komunikasi Efektif Antara Tenaga Kesehatan Dan Pasien

Perawat merupakan tenaga kesehatan yang memiliki intensitas interaksi paling tinggi dengan pasien dibandingkan profesi kesehatan lainnya. Dalam konteks pendekatan holistik dan humanistik, perawat tidak hanya berperan sebagai pelaksana tindakan medis, tetapi juga sebagai komunikator terapeutik, advokat pasien, edukator, dan fasilitator hubungan interprofesional.

Komunikasi efektif oleh perawat berkontribusi pada:

1. Peningkatan keselamatan pasien
2. Pencegahan kesalahan medis
3. Peningkatan kepatuhan terapi
4. Penguatan hubungan terapeutik
5. Kepuasan pasien dan keluarga

Menurut Levinson et al. (2023), komunikasi berbasis empati dan patient-centered care meningkatkan kepercayaan serta hasil klinis pasien.

Peran Perawat sebagai Komunikator Terapeutik:

1. Sebagai Pendengar Aktif

Perawat harus mampu:

- a. Memberikan perhatian penuh
- b. Menggunakan teknik refleksi dan klarifikasi
- c. Menghindari sikap menghakimi

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit

Pasien pasca operasi mengeluh nyeri dan cemas.

Perawat berkata:

“Bapak merasa nyerinya semakin kuat sejak tadi malam, ya? Mari kita ukur skala nyerinya dan saya bantu atasi.”

Perawat tidak langsung menyangkal atau mengabaikan keluhan, tetapi memvalidasi perasaan pasien.

Di Puskesmas

Pasien lansia mengeluh sering pusing.

Perawat:

"Ibu bisa ceritakan kapan biasanya pusing muncul? Apakah setelah aktivitas tertentu?"

Perawat menggali informasi tanpa terburu-buru.

2. Peran Perawat sebagai Edukator

Perawat bertanggung jawab memberikan pendidikan kesehatan yang jelas, sederhana, dan sesuai tingkat literasi pasien.

Prinsip Edukasi Efektif:

- a. Gunakan bahasa non-medis
- b. Gunakan media visual bila perlu
- c. Gunakan metode teach-back

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit (*Discharge Planning*)

Pasien dengan luka operasi akan pulang.

Perawat:

- a. Mendemonstrasikan cara membersihkan luka
- b. Memberikan leaflet
- c. Meminta pasien mengulang kembali instruksi

"Coba Bapak praktikkan kembali cara membersihkan lukanya, agar saya tahu sudah jelas."

Di Puskesmas (Program Prolanis Diabetes)

Perawat menjelaskan diet sehat:

Alih-alih berkata:

"Kurangi karbohidrat kompleks."

Perawat menjelaskan:

"Nasi boleh tetap makan, tetapi kurangi porsi nya dan tambahkan sayur lebih banyak."

Edukasi menjadi lebih aplikatif dan mudah dipahami.

3. Peran Perawat sebagai Advokat Pasien

Advokasi berarti membela dan melindungi hak pasien, termasuk hak atas informasi dan keputusan.

Bentuk Advokasi:

- a. Memastikan informed consent dipahami pasien
- b. Menyampaikan ke dokter jika pasien belum memahami prosedur
- c. Membela pasien yang rentan (anak, lansia, disabilitas)

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit

Pasien lansia tampak bingung sebelum operasi.

Perawat menyampaikan kepada dokter:

"Dokter, pasien tampaknya belum memahami sepenuhnya prosedur operasi. Apakah bisa dijelaskan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana?"

Di Puskesmas

Pasien ingin memilih metode KB tetapi ditekan keluarga.

Perawat:

"Ibu berhak menentukan metode KB yang paling nyaman dan sesuai kondisi kesehatan Ibu."

Perawat melindungi hak otonomi pasien.

4. Peran Perawat sebagai Fasilitator Hubungan Interprofesional

Perawat menjadi penghubung antara pasien dan tim kesehatan lainnya.

Tanggung jawab:

- a. Menyampaikan kondisi pasien secara akurat
- b. Menghindari miskomunikasi antar profesi
- c. Menggunakan komunikasi SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)

Contoh Aplikatif di Rumah Sakit

Perawat melaporkan kondisi pasien ke dokter menggunakan format SBAR:

Situation: "Pasien mengalami penurunan tekanan darah."

Background: "Pasca operasi 6 jam lalu."

Assessment: "Diduga perdarahan."

Recommendation: "Mohon evaluasi segera."

Komunikasi sistematis ini meningkatkan keselamatan pasien.

Di Puskesmas

Perawat menemukan balita gizi kurang dan berkoordinasi dengan:

- a. Ahli gizi
- b. Kader Posyandu
- c. Bidan desa

Perawat memfasilitasi komunikasi lintas profesi demi kepentingan pasien.

5. Peran Perawat dalam Pendekatan Holistik

Perawat memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan empat dimensi manusia:

- a. Biologis

Monitoring kondisi fisik pasien.

a. Psikologis

Memberikan dukungan emosional.

a. Sosial

Mengidentifikasi dukungan keluarga dan ekonomi.

a. Spiritual

Menghormati nilai dan keyakinan pasien.

Studi Kasus Terpadu

Pasien gagal ginjal menjalani hemodialisis:

Peran Perawat:

- a. Mengawasi kondisi hemodinamik (biologis)
- b. Memberikan dukungan psikologis karena pasien merasa putus asa
- c. Melibatkan keluarga untuk dukungan sosial
- d. Memfasilitasi kunjungan rohaniawan sesuai keyakinan pasien

Pendekatan ini mencerminkan praktik keperawatan yang holistik dan humanistik.

Tantangan Perawat dalam Komunikasi Efektif:

- a. Beban kerja tinggi
- b. Keterbatasan waktu
- c. Perbedaan budaya
- d. Kurangnya pelatihan komunikasi

Solusi:

- a. Pelatihan komunikasi berbasis simulasi
- b. Supervisi klinik
- c. Peningkatan rasio perawat-pasien
- d. Budaya organisasi yang mendukung patient-centered care

Dampak Komunikasi Efektif oleh Perawat

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi efektif oleh perawat berhubungan dengan:

- a. Penurunan angka keluhan pasien
- b. Peningkatan kepuasan pelayanan
- c. Penurunan readmisi
- d. Kepatuhan terapi yang lebih baik

Street et al. (2020) menjelaskan bahwa komunikasi yang empatik menciptakan jalur psikologis dan biologis yang mendukung penyembuhan.

Perawat memegang peranan sentral dalam komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien. Sebagai komunikator terapeutik, edukator, advokat, dan fasilitator tim kesehatan, perawat berkontribusi langsung terhadap keberhasilan pendekatan holistik dan humanistik dalam pelayanan kesehatan.

Komunikasi efektif bukan sekadar keterampilan tambahan, melainkan kompetensi inti profesional keperawatan yang menentukan kualitas asuhan dan keselamatan pasien.

I. Kesimpulan

Komunikasi efektif merupakan inti dari pendekatan holistik dan humanistik dalam pelayanan kesehatan. Melalui komunikasi yang empatik, jelas, dan partisipatif, tenaga kesehatan mampu:

1. Meningkatkan kualitas hubungan terapeutik
2. Mendukung keselamatan pasien
3. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien
4. Memperbaiki outcome klinis

Implementasi komunikasi efektif harus menjadi budaya organisasi, bukan sekadar keterampilan individual.

Pendekatan holistik menegaskan bahwa manusia adalah sistem yang saling terintegrasi antara dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Pelayanan kesehatan yang hanya berfokus pada aspek biologis akan kehilangan esensi kemanusiaan pasien. Tenaga kesehatan, khususnya perawat, memiliki peran strategis dalam:

1. Mengkaji keempat dimensi secara komprehensif
2. Mengintegrasikan intervensi lintas aspek
3. Menggunakan komunikasi empatik dan terapeutik

Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak hanya menyembuhkan penyakit, tetapi juga memulihkan martabat dan kualitas hidup pasien secara utuh.

Prinsip-prinsip komunikasi efektif—kejelasan pesan, empati, respek, konsistensi informasi, umpan balik, dan kesesuaian budaya—merupakan fondasi dalam pendekatan holistik dan humanistik pelayanan kesehatan. Penerapan keenam prinsip ini:

1. Meningkatkan kualitas hubungan terapeutik
2. Meningkatkan keselamatan pasien

3. Memperkuat kepercayaan dan kepatuhan terapi
4. Mendukung pelayanan yang berorientasi pada manusia seutuhnya

J. Referensi

- Levinson, W., Lesser, C. S., & Epstein, R. M. (2023). Developing physician communication skills for patient-centered care. *Journal of the American Medical Association*, 329(18), 1500–1508.
- Ranjan, P., Kumari, A., & Chakrawarty, A. (2021). How can doctor–patient communication influence patient satisfaction? *Journal of Family Medicine and Primary Care*, 10(1), 82–87.
- Street, R. L., Makoul, G., Arora, N. K., & Epstein, R. M. (2020). How does communication heal? Pathways linking clinician–patient communication to health outcomes. *Patient Education and Counseling*, 103(5), 863–871.
- Sustersic, M., Choudat, D., Gillaizeau, F., et al. (2022). Patient–physician communication in primary care: Evidence-based recommendations. *Annals of Family Medicine*, 20(3), 217–226.
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030*. WHO Press.

CHAPTER 6

ETIKA, EMPATI, DAN NILAI KEMANUSIAAN DALAM PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN

Aini Alifatin, S.KP., M.Kep

A. Pendahuluan

Perkembangan pelayanan kesehatan modern ditandai oleh kemajuan teknologi diagnostik, digitalisasi sistem rekam medis, penerapan indikator kinerja berbasis target, serta tekanan efisiensi dalam pembiayaan layanan. Transformasi ini meningkatkan akurasi klinis dan produktivitas sistem, namun secara simultan memunculkan kekhawatiran terhadap gejala dehumanisasi dalam praktik pelayanan kesehatan. Studi mengenai tekanan efisiensi dan target pelayanan menunjukkan bahwa orientasi berlebihan pada indikator kuantitatif dapat menggeser fokus profesional dari relasi terapeutik menuju pencapaian alur pasien dan kepatuhan administratif (Kerasidou, 2019).

Dalam konteks ini, empati dan komunikasi berpusat pada pasien sering terpinggirkan oleh beban kerja tinggi, keterbatasan waktu, serta budaya organisasi yang berorientasi prosedural. Literatur mengenai *patient-centered care* menegaskan bahwa komunikasi yang berfokus pada tugas (task-centered communication) cenderung mereduksi pasien menjadi objek tindakan klinis, sementara komunikasi berpusat pada pribadi (person-centered communication) menempatkan pasien sebagai mitra relasional dalam perawatan (Kwame & Petrucka, 2021).

Literatur pendidikan kedokteran dan keperawatan menunjukkan bahwa empati cenderung mengalami penurunan selama fase klinis, sehingga diperlukan intervensi pendidikan yang terstruktur untuk mempertahankan dan mengembangkan kompetensi empatik profesional (Hojat, 2016). Kajian tentang peran empati dalam profesi kesehatan dan sosial menunjukkan bahwa tekanan akademik dan lingkungan klinis yang berorientasi teknis berkontribusi terhadap erosi sensitivitas relasional (Moudatsou, Stavropoulou, Philalithis, & Koukouli, 2020).

Empati dalam praktik kesehatan tidak hanya dipahami sebagai sikap emosional, tetapi sebagai kompetensi multidimensional yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Dalam pendidikan profesi kesehatan, empati bahkan telah dikembangkan sebagai kompetensi yang dapat diukur dan ditingkatkan melalui instrumen seperti *Jefferson Scale of Empathy*, yang menunjukkan bahwa

empati merupakan kapasitas profesional yang dapat dibentuk melalui proses pendidikan yang sistematis (Hojat, 2016). Tinjauan sistematis terhadap lima dekade penelitian menunjukkan bahwa empati tenaga kesehatan berkorelasi dengan peningkatan kepuasan pasien, kepatuhan terhadap terapi, serta perbaikan luaran klinis. Temuan ini memperlihatkan bahwa empati memiliki nilai instrumental sekaligus moral dalam pelayanan kesehatan (Nembhard, David, Ezzeddine, Betts, & Radin, 2023).

Dari perspektif normatif, empati memiliki fungsi epistemik, memungkinkan profesional memahami perspektif pasien secara akurat, serta fungsi moral dalam realisasi hak pasien dan pengambilan keputusan bersama (*shared decision-making*). Empati membantu menghubungkan prinsip etika abstrak dengan konteks pengalaman hidup pasien yang konkret (Albuquerque & Howick, 2023).

Distingsi konseptual antara empati, simpati, dan compassion juga menjadi penting dalam membangun kerangka etika pelayanan. Hal ini ditegaskan bahwa empati yang berorientasi pada perspektif pasien (*other-oriented perspective taking*) lebih operasional dalam praktik klinis dibandingkan simpati yang cenderung berfokus pada reaksi emosional diri (Jeffrey, 2016). Klarifikasi konseptual ini mencegah reduksi empati menjadi sekadar ekspresi emosional tanpa pemahaman kognitif yang memadai.

Selain tekanan efisiensi, tantangan kontemporer muncul dari integrasi teknologi berbasis kecerdasan buatan dalam pelayanan kesehatan. Meskipun sistem berbasis *large language models* dapat mensimulasikan respons empatik, empati artifisial tidak identik dengan keterlibatan relasional manusia (Koranteng et al., 2023). Oleh karena itu, teknologi seharusnya diposisikan sebagai pendukung relasi terapeutik, bukan pengganti kehadiran moral profesional kesehatan.

Pendekatan neurobehavioral memperkuat urgensi empati dari sisi ilmiah. Artikel Schverer (2020), menunjukkan bahwa komunikasi empatik dapat memodulasi respons stres, nyeri, dan ekspektasi pasien melalui mekanisme psikobiologis yang terukur. Dengan demikian, empati memiliki dasar neurobiologis yang mendukung perannya dalam proses penyembuhan.

Dalam situasi krisis kesehatan global, seperti komplikasi neurologis dan visual pasca-COVID, pendekatan berbasis narasi dan etika kepedulian menjadi semakin relevan. Pentingnya *narrative ethics* untuk memahami pengalaman pasien sebagai sumber refleksi moral dan kebijakan publik. Narasi pasien memperlihatkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut intervensi biologis, tetapi juga pengakuan terhadap kerentanan dan martabat manusia (Hodge & Collins, 2024).

Berdasarkan telaah konseptual dan empiris tersebut, dapat ditegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang holistik dan humanistik tidak dapat dilepaskan dari

integrasi etika, empati, dan nilai kemanusiaan. Di tengah tekanan sistem, perkembangan teknologi, dan kompleksitas klinis, empati berfungsi sebagai fondasi relasional yang menjaga keseimbangan antara efisiensi dan penghormatan terhadap martabat manusia

Etika pelayanan kesehatan secara klasik dibangun di atas empat prinsip utama, yaitu *otonomi*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan keadilan (Beauchamp, 1979). Keempat prinsip tersebut memberikan kerangka normatif dalam pengambilan keputusan klinis. Namun, implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik nyata tidak berlangsung secara mekanis; dibutuhkan medium relasional yang memungkinkan profesional kesehatan memahami nilai, preferensi, dan pengalaman subjektif pasien. Dalam konteks ini, empati berfungsi sebagai jembatan antara norma etis abstrak dan realitas pengalaman pasien.

Secara normatif, empati klinis memiliki fungsi epistemik dan moral. Empati memungkinkan profesional kesehatan memahami perspektif pasien secara akurat melalui proses pemahaman, simulasi perspektif, dan atribusi makna terhadap kondisi pasien. Dengan demikian, empati mendukung realisasi hak pasien serta memperkuat praktik *shared decision-making*, karena keputusan klinis tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi juga pada nilai dan preferensi pasien (Albuquerque & Howick, 2023).

Selain itu, empati berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap bias dan diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Dengan mengembangkan *other-oriented perspective taking*, profesional kesehatan dapat mengurangi kecenderungan stereotip dan memperluas perhatian moral terhadap kelompok rentan. Klarifikasi konseptual antara empati, simpati, dan compassion menunjukkan bahwa empati, yang mencakup dimensi kognitif, afektif, dan perilaku, lebih operasional untuk pendidikan dan praktik profesional dibandingkan simpati yang berfokus pada respons emosional diri (Guidi & Traversa, 2021).

Dalam konteks krisis kesehatan global, seperti komplikasi neurologis dan visual pasca-COVID, pendekatan berbasis *narrative ethics* dan *care ethics* semakin menegaskan urgensi empati dalam pelayanan kesehatan. Pengalaman pasien tidak dapat direduksi menjadi data klinis semata, melainkan harus dipahami sebagai narasi yang mengandung dimensi psikologis, eksistensial, dan sosial. Refleksi etis terhadap pengalaman tersebut memperluas tanggung jawab profesional dari sekadar intervensi biologis menuju pendampingan relasional yang berorientasi pada martabat manusia (Hodge & Collins, 2024).

Dengan demikian, urgensi etika dan empati dalam pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sistemik dan ilmiah. Empati memperkuat implementasi prinsip etika, meningkatkan kualitas deliberasi klinis, serta menjaga

keseimbangan antara tuntutan efisiensi sistem dan penghormatan terhadap martabat manusia

B. Landasan Konseptual Etika dalam Pelayanan Kesehatan

1. Etika sebagai Fondasi Normatif Pelayanan Kesehatan

Secara konseptual, etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang merujuk pada kebiasaan, karakter, atau disposisi moral seseorang. Dalam konteks filsafat moral, etika merupakan kajian sistematis mengenai prinsip-prinsip yang membimbing perilaku benar dan salah (Varkey, 2021). Etika berbeda dari moralitas dalam arti bahwa moralitas merujuk pada norma atau nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan etika merupakan refleksi kritis dan rasional atas norma tersebut.

Etika dalam pelayanan kesehatan bukan sekadar aturan perilaku profesional, melainkan kerangka normatif yang membimbing pengambilan keputusan dalam situasi klinis yang sarat ketidakpastian moral. Etika juga memiliki dimensi normatif dan praktis. Secara normatif, etika menjawab pertanyaan “apa yang seharusnya dilakukan?”; secara praktis, etika membimbing pengambilan keputusan dalam situasi klinis yang kompleks (Varkey, 2021).

Dalam konteks pelayanan kesehatan, etika tidak hanya mengatur hubungan profesional antara tenaga kesehatan dan pasien, tetapi juga mencakup sistem organisasi, kebijakan, serta relasi dengan komunitas. Etika pelayanan kesehatan merupakan identifikasi prinsip-prinsip dan penerapan nilai serta norma yang membimbing praktik pelayanan dalam ranah *cure*, *care*, *control*, dan *community* (Lategan & Zyl, 2017). Dengan demikian, etika kesehatan bersifat transdisipliner dan melampaui sekadar kepatuhan terhadap kode perilaku.

Dalam praktik kesehatan modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan kompleksitas sistem, etika menjadi fondasi untuk menjaga integritas profesional dan kepercayaan publik. Dalam perspektif global, moralitas memiliki peran sentral dalam sistem kesehatan. Jindal dan Tiwari (2025) menegaskan bahwa keadilan, inklusivitas, dan martabat manusia merupakan determinan moral yang harus membimbing kebijakan kesehatan global. Moralitas tidak hanya terkait tindakan individu, tetapi juga sistem nilai yang membentuk prioritas kebijakan dan distribusi sumber daya.

Dalam praktik klinis, keputusan medis selalu mengandung dimensi nilai: siapa yang diprioritaskan, risiko apa yang dapat diterima, sejauh mana otonomi pasien dihormati, dan bagaimana keadilan didistribusikan. Oleh karena itu, etika tidak berdiri di luar praktik klinis; ia inheren dalam setiap keputusan medis (Varkey, 2021).

Etika juga tidak identik dengan hukum. Hukum menetapkan batas minimal perilaku yang diperbolehkan, sedangkan etika menuntut standar moral yang lebih tinggi. Sistem kesehatan berdiri di atas tiga pilar yang saling berinteraksi: etika, hukum, dan kebijakan public. Hukum dapat melindungi hak, tetapi etika memastikan bahwa praktik pelayanan tetap humanistik dan berkeadaban, bahkan ketika hukum belum secara eksplisit mengaturnya (Larasati, Fardiansyah, Saketi, & Dewiarti, 2024; Shetty, 2023; Widiyanto & Darmayanti, 2025).

2. Teori Etika: *Utilitarianisme* dan *Deontologi* dalam Praktik Kesehatan

Pemahaman prinsip etika tidak dapat dilepaskan dari teori moral yang mendasarinya. Terdapat dua teori utama yang paling relevan dalam praktik Kesehatan, yaitu *utilitarianisme* dan *deontology*.

a. Utilitarianisme

Utilitarianisme menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya. Suatu tindakan dianggap benar jika menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Prinsip ini sering muncul dalam kebijakan kesehatan publik, seperti alokasi sumber daya terbatas atau kebijakan vaksinasi massal (Heller, Wyllie, Haresnape, Davey, & Furniss, 2026). Dalam situasi pandemi, misalnya, keputusan *triase* ICU sering kali berlandaskan pertimbangan *utilitarian*—memaksimalkan keselamatan populasi secara keseluruhan. Namun, pendekatan ini berisiko mengabaikan hak individu dan kelompok minoritas.

b. Deontologi

Sebaliknya, *deontologi* menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral dan penghormatan terhadap hak individu, bukan semata konsekuensinya (Heller et al., 2026). Dalam praktik klinis, *deontologi* tampak dalam kewajiban untuk berkata jujur, menjaga kerahasiaan, dan menghormati otonomi pasien, meskipun konsekuensi pragmatismenya mungkin tidak selalu optimal secara *utilitarian*. Pendekatan *deontologis* menjadi dasar bagi banyak kode etik profesional, diantaranya menegaskan bahwa tenaga kesehatan tidak boleh menyiksa atau mendiskriminasi pasien dalam keadaan apa pun (World Health Organization (WHO), 2016).

c. Ketegangan Teoretis dalam Praktik

Dalam praktik nyata, *utilitarianisme* dan *deontologi* sering berbenturan. Misalnya, pembatasan akses keluarga selama pandemi mungkin bermanfaat secara epidemiologis (*utilitarian*), tetapi dapat melanggar nilai relasional dan hak individual (*deontologis*). Oleh karena itu, pendekatan etika klinis memerlukan keseimbangan reflektif, bukan penerapan teori secara kaku.

3. Empat Prinsip Etika Biomedis

Kerangka yang paling luas digunakan dalam etika klinis adalah empat prinsip: *beneficence*, *non-maleficence*, *autonomy*, dan *justice* (Ashcroft, Dawson, Draper, & McMillan, 2007; Varkey, 2021).

a. Autonomy

Otonomi adalah hak pasien untuk menentukan keputusan berdasarkan informasi yang memadai. Otonomi menjadi dasar *informed consent*, *truth-telling*, dan *confidentiality* (Varkey, 2021). *WHO Code of Ethics* (2023) menekankan penghormatan terhadap martabat, kesetaraan, dan non-diskriminasi sebagai bentuk konkret penghormatan terhadap otonomi manusia. Dalam praktik, penghormatan terhadap otonomi mengharuskan tenaga Kesehatan:

- 1) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur,
- 2) Menghormati pilihan pasien, bahkan ketika pilihan tersebut berbeda dari preferensi profesional,
- 3) Menjaga kerahasiaan data medis.

Prinsip ini juga menegaskan bahwa kewajiban utama tenaga kesehatan adalah kepada pasien, serta tindakan harus dilakukan dengan menghormati martabat dan tanpa diskriminasi (World Health Organization (WHO), 2016).

b. Beneficence

Beneficence mengacu pada kewajiban untuk bertindak demi kebaikan pasien dan mempromosikan kesejahteraannya. Prinsip ini menuntut tenaga kesehatan untuk tidak hanya menghindari bahaya, tetapi secara aktif memberikan manfaat (Varkey, 2021). *WHO Code of Ethics* (2023) menegaskan komitmen untuk "*put people's health interests first*" serta menunjukkan *compassion* terhadap semua manusia. Hal ini memperluas makna *beneficence* dari relasi individual menjadi komitmen institusional.

c. Non-Maleficence

Prinsip *non-maleficence*, yang dikenal sebagai *do no harm*, menegaskan kewajiban untuk tidak menyebabkan bahaya, penderitaan, atau risiko yang tidak proporsional terhadap manfaat (Varkey, 2021). Dalam dokumen *WHO Code of Ethics* (2023), prinsip ini tercermin dalam komitmen untuk tidak melakukan eksploitasi, pelecehan, atau tindakan yang merugikan populasi yang dilayani. Pada konteks krisis dan konflik bersenjata, tenaga kesehatan tidak boleh terlibat dalam penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi dalam keadaan apa pun (World Health Organization (WHO), 2016).

d. Justice

Prinsip keadilan menuntut distribusi sumber daya kesehatan secara adil dan tanpa diskriminasi. *Justice* mencakup keadilan distributif dan perlakuan setara bagi semua pasien (Varkey, 2021).

WHO *Code of Ethics* (2023) secara eksplisit melarang diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, kebangsaan, usia, atau status lainnya. Dalam konteks *global health*, *moral determinants* yang dibahas oleh Jindal dan Tiwari (2025) menegaskan bahwa keadilan dan *equity* harus menjadi fondasi sistem kesehatan lintas negara.

4. Etika, Hukum, dan Kebijakan Kesehatan

Etika, hukum, dan kebijakan kesehatan memiliki relasi yang dinamis. Hukum memberikan batas formal, tetapi etika memberikan arah normatif. Kebijakan kesehatan harus berakar pada pertimbangan moral, bukan sekadar pertimbangan administratif (Shetty, 2023; Widiyanto & Darmayanti, 2025; World Health Organization (WHO), 2016). Dalam praktik, konflik sering muncul ketika tindakan yang legal belum tentu etis, atau sebaliknya. Oleh karena itu, profesional kesehatan harus memiliki kompetensi etis untuk menilai situasi secara kritis, bukan hanya mengikuti regulasi.

5. Etika Profesional dan Pendekatan Humanistik

Etika profesional melampaui kepatuhan hukum. Ia mencerminkan integritas, akuntabilitas, independensi, dan profesionalisme dalam praktik pelayanan kesehatan. Etika profesional juga mencakup pengambilan keputusan etis yang sistematis. Etika profesional, tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga menangani kerentanan tenaga kesehatan dalam sistem yang kompleks (Burggraave et al., 2017).

WHO *Code of Ethics* (2023) merumuskan lima prinsip utama: integritas, akuntabilitas, independensi dan imparialitas, penghormatan terhadap martabat, dan kesetaraan serta profesionalisme. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah praktik moral, bukan sekadar teknis. Varkey (2021) juga menampilkan model pelayanan terintegrasi yang menggabungkan etika, profesionalisme, dan kompetensi klinis. Dalam model ini, keahlian teknis tanpa komitmen moral dianggap tidak memadai.

Hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan telah bergeser dari relasi paternalistik menjadi relasi komplementer yang berbasis saling menghormati (Burggraave et al., 2017). Model penyelesaian konflik prinsip etika ketika terjadi benturan, misalnya antara *beneficence* dan *autonomy*, dibahas secara rinci oleh Varkey, (2021). Pendekatan humanistik menempatkan caring sebagai inti pelayanan, dimana pelayanan kesehatan menempatkan manusia sebagai pusat

perhatian, bukan sekadar objek intervensi klinis. Etika humanistik juga menuntut sensitivitas terhadap kemiskinan, kerentanan, dan ketidaksetaraan sosial (Jindal & Tiwari, 2025). Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang beretika tidak hanya memulihkan fungsi biologis, tetapi juga memulihkan martabat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam WHO *Code of Ethics* (2023), tenaga kesehatan harus "*show compassion for all human beings*" serta membangun lingkungan yang aman dan menghormati.

C. Empati sebagai Kompetensi Inti Pelayanan Kesehatan

1. Konsep Empati dalam Pelayanan Kesehatan

Empati dalam pelayanan kesehatan merupakan kompetensi multidimensional yang memungkinkan tenaga kesehatan memahami pengalaman subjektif pasien, meresponsnya secara tepat, serta mengintegrasikan pemahaman tersebut ke dalam tindakan klinis. Empati tidak identik dengan respons emosional spontan, melainkan suatu proses relasional yang melibatkan pemahaman perspektif, resonansi emosional yang terkontrol, serta tindakan profesional yang bertujuan membantu pasien (Guidi & Traversa, 2021; Varkey, 2021). Secara konseptual, empati dalam praktik kesehatan dapat dibedakan ke dalam tiga dimensi utama: empati kognitif, empati afektif, dan empati perilaku.

a. Empati Kognitif

Empati kognitif merujuk pada kemampuan mengambil perspektif pasien (*perspective taking*) dan memahami makna pengalaman pasien tanpa kehilangan batas profesional. Dimensi ini bersifat analitis dan memungkinkan tenaga kesehatan menafsirkan kondisi pasien secara kontekstual. Empati memiliki fungsi epistemik: melalui proses *comprehension–simulation–attribution*, profesional kesehatan dapat memahami keyakinan, nilai, dan preferensi pasien secara lebih akurat (Albuquerque & Howick, 2023). Empati kognitif menjadi prasyarat bagi *shared decision-making*, karena keputusan klinis memerlukan pemahaman atas apa yang bermakna bagi pasien, bukan sekadar pertimbangan teknis.

b. Empati Afektif

Empati afektif mengacu pada resonansi emosional terhadap penderitaan pasien. Namun, literatur neurobehavioral menunjukkan bahwa resonansi emosional yang tidak diregulasi dapat memicu distress pribadi dan *burnout*. Decety & Li, (2025) dalam artikelnya menjelaskan bahwa profesional berpengalaman menunjukkan aktivasi regulasi prefrontal yang memungkinkan keterlibatan emosional tanpa kehilangan kontrol diri. Dengan demikian,

empati afektif dalam praktik klinis bukanlah keterlarutan emosional, melainkan kepekaan emosional yang diregulasi.

c. Empati Perilaku

Empati perilaku merupakan aktualisasi pemahaman kognitif dan afektif dalam komunikasi dan tindakan klinis. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang menghargai, validasi pengalaman pasien, serta respons terapeutik yang sesuai. Kwame & Petrucka (2021) dalam artikelnya menyebutkan, empati perilaku menjadi inti dari *person-centered communication*, yang membedakan komunikasi berbasis tugas dari komunikasi berbasis relasi. Empati hanya bermakna secara klinis apabila diwujudkan dalam perilaku yang dapat dipersepsi pasien.

2. Perbedaan Empati, Simpati, dan Belas Kasih

Distingsi konseptual antara empati, simpati, dan compassion penting untuk kejelasan praktik profesional (Guidi & Traversa, 2021):

- a. Empati melibatkan pemahaman perspektif pasien (kognitif), resonansi emosional terkontrol (afektif), dan tindakan responsif (perilaku).
- b. Simpati cenderung berorientasi pada perasaan diri terhadap penderitaan orang lain, sering kali tanpa pemahaman perspektif yang mendalam.
- c. *Compassion* (belas kasih) melibatkan dorongan moral untuk meringankan penderitaan, namun tidak selalu mensyaratkan akurasi perspektif.

Dalam praktik klinis, empati lebih operasional karena mengintegrasikan dimensi kognitif dan perilaku secara sistematis. (Guidi & Traversa, 2021) dalam artikelnya menekankan pentingnya *engaged curiosity*, ketertarikan moral yang reflektif terhadap pengalaman pasien, sebagai bentuk empati yang matang.

3. Dampak Empati dalam Pelayanan Kesehatan

a. Dampak terhadap Kepuasan Pasien

Tinjauan sistematis dalam Nembhard, (2023) menunjukkan hubungan konsisten antara empati tenaga kesehatan dan peningkatan kepuasan pasien. Pasien yang merasakan empati melaporkan pengalaman layanan yang lebih positif, kepercayaan yang lebih tinggi, serta persepsi kualitas yang lebih baik.

b. Dampak terhadap Kepatuhan Terapi

Empati juga berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan terhadap rencana pengobatan. Studi dalam artikel Nembhard, (2023) menunjukkan bahwa pasien dengan dokter yang memiliki skor empati lebih tinggi cenderung menunjukkan luaran klinis yang lebih baik, termasuk pada penyakit kronis seperti diabetes. Empati meningkatkan kepatuhan karena pasien merasa dipahami dan dilibatkan dalam keputusan terapi.

- c. Dampak terhadap Kualitas Komunikasi Klinis

Artikel Bauchat (2016) menunjukkan bahwa komunikasi empatik berkorelasi dengan penurunan kejadian kesalahan komunikasi yang dapat berujung pada sentinel events. Empati meningkatkan akurasi informasi, memperjelas ekspektasi, serta mengurangi konflik. Dalam perspektif neurobehavioral, komunikasi empatik juga memodulasi stres dan persepsi nyeri melalui mekanisme psikobiologis yang terukur (Decety & Li, 2025).
- 4. Hambatan Pengembangan Empati dalam Praktik Klinis
 - a. Tekanan Sistem dan Efisiensi

Artikel Kerasidou, (2019) menunjukkan bahwa orientasi target dan tekanan efisiensi dapat menggeser fokus profesional dari relasi empatik menuju produktivitas kuantitatif. Target berbasis waktu dan beban administratif mengurangi ruang interaksi bermakna dengan pasien.
 - b. Beban Kerja dan Burnout

Burnout dan kelelahan emosional merupakan faktor signifikan yang menurunkan empati. Dalam artikel Moudatsou, (2020), empati rendah dikaitkan dengan tingkat stres dan depresi yang lebih tinggi pada tenaga kesehatan.
 - c. Budaya Pendidikan Klinis

Beberapa studi menunjukkan adanya penurunan empati selama fase pendidikan klinis. Tanpa intervensi reflektif dan pelatihan komunikasi, empati dapat mengalami erosi seiring peningkatan tekanan akademik dan eksposur terhadap penderitaan pasien.
 - d. Tantangan Teknologi dan Digitalisasi

Artikel Koranteng, (2023) menyoroti risiko reduksi empati menjadi ekspresi algoritmik dalam era *AI*. Meskipun teknologi dapat mendukung efisiensi, empati manusia tetap memerlukan kehadiran relasional yang autentik.

D. Nilai Kemanusiaan dan Martabat dalam Praktik Pelayanan Kesehatan

1. Hakikat Nilai Kemanusiaan dalam Pelayanan Kesehatan

Nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan berakar pada pengakuan bahwa pasien bukan sekadar pembawa penyakit, melainkan pribadi yang memiliki martabat, hak, identitas sosial, dan pengalaman hidup yang unik. Etika klinis modern menegaskan bahwa praktik medis tidak hanya berkaitan dengan intervensi biologis, tetapi juga relasi moral antara profesional dan pasien (Varkey, 2021).

Dalam kerangka etika biomedis, penghormatan terhadap martabat manusia merupakan landasan bagi prinsip otonomi, keadilan, dan non-diskriminasi.

Pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan nilai sosial, budaya, dan politik yang membentuk pengalaman sakit (Ashcroft et al., 2007). Dengan demikian, nilai kemanusiaan bukan tambahan eksternal, tetapi inti dari praktik kesehatan yang bermakna.

WHO *Code of Ethics* (2023) secara eksplisit menyatakan kewajiban untuk menunjukkan rasa hormat, kesetaraan, dan compassion terhadap semua manusia tanpa diskriminasi. Pernyataan ini memperluas nilai kemanusiaan dari relasi individual menjadi komitmen institusional.

2. Martabat (*Dignity*) sebagai Prinsip Normatif

Martabat manusia merujuk pada nilai intrinsik yang melekat pada setiap individu terlepas dari kondisi fisik, sosial, atau ekonominya. Dalam praktik klinis, martabat diwujudkan melalui penghormatan terhadap pilihan pasien, perlindungan privasi, komunikasi yang bermakna, serta perlakuan yang bebas dari pelecehan atau diskriminasi (Varkey, 2021).

Dalam konteks konflik bersenjata atau krisis kemanusiaan, tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi serta tidak boleh terlibat dalam tindakan yang merendahkan martabat manusia (World Health Organization (WHO), 2016). Prinsip ini menempatkan martabat sebagai nilai absolut yang tidak dapat dikompromikan.

Pendekatan *deontologis* mendukung gagasan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai sarana untuk tujuan lain. Dalam konteks pelayanan kesehatan, ini berarti pasien tidak boleh direduksi menjadi "kasus" (hanya dilihat dari diagnosis atau kondisi medisnya (misalnya: "stroke di bed 12") tanpa mempertimbangkan identitas, nilai, dan pengalaman hidupnya) "nomor tempat tidur" (hanya direduksi menjadi bagian dari sistem administratif rumah sakit, sekadar unit pelayanan dalam alur kerja, bukan pribadi yang memiliki cerita dan kebutuhan unik), atau "objek penelitian" (hanya dijadikan sarana untuk kepentingan ilmiah tanpa penghormatan terhadap otonomi, informed consent, dan kesejahteraannya). Kalimat itu menegaskan prinsip martabat manusia dalam praktik klinis, dimana diagnosis tidak boleh menghapus identitas personal, Efisiensi sistem tidak boleh menghilangkan relasi manusiawi, serta penelitian tidak boleh mengorbankan martabat dan hak individu. Intinya, pasien adalah subjek moral yang utuh, bukan entitas fungsional dalam sistem Kesehatan.

3. Hak Pasien dan Realisasi Nilai Kemanusiaan

Hak pasien merupakan artikulasi konkret dari penghormatan terhadap martabat manusia. Hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menyetujui atau

menolak tindakan medis, hak atas kerahasiaan, serta hak untuk diperlakukan secara adil merupakan manifestasi normatif dari nilai kemanusiaan (Varkey, 2021).

Empati memiliki fungsi dalam merealisasikan hak-hak tersebut, karena pemahaman perspektif pasien menjadi prasyarat bagi implementasi otonomi dan informed consent. Tanpa empati, hak pasien berisiko menjadi prosedur administratif semata (Albuquerque & Howick, 2023).

Dalam konteks kebijakan kesehatan, perlindungan hak pasien memerlukan integrasi antara norma etika dan regulasi hukum (Shetty, 2023; Widiyanto & Darmayanti, 2025). Hukum memberikan perlindungan formal, tetapi etika memastikan implementasi yang bermakna.

4. Sensitivitas Budaya dan Konteks Sosial

Nilai kemanusiaan tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sosial pasien. Praktik kesehatan yang humanistik menuntut sensitivitas terhadap perbedaan keyakinan, tradisi, dan sistem nilai. Ashcroft et al (2007), dalam buku *Principles of Health Care Ethics*, menyoroti bahwa pluralitas budaya menuntut pendekatan reflektif yang tidak memaksakan nilai tunggal

Dalam perspektif global health, Jindal dan Tiwari, (2025), *juga* menekankan bahwa keadilan dan inklusivitas harus menjadi determinan moral dalam distribusi layanan kesehatan. Nilai kemanusiaan berarti memastikan bahwa kelompok rentan—termasuk mereka yang miskin, minoritas, atau terdampak konflik—tidak terpinggirkan dalam sistem kesehatan.

5. Relasi Tenaga Kesehatan–Pasien sebagai Relasi Moral

Hubungan tenaga kesehatan dan pasien bukan sekadar relasi teknis, melainkan relasi moral yang ditandai oleh kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kesejahteraan pasien. Relasi ini bersifat komplementer dan saling menghormati (Burggraeve et al., 2017).

Empati berperan sebagai jembatan yang memungkinkan nilai kemanusiaan terwujud dalam praktik sehari-hari. Tanpa empati, hubungan profesional dapat tereduksi menjadi interaksi prosedural yang dingin dan terfragmentasi.

Dalam konteks tekanan efisiensi dan target sistem, artikel Kerasidou (2019), menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan rentan terpinggirkan ketika pelayanan dipandang sebagai lini produksi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap relasi moral menjadi bagian dari tanggung jawab institusional.

6. Pelayanan Kesehatan sebagai Praktik Kemanusiaan

Pelayanan kesehatan yang berorientasi humanistik memandang penyembuhan sebagai proses biologis sekaligus relasional. Model pelayanan terintegrasi yang ditampilkan dalam Varkey (2021) menempatkan caring sebagai pusat, dengan etika dan profesionalisme terjalin bersama kompetensi teknis.

Dalam kerangka ini, nilai kemanusiaan tidak berdiri terpisah dari keunggulan klinis, melainkan menjadi syarat bagi praktik yang bermartabat. Pelayanan kesehatan yang bermutu bukan hanya yang efektif secara teknis, tetapi juga yang menjaga penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap interaksi.

E. Integrasi Etika, Empati, dan Nilai Kemanusiaan dalam Praktik Pelayanan Kesehatan

1. Kerangka Integratif: Dari Prinsip ke Praktik

Etika, empati, dan nilai kemanusiaan sering dipahami sebagai konsep terpisah. Namun dalam praktik klinis, ketiganya membentuk satu kesatuan normatif yang saling menopang. Prinsip etika menyediakan kerangka rasional; empati menyediakan medium relasional; nilai kemanusiaan menyediakan orientasi moral. Integrasi ketiganya menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang holistik.

Varkey (2021), menampilkan model pelayanan pasien yang menempatkan caring sebagai pusat, dengan etika dan profesionalisme terintegrasi bersama kompetensi klinis. Model ini menunjukkan bahwa keunggulan teknis tanpa fondasi etis dan relasional tidak memadai untuk praktik yang bermartabat.

Dalam konteks organisasi global, WHO *Code of Ethics* (2023) menegaskan prinsip integritas, akuntabilitas, imparialitas, penghormatan terhadap martabat, dan profesionalisme. Prinsip-prinsip tersebut menghubungkan standar moral individual dengan budaya institusional.

2. Pengambilan Keputusan Klinis Berbasis Empati dan Prinsip

Pengambilan keputusan klinis sering melibatkan konflik antara prinsip-prinsip etika, terutama antara beneficence dan autonomy. Varkey (2021) menguraikan pendekatan sistematis dalam menyelesaikan konflik tersebut melalui analisis konteks, klarifikasi nilai, dan deliberasi rasional

Empati memperkaya proses ini dengan memberikan pemahaman kontekstual terhadap preferensi pasien. Albuquerque, (2023), dalam artikelnya menegaskan bahwa empati memiliki fungsi epistemik dalam membantu profesional memahami makna subjektif dari kondisi pasien, sehingga keputusan tidak bersifat paternalistik.

Sebagai contoh, dalam situasi pasien menolak terapi yang secara klinis menguntungkan, pendekatan utilitarian mungkin menekankan hasil terbaik, sedangkan pendekatan deontologis menekankan penghormatan terhadap otonomi (Heller et al., 2026). Integrasi empati memungkinkan dialog reflektif yang mengklarifikasi nilai pasien sebelum keputusan final diambil.

3. Komunikasi Terapeutik sebagai Wujud Integrasi

Komunikasi terapeutik merupakan ruang konkret di mana etika, empati, dan nilai kemanusiaan bertemu. Kwame & Petrucka (2021), dalam artikelnya menyebutkan bahwa komunikasi yang berpusat pada pribadi (*person-centered communication*) menjadi indikator utama keberhasilan integrasi tersebut.

Empati perilaku—melalui validasi, mendengarkan aktif, dan penggunaan bahasa yang menghormati—mewujudkan penghormatan terhadap martabat pasien. Komunikasi juga menjadi sarana implementasi informed consent dan truth-telling (Varkey, 2021). Tanpa komunikasi empatik, prinsip etika berisiko tereduksi menjadi prosedur administratif.

4. Integrasi pada Level Sistem dan Kebijakan

Integrasi etika dan empati tidak cukup pada level individu; diperlukan dukungan struktural. Kerasidou (2019), dalam artikelnya menunjukkan bahwa tekanan efisiensi dan target berbasis indikator dapat menggerus ruang relasional dalam praktik klinis. Oleh karena itu, sistem harus dirancang untuk melindungi interaksi bermakna antara profesional dan pasien.

Shetty (2023) dan Widiyanto & Darmayanti (2025), menegaskan bahwa kebijakan kesehatan harus berakar pada pertimbangan moral, bukan sekadar kalkulasi administratif

Kebijakan triase, distribusi sumber daya, dan regulasi teknologi harus mempertimbangkan keadilan distributif serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam konteks global health, Jindal dan Tiwari (2025) menekankan bahwa moral determinants, keadilan, inklusivitas, dan equity, harus membimbing desain sistem kesehatan

5. Integrasi dalam Pendidikan dan Budaya Profesional

Empati sebagai kompetensi inti perlu dikembangkan melalui pendidikan reflektif dan pelatihan komunikasi. Sebuah studi dari Moudatsou et al, (2020) menunjukkan bahwa empati dapat ditingkatkan melalui metode pembelajaran berbasis pengalaman, simulasi, dan refleksi.

Budaya profesional yang humanistik juga memerlukan kepemimpinan etis. Dalam konteks perawatan intensif, artikel (Baronia, (2019) menunjukkan bahwa empati mendukung resolusi konflik, membangun kepercayaan, dan meningkatkan mutu pelayanan dalam lingkungan bertekanan tinggi. Integrasi etika, empati, dan nilai kemanusiaan dengan demikian merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan pembentukan karakter profesional dan desain sistem yang mendukung.

6. Model Konseptual Integrasi

Berdasarkan sintesis Bab 2–4, integrasi dapat dirumuskan dalam tiga lapisan:

- a. Lapisan Normatif – Prinsip etika (autonomy, beneficence, non-maleficence, justice).
- b. Lapisan Relasional – Empati sebagai medium komunikasi dan pengambilan keputusan.
- c. Lapisan Humanistik – Penghormatan terhadap martabat, keadilan sosial, dan sensitivitas budaya.

Ketiga lapisan ini saling berinteraksi. Tanpa prinsip, empati kehilangan arah normatif. Tanpa empati, prinsip kehilangan medium relasional. Tanpa orientasi humanistik, keduanya kehilangan tujuan moral.

F. Tantangan dan Dilema Etis dalam Pelayanan Kesehatan kontemporer.

1. Kompleksitas Moral dalam Praktik Klinis Modern

Pelayanan kesehatan kontemporer berlangsung dalam lingkungan yang ditandai oleh kemajuan teknologi, tekanan efisiensi, kompleksitas hukum, serta meningkatnya ekspektasi publik. Kondisi ini menciptakan ruang dilema etis yang semakin kompleks, di mana prinsip-prinsip dasar etika tidak selalu dapat diterapkan secara linear.

Varkey (2021), dalam *Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice*, menegaskan bahwa konflik antara autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice merupakan bagian inheren dari praktik klinis. Oleh karena itu, dilema etis bukan penyimpangan dari praktik profesional, melainkan konsekuensi dari kompleksitas moral dalam pelayanan kesehatan.

2. Konflik Antar-Prinsip Etika

a. Autonomy vs Beneficence

Salah satu konflik klasik muncul ketika pasien menolak intervensi yang secara klinis menguntungkan. Pendekatan utilitarian mungkin mendukung tindakan demi hasil terbaik, sedangkan pendekatan deontologis menuntut penghormatan terhadap pilihan pasien (Heller et al., 2026).

Tanpa empati, konflik ini berisiko berubah menjadi paternalistik. Dengan empati, profesional dapat mengeksplorasi nilai dan ketakutan pasien sebelum mengambil keputusan (Albuquerque & Howick, 2023).

b. Beneficence vs Justice

Konflik juga muncul dalam alokasi sumber daya terbatas. Dalam situasi triase atau keterbatasan ICU, keputusan harus mempertimbangkan keadilan distributif sekaligus manfaat klinis maksimal. Ashcroft et al., (2007) dalam bukunya *Principles of Health Care Ethics* menegaskan bahwa keadilan

distributif memerlukan refleksi sosial dan politik yang melampaui relasi individual

3. Tekanan Sistem dan Efisiensi

Orientasi target berbasis indikator dapat menciptakan "*crowding out*" empati. Ketika kinerja diukur melalui waktu tunggu dan jumlah pasien, interaksi relasional cenderung terpinggirkan (Kerasidou, 2019).

Tekanan administratif dan beban dokumentasi digital mempersempit waktu komunikasi bermakna dengan pasien. Dalam kondisi ini, prinsip *beneficence* dan nilai kemanusiaan dapat tereduksi menjadi penyelesaian prosedur.

4. Moral Distress dan Burnout Profesional

Dilema etis yang berulang dapat memicu *moral distress*, yaitu kondisi ketika profesional mengetahui tindakan yang secara moral benar, tetapi terhalang oleh sistem atau kebijakan untuk melaksanakannya. Penelitian Moudatsou (2020), menunjukkan bahwa empati yang tidak didukung regulasi emosi dan dukungan organisasi dapat meningkatkan risiko burnout.

Moral distress memperlihatkan bahwa dilema etis tidak hanya berdampak pada pasien, tetapi juga pada kesejahteraan tenaga kesehatan.

5. Tantangan Teknologi dan Digitalisasi

Integrasi kecerdasan buatan dan sistem digital menghadirkan dilema baru. Koranteng (2023) dalam artikelnya menyoroti bahwa teknologi berbasis *large language models* dapat mensimulasikan respons empatik, tetapi tidak menggantikan relasi moral manusia. Risiko bias algoritmik juga berpotensi memperkuat ketidakadilan struktural.

Dilema muncul ketika efisiensi teknologi berbenturan dengan kebutuhan relasional pasien. Sistem kesehatan harus memastikan bahwa inovasi tidak mengikis martabat manusia.

6. Dilema dalam Konteks Krisis dan Konflik

WHO (2016), menegaskan bahwa dalam situasi ekstrem, profesional kesehatan tetap terikat pada kewajiban moral untuk tidak menyiksa, tidak mendiskriminasi, dan memprioritaskan pasien

Dalam krisis, dilema sering muncul antara kewajiban profesional dan tekanan politik atau militer. Prinsip *non-maleficence* dan penghormatan terhadap martabat manusia harus tetap menjadi batas absolut.

7. Strategi Menghadapi Dilema Etis

Menghadapi dilema etis memerlukan pendekatan reflektif dan sistematis:

- a. Identifikasi konflik prinsip – Klarifikasi nilai yang terlibat.
- b. Analisis konsekuensi dan kewajiban – Gunakan lensa utilitarian dan deontologis

- c. Integrasi empati – Pahami perspektif pasien secara kontekstual.
- d. Deliberasi kolektif – Libatkan tim interprofesional.
- e. Rujukan pada kode etik profesional

(Heller et al., 2026; World Health Organization, 2023)

Pendekatan ini membantu menjaga keseimbangan antara kepatuhan sistem dan komitmen moral profesional.

G. Transformasi Pelayanan Kesehatan Menuju Pendekatan Holistik dan Humanistik

1. Sintesis Konseptual: Integrasi Etika, Empati, dan Nilai Kemanusiaan

Bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang bermakna tidak dapat dipisahkan dari integrasi tiga elemen utama: prinsip etika sebagai kerangka normatif, empati sebagai medium relasional, dan nilai kemanusiaan sebagai orientasi moral. Ketiganya membentuk fondasi konseptual bagi pendekatan holistik dan humanistik dalam pelayanan kesehatan. Prinsip etika, *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*—memberikan struktur rasional dalam pengambilan keputusan klinis. Namun, prinsip tersebut hanya efektif ketika diterjemahkan melalui empati yang memungkinkan pemahaman kontekstual atas pengalaman pasien (Albuquerque & Howick, 2023).

Nilai kemanusiaan, terutama penghormatan terhadap martabat, memastikan bahwa pasien diperlakukan sebagai subjek moral yang utuh, bukan sekadar objek intervensi medis (Ashcroft et al., 2007). Dengan demikian, pendekatan holistik tidak hanya mencakup aspek biologis, tetapi juga dimensi psikologis, sosial, dan moral pasien.

2. Implementasi pada Level Individu Profesional

Transformasi menuju pelayanan humanistik dimulai dari profesional kesehatan sebagai agen moral. Kompetensi teknis perlu disertai dengan:

- a. Refleksi etis berkelanjutan – kemampuan mengidentifikasi konflik nilai dan melakukan deliberasi moral (Varkey, 2021).
- b. Regulasi emosi – menjaga empati tanpa terjebak dalam distress pribadi (Decety & Li, 2025).
- c. Komunikasi terapeutik empatik – membangun hubungan yang berpusat pada pasien (Kwame & Petrucka, 2021).
- d. Ketahanan terhadap moral distress – menjaga integritas profesional dalam tekanan sistem.

Pendekatan holistik menuntut profesional tidak hanya mengobati penyakit, tetapi juga memahami makna sakit bagi pasien.

3. Implementasi pada Level Institusi dan Sistem

Pendekatan humanistik tidak dapat bergantung pada individu semata. Institusi kesehatan harus menciptakan budaya organisasi yang mendukung etika dan empati.

WHO Code of Ethics (2023) menegaskan prinsip integritas, akuntabilitas, penghormatan terhadap martabat, dan non-diskriminasi. Prinsip ini perlu diterjemahkan dalam kebijakan operasional, termasuk:

- a. Desain sistem kerja yang memberi ruang komunikasi bermakna,
- b. Pengurangan beban administratif yang menghambat relasi terapeutik,
- c. Mekanisme dukungan bagi tenaga kesehatan yang mengalami moral distress,
- d. Evaluasi mutu yang tidak hanya berbasis indikator kuantitatif, tetapi juga pengalaman pasien.

Kerasidou (2019), dalam artikelnya menunjukkan bahwa tekanan efisiensi dapat menggerus dimensi relasional pelayanan. Oleh karena itu, transformasi sistemik diperlukan agar efisiensi tidak mengorbankan martabat manusia.

4. Implikasi bagi Pendidikan Profesi Kesehatan

Pendekatan holistik dan humanistik harus dimulai sejak pendidikan. Empati sebagai kompetensi inti perlu dikembangkan melalui metode pembelajaran reflektif, simulasi klinis, diskusi kasus etis, dan supervisi berbasis pengalaman. Literatur menunjukkan bahwa empati dapat mengalami penurunan selama pendidikan klinis jika tidak didukung intervensi terstruktur (Moudatsou et al., 2020). Oleh karena itu, kurikulum harus mengintegrasikan:

- a. Pendidikan etika klinis berbasis kasus,
- b. Pelatihan komunikasi empatik,
- c. Evaluasi kompetensi empati,
- d. Penguatan sensitivitas budaya dan keadilan sosial.

Pendidikan yang hanya menekankan kompetensi teknis berisiko menghasilkan profesional yang cakap secara klinis tetapi miskin dimensi humanistik.

5. Tantangan Masa Depan dan Rehumanisasi Pelayanan

Digitalisasi dan kecerdasan buatan menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Teknologi dapat meningkatkan akses dan efisiensi, tetapi tidak menggantikan relasi moral manusia (Koranteng et al., 2023).

Pendekatan holistik di masa depan harus memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengurangi kehadiran empatik dan penghormatan terhadap martabat pasien. Rehumanisasi pelayanan kesehatan memerlukan keseimbangan antara presisi teknologi dan kehangatan relasional.

Dalam konteks global health, keadilan distributif dan equity menjadi penentu keberhasilan sistem kesehatan (Jindal & Tiwari, 2025). Pendekatan humanistik harus memperluas cakupan moralnya hingga tingkat kebijakan dan distribusi sumber daya.

H. Penutup

Pelayanan kesehatan yang bermakna tidak pernah berdiri semata pada kecanggihan teknologi, presisi diagnosis, atau efisiensi sistem. Di balik seluruh kemajuan tersebut, terdapat dimensi moral yang menentukan arah dan kualitas praktik pelayanan. Bab ini menegaskan bahwa etika, empati, dan nilai kemanusiaan merupakan fondasi konseptual yang tidak terpisahkan dalam membangun pelayanan kesehatan yang holistik dan humanistik.

Etika menyediakan kerangka normatif yang membimbing keputusan klinis melalui prinsip otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan. Empati menghadirkan medium relasional yang memungkinkan prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan secara kontekstual dan bermakna dalam interaksi nyata antara tenaga kesehatan dan pasien. Nilai kemanusiaan, terutama penghormatan terhadap martabat manusia, menjadi orientasi moral yang memastikan bahwa setiap tindakan medis tetap berakar pada pengakuan terhadap keutuhan pribadi pasien.

Dalam praktik kontemporer yang ditandai oleh tekanan efisiensi, kompleksitas hukum, dan perkembangan teknologi digital, risiko dehumanisasi pelayanan kesehatan menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, pendekatan holistik dan humanistik bukan sekadar pilihan normatif, melainkan kebutuhan struktural untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik. Transformasi pelayanan kesehatan memerlukan integrasi antara refleksi etis, kompetensi empatik, dan komitmen institusional terhadap keadilan serta martabat manusia.

Pendekatan holistik menuntut pemahaman pasien secara menyeluruh—biologis, psikologis, sosial, dan moral. Pendekatan humanistik menegaskan bahwa penyembuhan tidak hanya berarti mengatasi penyakit, tetapi juga memulihkan rasa aman, dihargai, dan dipahami. Keduanya hanya dapat terwujud apabila etika, empati, dan nilai kemanusiaan tidak diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai inti praktik pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, penguatan dimensi moral dalam sistem kesehatan menjadi agenda berkelanjutan yang melibatkan pendidikan profesi, budaya organisasi, kebijakan publik, serta refleksi individu profesional. Pelayanan kesehatan yang berorientasi holistik dan humanistik pada akhirnya bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tetapi tentang bagaimana dan untuk siapa tindakan tersebut dilakukan—yakni demi martabat dan kesejahteraan manusia secara utuh.

I. Referensi

- Albuquerque, A., & Howick, J. (2023). The moral role of clinical empathy in patient healthcare. *International Journal of Family & Community Medicine*, 7(1), 11–14. <http://doi.org/10.15406/ijfcm.2023.07.00304>
- Ashcroft, R., Dawson, A., Draper, H., & McMillan, J. (2007). *PRINCIPLES OF HEALTH Second Edition*. John Wiley & Sons Ltd, The.
- Baronia, A. (2019). Empathy: An essential skill in the intensive care units. *Indian Journal of Critical Care Medicine*, 23(9), 391. <http://doi.org/10.5005/jp-journals-10071-23230>
- Bauchat, J. R., Seropian, M., & Jeffries, P. R. (2016). Communication and Empathy in the Patient-Centered Care Model-Why Simulation-Based Training Is Not Optional. *Clinical Simulation in Nursing*, 12(8), 356–359. <http://doi.org/10.1016/j.ecns.2016.04.003>
- Beauchamp, T. L. (1979). Principles of biomedical ethics. In J. F. Childress. (Ed.), *New York: Oxford University Press*.
- Burggraeve, R., Campbell, P., Comer, A. R., Cross, B., Kruger, W., Lewitt, M. S., ... Viljoen, C. (2017). *Healthcare ethics for Healthcare Practitioners*. (L. O. K. Lategan & G. J. Van Zyl, Eds.) *Sun Media Bloemfontein*. Bloemfontein: UJ Press. <http://doi.org/10.18820/9781920382995>
- Decety, J., & Li, J. (2025). The value of empathy in medical practice: A neurobehavioral perspective. *Social Sciences and Humanities Open*, 12(March), 101956. <http://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101956>
- Guidi, C., & Traversa, C. (2021). Empathy in patient care: from "Clinical Empathy" to "Empathic Concern." *Medicine, Health Care and Philosophy*, 24(4), 573–585. <http://doi.org/10.1007/s11019-021-10033-4>
- Heller, T., Wyllie, A., Haresnape, J., Davey, B., & Furniss, P. (2026). Health Management, Ethics and Research Module: 7. Principles of Healthcare Ethics. *Health Management, Ethics and Research*, (February), 1–6. Retrieved from <https://www.open.edu/openlearncreate/mod/oucontent/view.php?id=225&printable=1>
- Hodge, D. A., & Collins, E. M. (2024). Ethics of Empathy and Care in Post-COVID Vision Loss: The Case of Dr. Ebony Michelle Collins. *Journal of Healthcare, Science and the Humanities*, 14(1), 212–219. Retrieved from <http://europepmc.org/abstract/MED/40927601%0Ahttps://europepmc.org/articles/PMC12416250%0Ahttps://europepmc.org/articles/PMC12416250?pdf=render>
- Hojat, M. (2016). *Empathy in health professions education and patient care. Empathy in Health Professions Education and Patient Care*. <http://doi.org/10.1007/978-3-319-27625-0>

- Jeffrey, D. (2016). Empathy, sympathy and compassion in healthcare: Is there a problem? Is there a difference? Does it matter? *Journal of the Royal Society of Medicine*, 109(12), 446–452. <http://doi.org/10.1177/0141076816680120>
- Jindal, R. M., & Tiwari, S. (2025). How should morality play a role in global health? *BMJ Global Health*, 10(10), e019118. <http://doi.org/10.1136/bmjgh-2025-019118>
- Kerasidou, A. (2019). Empathy and Efficiency in Healthcare at Times of Austerity. *Health Care Analysis*, 27(3), 171–184. <http://doi.org/10.1007/s10728-019-00373-x>
- Koranteng, E., Rao, A., Flores, E., Lev, M., Landman, A., Dreyer, K., & Succi, M. (2023). Empathy and Equity: Key Considerations for Large Language Model Adoption in Health Care. *JMIR Medical Education*, 9(1), 9–12. <http://doi.org/10.2196/51199>
- Kwame, A., & Petrucka, P. M. (2021). A literature-based study of patient-centered care and communication in nurse-patient interactions: barriers, facilitators, and the way forward. *BMC Nursing*, 20(1), 158. <http://doi.org/10.1186/s12912-021-00684-2>
- Larasati, T., Fardiansyah, A. I., Saketi, D., & Dewiarti, A. N. (2024). THE ETHICAL AND LEGAL ASPECTS OF HEALTH POLICY ON ELECTRONIC MEDICAL RECORDS IN INDONESIA. *Cepalo*, 8(2), 103–112. <http://doi.org/10.25041/cepalo.v8no2.3634>
- Lategan, L. O. K., & Zyl, G. J. van (Eds.). (2017). *Healthcare Ethics for Healthcare Practitioners*. Sun Media Bloemfontein (Pty) Ltd.
- Moudatsou, M., Stavropoulou, A., Philalithis, A., & Koukouli, S. (2020). The role of empathy in health and social care professionals. *Healthcare (Switzerland)*, 8(1), 7–9. <http://doi.org/10.3390/healthcare8010026>
- Nembhard, I. M., David, G., Ezzeddine, I., Betts, D., & Radin, J. (2023). A systematic review of research on empathy in health care. *Health Services Research*, 58(2), 250–263. <http://doi.org/10.1111/1475-6773.14016>
- Schverer, M., O'Mahony, S. M., O'Riordan, K. J., Donoso, F., Roy, B. L., Stanton, C., ... Cryan, J. F. (2020). Dietary phospholipids: Role in cognitive processes across the lifespan. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 111(November 2019), 183–193. <http://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2020.01.012>
- Shetty, N. (2023). Medical Ethics and Law. *Indian Journal of Orthopaedics*, 57(11), 1744–1747. <http://doi.org/10.1007/s43465-023-00972-w>
- Varkey, B. (2021). Principles of Clinical Ethics and Their Application to Practice. *Medical Principles and Practice*, 30(1), 17–28. <http://doi.org/10.1159/000509119>

- Widiyanto, E., & Darmayanti, R. (2025). BALANCE BETWEEN ETHICS AND LAW IN HEALTH PRACTICE. *Journal of Hospital Management and Services*, 7(1), 1–5. Retrieved from <https://thejhms.org/index.php/JHMS>
- World Health Organization. (2023). WHO Code of Ethics, 1–32.
- World Health Organization (WHO). (2016). Ethical Principles of Health Care in Times of Armed Conflict. *International Committee of the Red Cross*, (Icmm), 5–6. Retrieved from <https://www.icrc.org/en/document/common-ethical-principles-health-care-conflict-and-other-emergencies>

CHAPTER 7

TANTANGAN PENERAPAN PELAYANAN HOLISTIK DI FASILITAS KESEHATAN

Hanafi, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan

Penerapan pelayanan holistik di fasilitas kesehatan menekankan interaksi sentral antara dimensi fisik, mental, sosial, dan spiritual pasien dalam kaitannya dengan perawatan komprehensif pasien. Pelayanan holistik menghormati bahwa kesehatan memiliki faktor lingkungan, gaya hidup, dukungan keluarga, dan nilai-nilai budaya pada pasien, dan karena itu, strategi perawatan bukan hanya tentang penyakit melainkan juga kualitas hidup dan kesejahteraan. Implementasi pelayanan holistik mencakup kolaborasi multi-disiplin, komunikasi yang untuk empatik, dan melibatkan pasien serta keluarga dalam perencanaan dan evaluasi rencana perawatan searas preferensi dan konteks kehidupan pasien tersebut yang harus dilakukan oleh departemen kesehatan (Kemenkes, 2019). Tantangan utama dalam penerapan pelayanan holistik meliputi keterbatasan sumber daya misalnya kekurangan tenaga kesehatan yang terlatih dan berpengalaman dalam memberikan pelayanan holistik menjadi salah satu hambatan utama tantangan lain seperti waktu, tenaga, dan infrastruktur pendukung, serta kebutuhan akan pelatihan komunikasi lintas budaya dan profesi. Hambatan sistemik, seperti fragmentasi informasi kesehatan, variasi standar praktik antar fasilitas, dan kendala pembiayaan, juga dapat menghambat koordinasi antar penyedia layanan. Upaya peningkatan holistik perlu didorong melalui kebijakan yang mendukung pendidikan interprofesi, penerapan standar pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi dampak yang mencakup kualitas hidup pasien dan hasil klinis (Liapi et al., 2025)

B. Ruang Lingkup Pelayanan Holistik

Pelayanan holistik menekankan perawatan yang melihat individu secara komprehensif, melibatkan dimensi fisik, mental/emosional, sosial, spiritual, dan lingkungan. Pendekatan ini berakar pada filsafat humanistik dalam keperawatan yang menyoroti martabat, otonomi pasien, serta keseimbangan antar dimensi kesejahteraan. Dalam konteks kesehatan publik dan klinis, pelayanan holistik menghindari reduksionisme penyakit semata dan menekankan kesejahteraan secara menyeluruh serta kapasitas adaptif individu terhadap stres lingkungan (Pesut, 2013)

1. Dimensi keperawatan holistik

Menurut (Melva Epy Mardiana Manurung, 2023) terdapat beberapa dimensi dalam pemberian pelayanan secara holistik:

a. Dimensi fisik

Kesejahteraan fisik adalah kemampuan untuk menjaga kesehatan yang memungkinkan kita melakukan aktivitas sehari-hari tanpa merasa terlalu lelah atau mengalami stres berlebihan. Hal ini mencakup berbagai kebiasaan sehat seperti berolahraga cukup, mengonsumsi makanan bergizi, dan menghindari kebiasaan buruk seperti penggunaan narkoba serta konsumsi alkohol yang berlebihan. Artinya, kita perlu belajar mengenali tanda-tanda penyakit, rutin melakukan pemeriksaan kesehatan, serta menjaga diri agar tidak terkena cedera atau bahaya. Membiasakan diri berbuat baik setiap hari, yang bisa membuat hidup lebih lama dan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup selama masa tersebut.

b. Dimensi sosial

Kesejahteraan sosial berarti kemampuan seseorang untuk berhadapan dengan baik dengan orang-orang di seluruh dunia dan menjalankan tugas serta tanggung jawab yang diharapkan dari peran pribadinya. Ini berarti belajar berkomunikasi dengan baik, menjalin hubungan dekat dengan orang lain, dan membangun lingkaran teman serta keluarga yang bisa saling mendukung. Kesehatan sosial mencakup menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain serta terhadap diri sendiri. Ketika kita melihat orang-orang yang berinteraksi dengan kita, mereka seperti cermin yang menunjukkan sisi diri kita sendiri. Dengan melihat cara mereka berperilaku, kita pun punya kesempatan untuk berkembang dan memahami diri sendiri lebih dalam. Bergabung dengan komunitas di sekitar dan di dunia akan menciptakan rasa memiliki.

c. Dimensi emosional

Pada dimensi ini individu dapat mengekspresikan kondisi emosional dan mengendalikan stres dalam menjalankan proses kehidupan dalam menghadapi masalah

d. Dimensi intelektual

Kesejahteraan intelektual merupakan kemampuan seseorang untuk terbuka terhadap ide-ide baru dan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Termasuk dalam hal itu adalah keinginan untuk mempelajari konsep baru, meningkatkan keterampilan, serta mencari tantangan dalam belajar sepanjang hidup, yang dapat meningkatkan kesejahteraan secara intelektual. Dimensi intelektual mendorong kegiatan berpikir yang kreatif dan merangsang. Pikiran seseorang harus terus-menerus diberi semangat dan dijalankan seperti halnya tubuh.

Orang yang cerdas secara intelektual memiliki pikiran yang selalu aktif dan terus belajar. Orang yang cerdas memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kemampuan. Selalu terinformasi tentang hal-hal terbaru dan ikut serta dalam kegiatan yang bisa mengasah pikiran juga sangat penting.

e. Dimensi spiritual

Kesejahteraan rohani adalah kumpulan keyakinan, prinsip, atau nilai yang menjadi pedoman, sehingga membantu memberikan arah dalam hidup seseorang. Ini melibatkan tingkat kepercayaan, keyakinan, dan komitmen yang kuat terhadap keyakinan seseorang yang memberikan perasaan makna dan tujuan. Ini adalah sikap ingin mencari arti dan tujuan dalam hidup manusia, ingin bertanya tentang segala hal, dan menghargai hal-hal yang sulit dijelaskan atau dipahami. Orang yang berakar dari sisi spiritual mencoba merapatkan antara apa yang ada di dalam diri dan kekuatan yang ada di luar diri. Namun yang terpenting, tenaga kesehatan selaku pemberi pelayanan perlu menyadari bahwa perawatan spiritual dimulai dari diri sendiri. Spiritualitas adalah salah satu aspek perawatan pasien yang, ketika diperhatikan, bisa memberikan manfaat positif bagi pasien maupun petugas kesehatan. Spiritualitas memiliki konsep yang luas dan memiliki berbagai perspektif yang berbeda. Pencarian identitas seringkali melibatkan nilai-nilai spiritualitas dalam arti yang luas. Secara subyektif, spiritualitas sangat sulit untuk didefinisikan. Spiritualitas adalah pengalaman pribadi bagi setiap manusia yang secara tidak langsung merusak kita semua. Pengalaman spiritual dianggap sebagai sesuatu yang berkesan sakral dan tinggi, dengan makna yang sangat dalam. Budaya, latar belakang etnis, agama, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja di bidang klinis mempengaruhi cara seseorang memiliki spiritualitas.

C. Nilai Utama dalam Pelayanan Holistik

Pendekatan holistik adalah cara yang melibatkan semua orang secara menyeluruh, dan cara penyampaian informasinya menggunakan berbagai metode yang saling mendukung satu sama lain. Karakteristik holistik adalah mampu menghasilkan manusia yang utuh dalam kehidupan masyarakat, mencakup materi tentang kesatuan hingga kecerdasan intelektual hingga emosi serta tercapainya perkembangan ilmu pengetahuan dan perilaku keterampilan. Nilai utama perawatan holistik dijelaskan sebagai berikut:

1. Filosofi dan Pendidikan - Menekankan bahwa pendekatan yang holistik didasarkan pada suatu kerangka filosofi dan pengetahuan.

2. Keperawatan Holistik, Teori dan Penelitian - Menekankan bahwa pelayanan keperawatan yang profesional didasarkan pada teori, didukung oleh hasil penelitian, dan mengacu pada prinsip etik sebagai pedoman untuk praktik yang kompeten.
3. Holistik *Nurse Save Care* - Keyakinan bahwa perawat harus terlibat dalam perawatan diri agar bisa meningkatkan kesehatan dan kesadaran diri sendiri, sehingga perawat dapat melayani orang lain sebagai alat dalam proses penyembuhan orang lain. Holistik Communication,
4. Therapeutic *Environment and Cultural Competency* - Fokus pada pengembangan untuk menggunakan proses pengkajian dan asuhan terapeutik yang mengacu pada pola, masalah, dan kebutuhan klien, serta lingkungan yang mendukung proses penyembuhan pasien. Holistic caring process - Fokus pada pengembangan untuk menggunakan proses pengkajian dan asuhan terapeutik yang mengacu pada pola, masalah, dan kebutuhan klien, serta lingkungan yang mendukung proses penyembuhan pasien.

D. Tantangan Pelayanan Holistik

1. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan sumber daya seperti tenaga medis, fasilitas, dan dana sering menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan pelayanan holistik. Ketika jumlah tenaga kesehatan terbatas, beban kerja meningkat dan waktu yang tersedia untuk setiap pasien berkurang, sehingga praktisi cenderung fokus pada masalah medis yang segera terlihat daripada pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, dan spiritual pasien. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung dapat membatasi kemampuan untuk menjalankan intervensi non-fisik yang diperlukan dalam perawatan holistik, seperti aktivitas rehabilitasi, konseling, atau program dukungan keluarga. Keterbatasan dana juga mempengaruhi kelengkapan alat, obat, dan akses ke layanan rujukan, sehingga kualitas dan kontinuitas perawatan berisiko menurun. Di sisi lain, minimnya pelatihan dan pengetahuan tentang perawatan holistik di kalangan tenaga kesehatan menjadi kendala penting. Banyak tenaga kesehatan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengintegrasikan aspek biopsikososial-spiritual dalam rencana perawatan, serta kurangnya keterampilan komunikasi yang mendalam untuk menggali kebutuhan non-medis pasien. Akibatnya, pendekatan yang diadopsi cenderung bersifat fragmentaris, tidak terarah pada kesejahteraan holistik pasien secara menyeluruh. Upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, kurikulum yang terstruktur, dan dukungan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengubah paradigma perawatan

dari fokus penyakit semata menjadi pelayanan holistik yang lebih relevan dan berkelanjutan bagi pasien (Hairi et al., 2025)

2. Standar Mutu Pelayanan

Mutu dalam pelayanan kesehatan dapat menentukan sejauh mana pelayanan tersebut dalam memenuhi harapan pelayanan pasien pelayanan harus dilakukan sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan. Kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi manusia untuk hidup layak dan produktif, dan merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi (Agustina et al., 2023). Standar kualitas layanan kesehatan adalah ukuran atau pedoman yang digunakan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi kualitas, keselamatan, kenyamanan, maupun efisiensi. Tujuan standar kualitas ini adalah untuk memastikan bahwa menerima layanan perawatan yang aman, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan medis mereka (Ramdahani, 2025)

3. Integrasi Sistem Informasi

Standarisasi dan integrasi informasi di seluruh sektor kesehatan memang menjadi tantangan besar. Ketika berbagai sistem informasi yang ada tidak memiliki standar yang seragam, data pasien, riwayat pengobatan, dan hasil pemeriksaan sering tersebar di berbagai platform tanpa konsistensi format. Hal ini membuat proses pertukaran informasi antar rumah sakit, klinik, laboratorium, dan fasilitas rehabilitasi menjadi lamban dan rentan kehilangan data. Akibatnya, klinisi kesulitan memperoleh gambaran klinis yang utuh dalam waktu singkat, sehingga potensi koordinasi perawatan antar penyedia layanan menjadi terhambat dan berisiko menimbulkan duplikasi tes, keterlambatan pengambilan keputusan, serta ketidakakuratan dalam manajemen obat.

Selain itu, adanya fragmentasi sistem informasi juga menghambat kerja sama lintas program dan lintas sektor, seperti perawatan primer, rujukan, dan layanan sosial. Ketidakterseragaman protokol interoperabilitas, struktur data, serta terminologi klinis membuat integrasi data menjadi mahal dan teknis secara berkelanjutan. Tanpa integrasi yang memadai, informasi penting seperti alergi, kondisi komorbid, dan preferensi pasien sulit dipertahankan secara konsisten, yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan pasien. Upaya standarisasi, adopsi arsitektur interoperabilitas, serta tata kelola data yang jelas menjadi kunci untuk meningkatkan koordinasi, akurasi, dan efisiensi pelayanan kesehatan secara menyeluruh (Peel et al., 2021)

4. Budaya dan moral

Budaya organisasi yang tidak mendukung perubahan bisa menjadi penghalang utama bagi penerapan pelayanan holistik. Ketika nilai-nilai, kebiasaan kerja, atau struktur hierarki tidak mendorong inovasi, tenaga kesehatan cenderung bertahan pada praktik yang telah mapan meski kurang optimal bagi pendekatan biopsikososial-spiritual. Dilema moral juga dapat muncul ketika tindakan perawatan holistik memerlukan kompromi antara prinsip etika, sumber daya, dan keinginan pasien. Ketidaksetujuan antara kepentingan institusi dan kebutuhan pasien dapat menimbulkan kebingungan, keraguan, atau bahkan penolakan terhadap perubahan, sehingga inisiatif holistik sulit diimplementasikan secara konsisten di berbagai tingkat organisasi. Selain itu, stigma terhadap beberapa kelompok pasien dapat menghambat integrasi layanan yang dibutuhkan untuk perawatan holistik. Sifat diskriminatif atau prasangka yang tidak diungkap secara terbuka bisa mempengaruhi penilaian, akses, dan kualitas interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien tertentu. Akibatnya, kebutuhan non-medik seperti dukungan emosional, sosial, atau budaya mungkin tidak diprioritaskan dengan adil, sehingga pasien merasa tidak sepenuhnya dilayani. Upaya campuran untuk mengatasi budaya organisasi yang mendukung perubahan, mengelola dilema etika, serta mengurangi stigma secara sistematis menjadi kunci untuk memperkuat kapasitas pelayanan holistik yang inklusif dan responsif terhadap semua kelompok pasien. (Searby et al., 2026)

5. Keterjangkauan pelayanan

Standar ini menjamin bahwa layanan kesehatan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak peduli lokasi geografis, sosial ekonomi, atau ketersediaan layanan. Waktu tunggu yang wajar, kemampuan untuk mendapatkan layanan dalam keadaan darurat, dan kemampuan pasien untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang pilihan perawatan yang tersedia adalah contoh aksesibilitas (Faiz et al., 2025)

E. Kesimpulan

Penerapan pelayanan holistik dalam sistem kesehatan harus menghadapi tantangan utama berupa keterbatasan sumber daya, termasuk tenaga medis, fasilitas, dan dana. Ketika sumber daya terbatas, fokus cenderung beralih ke masalah medis yang paling segera terlihat, sehingga aspek biopsikososial-spiritual pasien kurang mendapat perhatian. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengetahuan tenaga kesehatan tentang pendekatan holistik memperkuat hambatan ini, mengakibatkan intervensi yang sering bersifat fragmentaris dan tidak terintegrasi secara menyeluruh. menekankan perlunya standarisasi dan integrasi informasi

antarpelayanan untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan keselamatan pasien. Sistem informasi yang terfragmentasi berisiko menimbulkan duplikasi tes, keterlambatan pengambilan keputusan, dan kehilangan informasi penting seperti riwayat pengobatan dan preferensi pasien. Oleh karena itu, adopsi arsitektur interoperabilitas, standar data, dan tata kelola data yang jelas dinilai krusial untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dan memastikan kualitas perawatan holistik. Menyoroti peran budaya organisasi dan persepsi sosial dalam keberhasilan implementasi pelayanan holistik. Budaya yang tidak mendukung perubahan, dilema etika, serta stigma terhadap kelompok pasien dapat menghambat adopsi pendekatan holistik dan akses layanan yang adil. Upaya yang diperlukan mencakup perubahan budaya organisasi, penanganan dilema etika secara transparan, serta program anti-stigma yang menyeluruh untuk menjamin inklusivitas dan responsivitas layanan terhadap semua pasien, tanpa terkecuali

F. Daftar Pustaka

- Agustina, D., Irawan, A. G., & Ginting, S. O. B. (2023). Manajemen Strategis Pelayanan Puskesmas Di Medan. *J. Kesehat. Tambusai*, 4(2), 998–1007.
- Faiz, M. N., Ritonga, F. R., Anjaini, N., Sembiring, A. S. P., Adelia, N., & Agustina, D. (2025). Kajian Literatur: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Layanan Kesehatan di Rumah Sakit. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5), 2212–2217.
- Hairulisa@Mohd Hairi, N. A., Wan Mamat, W. H., Mohamad Shariff, N., Jaafar, S. N. I., Che Ahmad, A., & Salah, M. (2025). Challenges in Providing Spiritual Care among Healthcare Workers: A Qualitative Study. *IIUM Medical Journal Malaysia*, 24(1), 78–84. <https://doi.org/10.31436/imjm.v23i04.2600>
- Liapi, F., Chater, A. M., Randhawa, G., Stephenson, A., & Pappas, Y. (2025). Factors that influence inter-organisational integration: a qualitative exploration of service providers' perspectives from an integrated care initiative. *BMC Health Services Research*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-025-13051-7>
- Melva Epy Mardiana Manurung, H. K. S. R. R. S. S. U. D. A. A. A. F. U. P. I. R. M. P. A. P. U. R. Y. Y. (2023). *FullBook Keperawatan Holistik* (Ronald Watrianthos, Ed.). Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Peel, N. M., Hornby-Turner, Y. C., Osborne, S. R., Henderson, A., Hubbard, R. E., & Gray, L. C. (2021). Implementation and Evaluation of a Standardized Nurse-Administered Assessment of Functional and Psychosocial Issues for Patients in Acute Care. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 18(3), 161–169. <https://doi.org/10.1111/wvn.12490>

- Pesut, B., & Sawatzky, R. (2013). Spiritual Care in Nursing Practice. In *Journal of Holistic Nursing*.
- Ramdahani, T. K. (2025). Pengaruh Mutu Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Poli Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Nu'mang. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(4), 1730–1740.
- Searby, A., Burr, D., & Hutchinson, A. M. (2026). Stakeholder barriers and facilitators to mental health service integration: a qualitative study using the theoretical domains framework. *BMC Health Services Research*, 26(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-025-13818-y>

PROFIL PENULIS



Dhea Novita, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb., Lahir di Mataram, 9 November 1997. Lulus Sekolah Menengah Atas pada Tahun 2016. Lulus Diploma 4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram Tahun 2020. Lulus Magister Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang Tahun 2023. Saat ini sebagai Dosen dan aktif mengajar di STIKes Bhakti Husada Cikarang. Penulis memiliki ketertarikan di bidang Kebidanan dan aktif sebagai peneliti dan menulis artikel jurnal ilmiah di bidang Kebidanan. Keinginan mengembangkan Ilmu Kebidanan mendorong penulis untuk menulis buku. Kebidanan penulis juga ingin mewujudkan terbitnya buku-buku yang bermanfaat dan relevan dengan kebidanan dari hasil-hasil penelitian Kesehatan Reproduksi, Senam Untuk Wanita Menopause dan Gizi pada Wanita Menopause. Semoga buku-buku yang kami tulis bermanfaat bagi Dosen, Mahasiswa Kebidanan dan Masyarakat umum.

Email Penulis: deanovita957@gmail.com



Erwin Purwanto, S.Kep., Ners., M.Kep., lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1994. Pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis yaitu menyelesaikan jenjang Diploma III Jurusan Keperawatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar Tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Airlangga Tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan dengan konsentrasi Keperawatan Medikal Bedah di Universitas

Hasanuddin pada tahun 2022. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo dan tergabung dalam Departemen Keperawatan Medikal Bedah (KMB). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu publikasi jurnal ilmiah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: erwinpurwanto65@gmail.com

PROFIL PENULIS

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep. Lahir di Bojonegoro, 02 Desember 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan, lulus tahun 1991, selanjutnya melanjutkan pada jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2000, dan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 sebagai perawat pelaksana di rumah sakit, dan kemudian beralih sebagai staff dosen Diploma III Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Malang hingga sekarang menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang terdiri atas program D3, S1, S2 dan profesi Keperawatan serta jurusan kesehatan lainnya diantaranya Farmasi dan Fisioterapi. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Etik dan Hukum Keperawatan, komunikasi keperawatn dan Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan aktif dalam kegiatan kajian-kajian parenting dan perlindungan perempuan dan anak di tingkat universitas serta Malang raya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: alifatin@umm.ac.id. Motto: " Selalu Berpikiran Positif, Bahkan Dalam Situasi Tersulit.



Dewi Mey Lestanti Mukodri, SST., M.Keb., Penulis lahir di Bandung pada bulan Mei 1986. Ketertarikan penulis terhadap ilmu kebidanan dimulai pada tahun 2004 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke STIKes Bhakti Kencana Bandung dan berhasil lulus pada tahun 2007. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke DIV Bidan Pendidik dan berhasil menyelesaikan studi DIV Bidan Pendidik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya pada tahun 2008. Tahun 2015 penulis menyelesaikan studi S2 Kebidanan Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran Bandung. Penulis bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi DIII Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang. Saat ini penulis memiliki tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang. Penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah dan organisasi keprofesian yaitu IBI sebagai pengelola PD IBI Provinsi Kepulauan Riau di bidang Pendidikan. Sehari-harinya bekerja sebagai dosen pengampu mata kuliah Askeb Kehamilan, Konsep kebidanan, Askeb Neonatus bayi dan balita serta Gizi dalam Kesehatan Reproduksi. Selain itu penulis juga aktif dalam menulis jurnal, menjadi tim editor dan sebagai *Editor in Chief* pada salah satu jurnal di Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang, menjadi reviewer salah satu jurnal di Poltekkes Kemenkes lainnya serta aktif menulis buku ajar dan *book chapter*. Penulis telah mendapatkan sertifikat Kompetensi dari BNSP pada bidang Editor buku dengan kualifikasi penyuntingan naskah dan Bidang Penerbitan Ilmiah dengan kualifikasi Pengelola Penerbit Ilmiah. Email Penulis : dewimey@poltekkes-tanjungpinang.ac.id. Motto: "Live with purpose, serve with compassion, lead with knowledge"

PROFIL PENULIS



Dr. Atik Badi'ah, S.Pd, S.Kp, M.Kes., Lahir di Trenggalek, 30 Desember 1965. Bekerja sebagai dosen/Lektor Kepala di Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta mulai 1988 s.d sekarang. Lulus Akademi Perawat Dep Kes Yogyakarta 1987, Lulus IKIP PGRI Wates Bimbingan Konseling tahun 1994, Lulus S 1 Keperawatan PSIK FK UNPAD Bandung tahun 1997, Lulus S2 Kesehatan Ibu Anak FK UGM tahun 2002 dan Lulus S3 Promosi Kesehatan Pasca Sarjana UNS Surakarta tahun 2018.

Menjadi dosen berprestasi terbaik 1 Poltekkes Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2006, dosen berprestasi tingkat Nasional tahun 2006, dosen berprestasi terbaik 1 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2024 dan dosen berprestasi tingkat nasional Poltekkes kemenkes peringkat harapan 1 Tahun 2024. Mendapat penghargaan dari Presiden dan Menteri Kesehatan. Menjadi penguji eksternal Disertasi S3 Promosi Kesehatan UNS. Menjadi Asesor Beban Kinerja Dosen (BKD). Menjadi Vaksinator Covid 19, menjadi Yuri Podcast dan Yuri Poster. Menjadi Reviewer Internal Jurnal Caring Jurusan Keperawatan Poltekkes Yogyakarta, menjadi Reviewer Eksternal Jurnal Internasional Health Notion, Jurnal Internasional Open Access Macedonian Journal Of Medical Sciences Terindeks Scopus Q3, Jurnal Internasional Nursing Open, Jurnal Nasional Forikes Poltekkes Surabaya, Jurnal Nasional Surya Medika Stikes Surya Global Yogyakarta, Jurnal Nasional Health Sciences and Pharmacy Journal Stikes Surya Global Yogyakarta, Jurnal Nasional. Humanis Journal Of Community Empowerment Stikes Surya Global Yogyakarta, Journal Of Health And Cardiovascular Nursing Poltekkes Jakarta I dan Jurnal Nasional MIKKI Stikes Wira Husada Yogyakarta. Menjadi Reviewer Penelitian Eksternal Nasional, Reviewer Pengabdian Masyarakat nasional, Reviewer internal Penelitian dan reviewer internal pengabdian masyarakat tingkat Poltekkes Yogyakarta. Menjadi pembicara tingkat lokal dan nasional. Menjadi Afiliasi Reasearch Seameo Recfon. Melakukan berbagai penelitian tingkat Poltekkes, Nasional dan Internasional (Seameo Recfon) dan telah dipublikasikan dalam jurnal Internasional terindeks Scopus, jurnal nasional OJS dan Terakreditasi. Sudah menerbitkan beberapa buku Keperawatan. Sudah menulis 98 Chapter Kesehatan Dan Pendidikan

Email : atik.cahyo@yahoo.com

PROFIL PENULIS



Ns. Hanafi, M.Kep., asal Pontianak Lahir 28 Oktober 1997 Penulis menempuh Pendidikan tinggi pada S1 dan Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan Muhammadiyah Pontianak 2021 dan Pendidikan Megister Keperawatan di Institut Teknologi Dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat 2023. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan-Barat sejak tahun 2024 dan saat ini mengampu mata kulia konsep dasar dan dasar keperawatan Penulis dapat dihubungi melalui hanafi@ners.untan.ac.id. Motto: Manjadda wajadda

Sinopsis

Bunga rampai “**Pendekatan Holistik dan Humanistik dalam Pelayanan Kesehatan**” menghadirkan gagasan dan praktik pelayanan kesehatan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Di tengah layanan yang semakin berorientasi pada teknologi, efisiensi, dan target klinis, buku ini menegaskan kembali bahwa kesehatan tidak semata-mata bebas dari penyakit, melainkan kondisi utuh yang mencakup aspek **biologis, psikologis, sosial, dan spiritual**. Karena itu, pendekatan holistik dan humanistik menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih bermakna, berempati, dan berkeadilan.

Pembahasan dimulai dari **konsep pelayanan kesehatan holistik dan humanistik** sebagai fondasi berpikir dan bertindak dalam pelayanan. Selanjutnya, buku ini memperdalam **pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual** yang membantu tenaga kesehatan memahami faktor penyebab, risiko, serta kebutuhan pasien secara lebih menyeluruh. Implementasinya ditunjukkan melalui kajian **asuhan keperawatan holistik dalam berbagai tatanan pelayanan**, baik di rumah sakit, layanan primer, komunitas, hingga perawatan berkelanjutan, dengan penekanan pada kolaborasi dan kontinuitas asuhan.

Tidak hanya itu, buku ini juga mengangkat peran penting **pendekatan gizi holistik** dalam pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, yang menempatkan nutrisi sebagai bagian dari strategi terapi, pencegahan komplikasi, dan peningkatan kualitas hidup. Dimensi relasional dalam pelayanan diperkuat melalui topik **komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien**, sebagai jembatan membangun kepercayaan, meningkatkan kepatuhan, serta mendorong pengambilan keputusan bersama yang lebih etis dan manusiawi. Nilai-nilai inti profesi ditegaskan lewat pembahasan **etika, empati, dan nilai kemanusiaan**, yang menjadi pedoman agar praktik pelayanan tetap menghormati martabat pasien, menjaga kerahasiaan, serta sensitif terhadap latar belakang budaya dan kondisi psikososial.

Sebagai penutup, bunga rampai ini mengulas **tantangan penerapan pelayanan holistik di fasilitas kesehatan**, mulai dari keterbatasan sumber daya, beban kerja, budaya organisasi, hingga kebutuhan peningkatan kompetensi dan dukungan sistem. Dengan menghadirkan perspektif konseptual sekaligus praktis, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, tenaga kesehatan, dan pengelola layanan untuk memperkuat pelayanan yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga **memanusiakan**.

Bunga rampai “Pendekatan Holistik dan Humanistik dalam Pelayanan Kesehatan” menghadirkan gagasan dan praktik pelayanan kesehatan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Di tengah layanan yang semakin berorientasi pada teknologi, efisiensi, dan target klinis, buku ini menegaskan kembali bahwa kesehatan tidak semata-mata bebas dari penyakit, melainkan kondisi utuh yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Karena itu, pendekatan holistik dan humanistik menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih bermakna, berempati, dan berkeadilan.

Pembahasan dimulai dari konsep pelayanan kesehatan holistik dan humanistik sebagai fondasi berpikir dan bertindak dalam pelayanan. Selanjutnya, buku ini memperdalam pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual yang membantu tenaga kesehatan memahami faktor penyebab, risiko, serta kebutuhan pasien secara lebih menyeluruh. Implementasinya ditunjukkan melalui kajian asuhan keperawatan holistik dalam berbagai tatanan pelayanan, baik di rumah sakit, layanan primer, komunitas, hingga perawatan berkelanjutan, dengan penekanan pada kolaborasi dan kontinuitas asuhan.

Tidak hanya itu, buku ini juga mengangkat peran penting pendekatan gizi holistik dalam pemeliharaan dan pemulihan kesehatan, yang menempatkan nutrisi sebagai bagian dari strategi terapi, pencegahan komplikasi, dan peningkatan kualitas hidup. Dimensi relasional dalam pelayanan diperkuat melalui topik komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien, sebagai jembatan membangun kepercayaan, meningkatkan kepatuhan, serta mendorong pengambilan keputusan bersama yang lebih etis dan manusiawi. Nilai-nilai inti profesi ditegaskan lewat pembahasan etika, empati, dan nilai kemanusiaan, yang menjadi pedoman agar praktik pelayanan tetap menghormati martabat pasien, menjaga kerahasiaan, serta sensitif terhadap latar belakang budaya dan kondisi psikososial.

Sebagai penutup, bunga rampai ini mengulas tantangan penerapan pelayanan holistik di fasilitas kesehatan, mulai dari keterbatasan sumber daya, beban kerja, budaya organisasi, hingga kebutuhan peningkatan kompetensi dan dukungan sistem. Dengan menghadirkan perspektif konseptual sekaligus praktis, buku ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, tenaga kesehatan, dan pengelola layanan untuk memperkuat pelayanan yang tidak hanya menyembuhkan, tetapi juga memanusiakan.

ISBN 978-634-7556-80-6 (PDF)



9

786347

556806

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

